UPEC
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

INSTITUT
DE FORMATION
EN ERGOTHÉRAPIE

ERGOTHÉRAPIE

Année universitaire 2022 – 2023

Mai 2023

La participation occupationnelle de l'enfant présentant des troubles du spectre autistique sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile

Présenté par : **Garance HAUCK**

Numéro étudiant : **32015175**

Dirigé par : **Madame Pauline DESCAMPS**

Promotion 2020 - 2023

ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR

L'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'État d'ergothérapeute précise que l'Unité d'intégration UE 6.5 Semestre 6 intitulée « Évaluation de la pratique professionnelle et recherche » a pour modalité d'évaluation un mémoire d'initiation à la recherche : écrit et argumentation orale.

L'étudiante réalise, après utilisation du traitement de textes, un mémoire d'au moins 40 pages sans excéder 65 pages, hors annexes.

Ce mémoire doit permettre à l'étudiante de montrer ses capacités à utiliser des outils d'expertise et de recherche, ainsi que ses capacités à synthétiser et rendre compte des résultats de son travail.

Le mémoire peut être :

- Un travail de recherche fondamentale relatif à la pratique de l'ergothérapie.
- Un travail de recherche appliquée à partir de l'observation d'un ou plusieurs cas cliniques.

L'étudiante est aidée dans sa recherche et dans son travail d'écriture par un maître de mémoire.

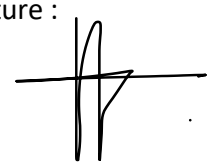
Le sujet et le maître de mémoire sont choisis par l'étudiant(e) en accord avec le directeur de l'institut.

Je, soussignée, HAUCK Garance étudiante en 3ème année en institut de formation en ergothérapie, m'engage sur l'honneur à mener ce travail écrit dans les règles édictées.

Je reconnais avoir été informée des sanctions et des risques de poursuites pénales qui pourraient être engagées à mon encontre en cas de fraude, et/ou de plagiat avéré.

A Créteil, le 16/05/2023

Signature :



Note aux lecteurs :

« Ce mémoire est réalisé dans le cadre d'une scolarité. Il ne peut faire l'objet d'une publication que sous la responsabilité de son auteur et de l'Institut de formation concerné. »

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier ma maître de mémoire, Madame Pauline DESCAMPS pour ses conseils, son investissement et son accompagnement tout au long de la réalisation de ce mémoire de recherche.

Je souhaite remercier également toute l'équipe pédagogique de l'institut de formation en ergothérapie de Créteil. Notamment mes référentes en méthodologie, Madame Hélène HAVIN et Madame Amandine IBANEZ, ainsi que le bureau L3, Madame Anne REGNAQ et Monsieur Simon GADEYNE, pour leurs conseils et leur soutien tout au long de l'année.

J'aimerais ensuite remercier les trois ergothérapeutes qui se sont rendues disponibles pour participer aux entretiens. Leurs réponses et leur bienveillance m'ont permis de réaliser au mieux mon étude de recherche.

Pour finir, je remercie mes camarades de promotions et ma famille pour leur écoute, leur soutien et leur encouragement durant ces trois années d'études et l'écriture du mémoire.

« L'aveugle parle mais ne voit pas.

Le sourd parle mais n'entend pas.

L'autiste parle mais ne perçoit pas.

Les trois tentent quand même de communiquer. »

Brigitte Harrisson

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ANFE : Association Nationale Française des Ergothérapeutes

AQNP : Association Québécoise des NeuroPsychologues

AQRP : Association Québécoise de la Réadaptation Psychosociale

CAOT : Canadian Association Occupational Therapists

CHUSJ : Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine

CRAIF : Centre de Ressources Autisme Ile de France

DSM-V : Diagnostique et Statistique des troubles Mentaux

HAS : Haute Autorité de Santé

IFE : Institut de Formation d'Ergothérapie

IME : Institut Médico-Éducatif

INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale

MCRO : Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel

MHAVIE : Mesure des Habitudes de VIE

MOH : Modèle de l'Occupation Humaine

SESSAD : Service d'éducation Spéciale et de Soins À Domicile

TSA : Trouble du Spectre Autistique

Table des matières

Introduction 1

Situation d'appel 2

I. Les troubles du spectre autistique 3

1. Définition 3

2. Épidémiologie et étiologie 4

3. Signes cliniques 5

Communication et langage 5
Émotions et comportement 6
Interactions sociales 6
Cognition 7
Sensoriel et moteur 7

4. Les troubles associés et comorbidités 8

5. Établissements et services d'accompagnement 10

II. Ergothérapie 11

1. Généralités 11

2. Rôle de l'ergothérapeute auprès des enfants ayant des TSA sévères 11

Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 12
Cabinet libéral 13

3. La prise en soin pluridisciplinaire 13

4. Le lien avec la famille 14

III. La participation à travers le Modèle de l'Occupation Humaine 16

1. L'Être occupationnel 16

Habituation 16
Capacité de rendement 17

2. L'Agir occupationnel 18

Occupation 18
La participation occupationnelle 19

3. L'environnement 20

Physique 20
Social 21

IV. Problématique et hypothèses 22

V. Méthodologie de l'enquête 23

1. Objectifs de l'enquête 23

2. Population ciblée 23

3. Choix de l'outil d'investigation 24

4. L'échantillonnage 25

VI. Résultats et analyse 27

1. Thème 1 : Profil des ergothérapeutes interrogées 27

2. Thème 2 : La prise en soin pluridisciplinaire et le lien avec la famille 28

Sous thème : L'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères 28
Sous thème : La collaboration avec les parents 31

3. Thème 3 : La participation occupationnelle chez l'enfant ayant des TSA sévères 32
Sous thème : Définition de la participation occupationnelle 32
Sous thème : L'occupation la plus impactée 33

4. Thème 4 : La participation occupationnelle dans les activités de vie quotidienne 34
Sous thème : Les évaluations 34
Sous thème : Les moyens et les outils 36

VII. Discussion 38

1. Confrontation entre les recherches théoriques et les éléments du terrain 38

2. Validation de l'hypothèse de recherche 39

3. Limites et apports de mon étude de recherche 40
Limites 40
Apports 41

Conclusion 42

Bibliographie 44

Sommaire tableaux 51

Sommaire nuages de mots 51

Sommaire annexes 51

Introduction

Les troubles du neuro-développement, dont font partie les troubles du spectre autistique (TSA), touchent 5% de la population, soit environ 35 000 naissances par an, selon la Haute Autorité de Santé. Les TSA représentent eux, entre 0.9% et 1.2% des naissances, 1% de la population générale vit avec des troubles du spectre autistique (Handicap.gouv, 2023)

Les troubles du spectre autistique sont un enjeu et une priorité de santé publique. De nombreuses actions sur le plan nationale sont menées concernant les TSA.

En effet, depuis 2005 en France quatre « plan autisme » se sont succédés, le but étant d'améliorer l'accompagnement des personnes vivant avec ses troubles et de leur famille. Actuellement le dernier et le quatrième « plan autisme » est celui de 2018-2022, il vise à essayer de répondre au mieux aux besoins des individus ayant des TSA, à chaque étape de leur vie et dans leurs différents lieux de vie tels que l'école, les loisirs, l'emploi, le logement. Une nouvelle « stratégie nationale autisme 2023-2027 » a été lancée, avec 6 nouveaux grands axes. (Inserm, 2018).

Les ergothérapeutes ont un grand rôle à jouer dans la prise en soin des personnes ayant des troubles du spectre autistique. Il est vrai que les évaluations et les interventions réalisées par ces professionnels de santé permettent d'apporter des informations à la personne sur le domaine de la santé physique, du traitement de l'information sensorielle ainsi que de la santé sociale et émotionnelle en prenant en compte ses environnements (CAOT, 2017).

Lors de ce mémoire d'initiation à la recherche, nous aborderons dans un premier temps une partie théorique qui consistera à définir les troubles du spectre autistique ainsi que le parcours de vie et de soins des personnes vivant avec ces troubles. Puis nous évoquerons la place de l'ergothérapeute auprès de cette population. Dans un second temps, une partie conceptuelle sera réalisée, ayant pour vocation de définir les termes principaux du sujet de cette étude, s'en suivra l'énoncé de la problématique et de l'hypothèse. Les méthodes utilisées pour l'enquête, ainsi que les résultats et analyses des entretiens effectués seront décrits dans un troisième temps. Enfin, le dernier temps de ce mémoire sera consacré à l'évocation des limites et des apports de cette étude de recherche lors d'une discussion et permettra de conclure.

Situation d'appel

Les troubles du spectre autistique m'intéressent particulièrement depuis plusieurs années. C'est un fonctionnement complexe, dont nous entendons souvent parler sans réellement savoir ce que ça signifie, quelles sont les difficultés rencontrées par les individus vivant avec ces troubles.

J'ai lu de nombreux ouvrages traitant le sujet des troubles du spectre autistique, comme : *Les livres de Josef Schovanec ; Louis pas à pas de Francis et Gersende Perrin.* J'ai également regardé de nombreux films et séries, comme : *Astrid et Raphaëlle ; Rain Man ; Hors normes ; Forrest Gump ; Le huitième jour ; Monsieur je sais tout.* Ainsi que de nombreuses interviews de parents d'enfants ayant des troubles du spectre autistique, comme Églantine Éméyé, qui m'ont donné envie d'approfondir davantage mes recherches sur ce fonctionnement.

La thématique de mon mémoire m'est venue après avoir visité l'habitat inclusif *« Les Amalias »* de l'association *« Ensemble et différents »*. Cet habitat se situe dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et a été inauguré en novembre 2021. Il se compose de trois bâtiments, dans l'un d'eux trois jeunes adultes et amis vivent en colocation. Ils présentent un polyhandicap, dont des troubles du spectre autistique sévères. Ces trois personnes sont accompagnées au quotidien (7j/7 ; 24h/24) par une équipe pluridisciplinaire organisée en gouvernance partagée, car ils sont dépendants dans toutes leurs activités de vie quotidienne (différents, 2020).

Cet habitat inclusif a été créé par les parents d'une des colocataires. Le domicile familial n'était pas adapté à ses besoins, ses particularités et ses troubles, qui sont très personnels à chaque personne présentant des troubles du spectre autistique. Ses parents, étant épuisés et n'arrivant pas à trouver de solution au domicile, ont pris la décision de mettre leur fille dans une institution. Ce qui permettait qu'elle soit dans un cadre médical, qu'ils pensaient peut-être plus adapté pour elle. Finalement, l'institution ne s'est pas révélée être le lieu le plus sécurisant pour cette jeune fille, ses crises étaient encore plus intenses qu'au domicile. Leur fille a actuellement 25 ans, elle a été en institution jusqu'à ses 10 ans mais, en grandissant, elle ne voulait pas avoir à y retourner un jour. C'est à la suite de ces différentes étapes et problématiques rencontrées qu'ils ont eu l'initiative de créer un habitat inclusif tel que les Amalias.

Après avoir rencontré ces personnes et avoir entendu leur histoire, je me suis alors demandé comment, en tant qu'ergothérapeute, il serait possible d'améliorer le quotidien de la personne présentant des troubles du spectre autistique sévères au domicile ?

I. Les troubles du spectre autistique

1. Définition

Selon le DSM-V, le *« trouble du spectre autistique (TSA) »* est un est un trouble du neurodéveloppement qui apparaît dès le plus jeune âge - apparition des premiers signes avant 3 ans - et qui évolue tout au long de la vie de la personne. Il est caractérisé par *« des déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans des contextes variés »* ainsi qu'un *« caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. »* (DSM-V, 2013). Chaque individu se situe à un niveau différent du spectre, qui peut varier d'un trouble léger à un trouble sévère, c'est-à-dire avec une atteinte plus ou moins forte. C'est en partie pour cela qu'une personne ayant un trouble du spectre autistique ne présentera pas forcément les mêmes caractéristiques qu'une autre (Lebaut, 2020).

Les deux domaines évoqués précédemment, dans lesquels nous retrouvons les caractéristiques des TSA, forment la dyade autistique. Les personnes ayant des TSA semblent souvent isolées dans leur monde intérieur et peuvent présenter des réactions sensorielles particulières (Inserm, 2018).

Les déficits au niveau de la communication et des interactions sociales peuvent provoquer des déficiences notables dans la vie quotidienne de la personne. En effet, l'individu peut donner des réponses atypiques ou non adaptées aux normes sociétales, ainsi que montrer un intérêt diminué pour interagir avec autrui, ce qui va rendre difficile l'ouverture sociale.

Les comportements répétitifs et les intérêts restreints chez la personne ayant des TSA peuvent provoquer une inflexibilité du comportement. Ce qui va amener à des difficultés dans un ou plusieurs contextes si aucun soutien n'est mis en place. De plus, cela peut provoquer des problèmes d'organisation et de planification qui entravent l'indépendance de l'individu.

Il va alors être important de mettre en place une aide pour pallier ces difficultés, en fonction du degré de sévérité du TSA chez la personne. Selon le DSM-V, il existe trois degrés de sévérité sur le spectre autistique :

- Le niveau 1 : qui nécessite un léger soutien,
- Le niveau 2 : qui nécessite un soutien plus important,

- Le niveau 3 : qui nécessite un soutien très important. Ce niveau est celui sur lequel nous allons nous attarder au vu de la thématique. Nous allons retrouver différentes particularités comme : un manque très visible d'aptitudes à la communication verbale et non verbale ; une difficulté à modifier ses comportements ; une problématique extrême à faire face à des changements inattendus dans la routine ou l'environnement ; une grande détresse ou une difficulté à changer d'orientation ou de sujet d'attention (Labbé, 2021, [1]).

Auparavant, une distinction était faite entre ces trois niveaux et le syndrome d'Asperger, qui se nomme actuellement l'autisme de haut niveau et qui s'inscrit simplement dans les troubles du spectre autistique. Une distinction peut quand même être faite puisque les personnes ayant ce trouble présentent les mêmes manifestations que les autres mais elles n'ont ni retard de langage, ni déficit intellectuel (Crocq, Guelfi, Boyer & Pull, 2015).

2. Épidémiologie et étiologie

En France, 700 000 personnes sont concernées par les troubles du spectre autistique (TSA), dont 100 000 ayant moins de 20 ans. Actuellement, 8 000 enfants ayant des TSA naîtraient tous les ans, soit environ une personne sur 100 (Inserm, 2018). Le nombre d'enfants ayant des TSA n'a pas réellement augmenté ces dernières années, c'est le nombre d'enfants ayant reçu un diagnostic qui s'est accru de façon marquée dans l'ensemble des pays industrialisés durant ces dernières décennies.

Dans le monde entier, les causes précises des troubles du spectre autistique restent inconnues. Toutefois, plusieurs études étiologiques prouvent qu'il existe une origine génétique prédominante aux troubles. Ces troubles, qui pourraient venir d'un syndrome génétique, sont alors fortement héréditaires. En effet, selon John Constantino, il y aurait 10,9% de risques que, dans une famille ayant un enfant avec des TSA, un autre enfant de la fratrie présente également ces troubles (Constantino, 2000). Cependant, malgré le nombre de recherches dans ce domaine, seulement 6 à 15% des personnes présentant des troubles du spectre autistique ont reçu un diagnostic génétique (HAS, 2018, [1]).

En plus du facteur génétique, le facteur démographique serait également un des facteurs de risques connus des troubles du spectre autistique. D'après le DSM-V, l'autisme infantile touche quatre fois plus de garçons que de filles. Il se pourrait que les filles soient davantage sous-diagnostiquées que les garçons en raison d'une présentation clinique atténuée des difficultés sociales et de communication (HAS, 2018, [1]).

Les recherches qui ont été faites sur les facteurs de risque des troubles du spectre autistique mettent en lumière une origine multifactorielle (HAS, 2018, [2]).

3. Signes cliniques

Précédemment, nous avons évoqué les domaines dans lesquels la personne ayant des troubles du spectre autistique peut se retrouver en difficulté. À présent, nous allons les détailler davantage afin de nous rendre compte de l'impact que cela peut avoir dans le quotidien de l'individu.

Communication et langage

Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe trois formes de langage. Il peut être verbal - il est alors caractérisé par l'utilisation de mots ; para-verbal - ici nous sommes plutôt sur la voix, l'intonation, le rythme ; ou non verbal – nous faisons alors appel au corps, à notre gestuelle ainsi qu'aux expressions de notre visage. La communication est définie comme un échange entre deux personnes qui se fait grâce au langage (Larousse, 2020, [1]).

Chez les individus avec des troubles du spectre autistique les trois formes de langage et de communication peuvent être altérées.

Généralement, les personnes ayant des TSA connaissent le vocabulaire, les bons mots. Néanmoins, elles les utilisent sans en comprendre la signification, ce qui fait que les mots peuvent ne pas être cohérents avec le contexte, le sujet. Cela se retrouve dans l'écholalie : dans ce cas, la personne - particulièrement l'enfant avec des TSA - va répéter un mot qu'elle a entendu, sans en connaître le sens (Rogé, 2008).

Les personnes ayant des TSA ont souvent une intonation monotone : la voix est très rarement associée à l'émotion que l'individu ressent. Qu'elles soient tristes, joyeuses ou en colère, elles peuvent parler de la même manière. Les difficultés sont aussi présentes dans la gestion du volume de la voix : ainsi, dans un lieu public où il est préférable de parler doucement pour ne pas déranger les autres, la personne avec des TSA peut parler très fort car elle n'a pas conscience qu'elle peut déranger (Rogé, 2008).

De plus, les expressions du visage, ainsi que la gestuelle ou encore la posture de la personne peuvent être inadaptées à la situation. Elles peuvent également être altérées, exagérées ou inexistantes. L'adaptation de ce langage non verbal à une situation ou à un environnement donné demande un effort très important et conscient à la personne ayant des TSA, tandis que, pour un neurotypique, cela est inné (Rogé, 2008).

Émotions et comportement

Les personnes ayant des troubles du spectre autistique rencontrent des difficultés dans l'interprétation des émotions, que ce soit les leurs ou celles de leur entourage. Ce qui est vrai pour les neurotypiques ne l'est pas forcément pour les individus avec des TSA. En effet, le sourire et les pleurs ne sont pas toujours pour eux synonymes de joie et de tristesse. Cela fait que leur comportement, leur réaction, peuvent être en discordance avec la situation (Harrisson & St-Charles, 2018).

Elles ont aussi du mal à reconnaître, contrôler et exprimer leurs propres émotions. Pour exprimer la douleur par exemple, la personne ne va pas forcément l'exprimer par des mots ou des pleurs. Elle peut plutôt se cogner la tête contre les murs ou encore faire des crises de colère, par frustration de ne pas réussir à communiquer ce qu'elle ressent. Ces moyens d'expression, très différents de ce que nous avons l'habitude de voir dans notre société, font que nous pouvons mettre beaucoup de temps à comprendre ce qui ne va pas chez l'individu, et donc être parfois confrontés à des situations critiques (Harrisson & St-Charles, 2018).

Interactions sociales

Les difficultés de communication, de langage et de reconnaissance des émotions évoquées précédemment peuvent fortement freiner les interactions sociales de la personne TSA.

En effet, pour les personnes ayant des troubles du spectre autistique, le comportement social est plus complexe à déchiffrer que la communication. Jérôme Bruner, un psychologue américain, parle de *« symboles sociaux en mouvement perpétuel »,* car les situations sociales rencontrées par la personne ne sont jamais identiques. C'est ce changement quotidien qui effraye l'individu avec des TSA, alors que lui a besoin d'avoir des rituels bien précis.

La problématique pour ces personnes est de comprendre la signification de l'information sociale reçue. Ce qui va impacter les interactions sociales de la personne ayant des TSA avec les individus qui l'entourent (Peeters, 2014).

Selon Baron Cohen, un psychologue et psychiatre anglais, le déficit social est de nature chronique. Il change et évolue durant le développement de l'enfant, ainsi que selon les situations. Cependant, il persiste tout au long de la vie de la personne comme une incapacité à participer à des interactions sociales dyadiques et réciproques (Thommen, 2014).

Cognition

La capacité cognitive est différente chez toutes les personnes présentant un trouble du spectre autistique. Pour certaines, celle-ci peut être extrêmement élevée, comme chez les individus ayant des TSA de haut niveau, qui ne présentent pas forcément de déficit intellectuel. Selon des études, la proportion de personnes avec des TSA présentant une déficience intellectuelle varie de 13% à 84% (Gauvreau, 2019). Néanmoins, elles peuvent être souvent confrontées à des difficultés au niveau du traitement des informations, ce qui va rendre l'autonomie dans les activités de vie quotidienne complexe (Labbé, 2021, [5]).

La cognition a différents rôles comme mémoriser, parler et bouger, qui sont les fonctions cognitives. Ces fonctions cognitives représentent les différentes facettes de la pensée humaine, qui vont chacune jouer un rôle et nous permettre de réaliser des actions. Nous allons retrouver dans les fonctions cognitives la perception – qui est la capacité à reconnaitre et à identifier les choses ; l'attention – qui correspond au processus de sélection d'un stimulus extérieur ou intérieur ; la mémoire – qui permet d'enregistrer et retrouver des informations, et existe sous trois formes, à court terme, de travail et à long terme. Il y a également la motricité – qui correspond aux actions motrices que nous coordonnons dans un but intentionnel ; le langage – qui permet de communiquer avec autrui ; ainsi que les fonctions exécutives – qui, elles, permettent notre raisonnement (AQNP, 2023).

Un déficit de l'attention et de la concentration est aussi très courant chez l'individu ayant des troubles du spectre autistique. Mais, une fois de plus, certains peuvent avoir une attention et une concentration plus élevées que les autres (Labbé, 2021, [5]).

Sensoriel et moteur

La personne avec un TSA a très souvent des particularités sensorielles. Il est possible que l'individu soit hypersensible, hyposensible ou qu'il ait simplement une sensorialité différente que celle des autres individus. Les troubles sensoriels peuvent se ressentir au niveau de différents sens de la personne : auditif, visuel, tactile, olfactif, proprioceptif, c'est-à-dire de ressentir les mouvements de son corps, et vestibulaire, qui correspond à notre équilibre.

L'hypersensibilité est un état psychologique dans lequel la personne exprime une sensibilité plus forte que les autres face à un environnement (Larousse, 2020, [2]). Cette sensibilité extrême peut se développer sur un ou plusieurs de nos cinq sens, comme l'hypersensibilité alimentaire qui va provoquer une sélectivité des aliments très importante.

Cette déficience de perception sensorielle entraîne des comportements inadaptés chez la personne ayant des troubles du spectre autistique (Labbé, 2021, [4]).

L'hyposensibilité, moins courante, se traduit par une sensibilité réduite, voire une insensibilité complète aux différents stimuli sensoriels de son environnement (Larousse, 2020, [3]). Ce phénomène s'explique par un dysfonctionnement du traitement des informations sensorielles perçues par le cerveau.

Par exemple, un individu hyposensible ne va pas sentir la douleur s'il se brûle. Cette déficience de perception sensorielle peut donc être dangereuse pour la santé de la personne ayant des TSA (Chapel, 2019, [2]).

Comme énoncé précédemment, certains individus peuvent avoir des troubles de la sensorialité sans qu'ils soient hypersensibles ou hyposensibles et sans que ce trouble ne se retrouve dans tous les sens.

Aux troubles sensoriels sont souvent associés les particularités motrices que nous retrouvons fréquemment chez l'individu ayant des TSA, de l'enfance à l'âge adulte. Ces particularités se retrouvent à différents niveaux. Au niveau de la motricité globale, la personne va avoir de grandes difficultés d'acquisition des mouvements alternatifs ou nécessitant une dissociation des deux hémicorps. Également dans les activités qui demandent de la coordination et de la synchronisation membres supérieurs/membres inférieurs. La déficience au niveau de la motricité globale va entraîner un retard dans les apprentissages d'activités comme le vélo, la natation. Mais elle peut aussi poser problème dans la conscience du corps, l'équilibre et le contrôle moteur. Pour ce qui est de la motricité fine, les activités minutieuses et précises comme l'apprentissage de l'écriture, du dessin et de l'habillage, vont être plus complexes à réaliser (Rogé, 2008).

4. Les troubles associés et comorbidités

Les troubles du spectre autistique sont très souvent associés à d'autres troubles tels que les troubles des apprentissages, des fonctions exécutives, fonctionnelles et cognitives.

Les troubles des apprentissages peuvent toucher plusieurs domaines : la dyslexie, qui est un trouble de la capacité à lire ou une difficulté à reconnaître un langage écrit ; la dysorthographie, qui se définit par un trouble de l'acquisition de l'orthographe, des difficultés à respecter l'orthographe d'un mot, à recopier un texte, à accorder les verbes ainsi qu'à organiser ses phrases ; la dyscalculie, lorsque

la personne se retrouve en difficulté pour lire les chiffres, écrire des nombres, comprendre le sens d'un nombre ; la dysgraphie : dans ce cas, l'individu parvient difficilement à organiser et coordonner son écriture, ce qui rend la lecture peu compréhensible ; la dysphasie, qui se traduit par un déficit limité au niveau du langage : dans ce cas, l'expression, la compréhension et l'organisation grammaticale de la phrase peuvent être altérées ; enfin, la dyspraxie, qui est un trouble de la planification des gestes volontaires et qui peut entraîner des difficultés à progresser sur le plan moteur. (Le Robert, 2020).

Ces troubles vont avoir un impact dans la vie quotidienne de la personne. Des déficits dans la réalisation de certaines activités de la vie quotidienne peuvent apparaître, comme lorsque l'individu souhaite faire ses lacets, mettre le couvert ou encore se laver les dents (Pouhet, 2016).

Le trouble des fonctions exécutives est très souvent présent chez les personnes ayant des TSA. Les fonctions exécutives correspondent au contrôle que l'individu exerce sur ses comportements pour organiser une activité au quotidien. Elles font partie des fonctions cognitives.
Elles regroupent l'inhibition, qui est la capacité de supprimer l'expression, ou la préparation de l'information qui perturberait le bon achèvement de l'objectif souhaité. Mais aussi la flexibilité mentale, qui permet de s'ajuster aux changements, de percevoir les différentes facettes d'une situation et qui intervient dans la résolution de problèmes. Ou encore, la mémoire de travail, qui favorise le maintien actif et la manipulation de l'information dans la mémoire, dans le but de réaliser une tâche qui dure dans le temps. Ainsi que la planification, qui est une fonction permettant d'organiser et d'établir l'ordre des étapes à suivre dans le temps pour atteindre un but. Ce processus de contrôle permet de s'adapter à des situations nouvelles, en mettant en place un ajustement comportemental, une capacité à se détacher de nos routines. Un trouble présent à ce niveau va perturber les activités de vie quotidienne de la personne et l'empêcher de s'intégrer facilement à son environnement (Perrin, 2013).

Les personnes ayant des TSA peuvent également souffrir d'épilepsie, qui se manifeste surtout au moment de l'adolescence. L'association entre les troubles du spectre autistique et l'épilepsie est à présent clairement établie. Selon des études, la prévalence de l'épilepsie chez les personnes ayant des TSA se situe entre 5 et 40%, les taux sont nettement plus élevés que ceux observés dans la population générale (0.5 à 1%) (Canitano, 2007). Cette prévalence varie en fonction du sous-type de trouble envahissant associé aux TSA.

Le déficit intellectuel, les troubles structurels du langage, anxieux-dépressif, du sommeil et digestifs ne sont pas des caractéristiques spécifiques des TSA, ni des troubles associés mais plutôt des

comorbidités, c'est-à-dire des associations de deux pathologies, psychiques ou physiques, par ailleurs fréquemment observées dans la population.

5. Établissements et services d'accompagnement

Depuis les années 1990, la situation des troubles du spectre autistique en France est présentée comme complexe à cause de l'augmentation des diagnostics de TSA, de l'hétérogénéité des cas et donc du manque de structures adaptées aux besoins divers (Ratel, 2012). Des milliers d'enfants et d'adultes avec des troubles du spectre autistique se retrouvent dans des centres situés en Belgique, faute de place dans les institutions françaises (Vincent, 2012). Les structures accueillent actuellement en priorité les cas de TSA les moins sévères. Cette priorité axée sur les TSA légers engendre une détérioration de la situation puisque les cas les plus complexes et sévères se retrouvent le plus souvent sans solution. Ainsi, les individus ayant les troubles les plus importants rencontrent de nombreuses difficultés dans leur parcours et au niveau de leur qualité de vie (Chamak & Bonniau, 2012).

Néanmoins, il existe quand même en France des structures pouvant accueillir et accompagner les personnes ayant des troubles du spectre autistique sévères. J'ai choisi de m'intéresser à l'intervention de l'ergothérapeute auprès de cette population, plus particulièrement auprès des enfants ayant des TSA sévères. Je vais alors me focaliser seulement sur les deux structures suivantes : le Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) et le cabinet libéral en ergothérapie, car ces professionnels accompagnent des enfants et peuvent intervenir au domicile, ce qui rejoint ma thématique.

Dans les SESSAD spécialisés dans l'accompagnement des enfants avec des TSA, âgés entre 0 et 20 ans, la prise en soin est personnalisée et adaptée au fonctionnement autistique. Les missions de ces structures sont orientées vers la socialisation et la scolarisation de l'individu ainsi que vers la recherche d'autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. Les professionnels interviennent dans et hors les murs, au cœur de la vie de l'enfant, en collaboration entre eux et avec la famille. Ce sont les professionnels qui se déplacent à l'école, au domicile ou dans les lieux de loisirs de l'enfant (CRAIF, 2018).

Les cabinets libéraux peuvent accompagner les enfants avec des TSA sévères. De manière plus générale, les professions libérales sont des activités d'un travailleur non salarié, indépendant. L'activité est soumise à la seule responsabilité du travailleur, il exerce dans l'intérêt d'un client ou d'un public (Service public, 2023). Le plus souvent, les professionnels libéraux reçoivent des clients au cabinet,

mais ils peuvent aussi se déplacer dans les lieux de vie de l'enfant (domicile, école…). Le fait d'intervenir au domicile fait que le professionnel va être au plus proche du quotidien du client et de son entourage, ce qui permet une meilleure collaboration. Généralement, les professionnels libéraux travaillent seuls dans leur cabinet, ce qui ne permet pas un accompagnement pluridisciplinaire comme dans les SESSAD. Si c'est le cas, il va alors être important que les différents professionnels suivant un même client entrent en relation afin de favoriser une meilleure prise en soin, surtout chez l'enfant ayant des TSA. Il existe aussi des cabinets de groupe, ce qui facilite le lien entre eux (Ameli, 2022).

II. Ergothérapie

1. Généralités

L'étymologie *« d'ergothérapie »* provient du mot grec *« ergon »,* qui signifie l'action, accolé au mot grec également *« therapia »,* qui signifie soin. L'ergothérapie c'est donc le soin par l'action, par l'activité.

Le métier d'ergothérapeute se développe en Europe au cours du 20ème siècle. En 1961, une association, qui rassemble des ergothérapeutes exerçant en France, a été créée, c'est l'Association Nationale Française d'Ergothérapie (ANFE, 2022).

Selon l'ANFE : « *l'ergothérapeute est un professionnel de santé, exerçant dans les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux (…). Spécialiste du rapport entre l'activité (ou occupation en lien avec la terminologie internationale désignant l'ergothérapie) et la santé, il mène des actions d'une part pour prévenir et modifier les activités délétères pour la santé, et d'autre part pour assurer l'accès des individus aux occupations qu'ils veulent ou doivent faire et rendre possible leur accomplissement de façon sécurisée, autonome, indépendante et efficace*. » (ANFE, 2022).

2. Rôle de l'ergothérapeute auprès des enfants ayant des TSA sévères

La plupart du temps, l'ergothérapeute commence son intervention auprès des enfants ayant des troubles du spectre autistique sévères au moment où le diagnostic est posé.

Le rôle de l'ergothérapeute auprès de cette population consiste, entre autres, à évaluer les habiletés, les forces et les intérêts particuliers de la personne. Ainsi que les difficultés liées aux activités de la vie quotidienne au sein de la collectivité, au domicile et au niveau scolaire, qui vont restreindre sa participation occupationnelle (Autism Ontario, 2011). L'objectif principal est de permettre à la personne de maintenir, récupérer ou acquérir une meilleure autonomie dans tous ses lieux de vie (Chapel, 2019, [1]).

Pour cela, l'ergothérapeute utilise différentes méthodes d'évaluation. Les évaluations initiales peuvent être des entretiens avec les parents ou les responsables légaux de l'enfant et le jeune ; ou encore des mises en situation écologiques. Il va souvent se rendre dans les lieux de vie de l'enfant (domicile, école, loisirs), afin de voir comment l'enfant se comporte, à quel endroit il rencontre des difficultés (Autism Ontario, 2011).

À la suite des évaluations, l'ergothérapeute peut établir un Profil Sensoriel de l'enfant, qui lui permettra de déterminer les adaptations nécessaires de l'environnement afin qu'elles répondent à ses besoins sensoriels et comportementaux. Le Profil Sensoriel est un questionnaire que les parents ou les responsables légaux de l'enfant doivent remplir à partir des observations qu'ils peuvent faire au quotidien. Il sera ensuite analysé par un professionnel, tel que l'ergothérapeute, étant formé au profil sensoriel. Le Profil Sensoriel, une fois analysé, permet d'identifier les particularités sensorielles et perceptives de l'enfant pour pouvoir élaborer un projet d'intervention adapté à ses besoins (Marquis, 2023). L'ergothérapeute va pouvoir créer un environnement dans lequel l'enfant peut réaliser son plein potentiel, contribuer à améliorer le développement de ses compétences motrices, mais aussi enseigner au jeune individu des stratégies de compensation (Autism Ontario, 2011). L'ergothérapeute intervient auprès de l'enfant via des activités choisies en fonction de ses intérêts et de ses besoins. Son but étant d'engager le jeune dans une démarche de participation (ANFE, 2013). Les adaptations que l'ergothérapeute va pouvoir proposer vont permettre d'apporter davantage de bien-être et de sérénité dans le quotidien de l'enfant ayant des TSA. Cela, dans l'objectif de favoriser l'apprentissage, l'autonomie, le langage ainsi qu'une canalisation des comportements parfois négatifs (Ergothérapeutes.net, 2022).

Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

Dans les SESSAD, l'ergothérapeute est très présent dans le domaine des habiletés, donc sur les différents lieux de vie de l'enfant puisque son but est de permettre la généralisation des acquis. Il va s'axer sur l'observation de l'enfant dans son environnement, afin de voir si des modifications, des

adaptations doivent être réalisées pour que l'individu puisse plus facilement s'adapter. L'ergothérapeute intervient dans toutes les sphères de vie de l'enfant ayant des TSA. Son but étant que la personne devienne autonome dans ses activités de vie quotidienne, que ce soit au niveau des soins personnels, que de la productivité ou des loisirs (CRAIF, 2018).

Cabinet libéral

En cabinet libéral, l'ergothérapeute va s'engager dans la recherche d'actions rééducatives ou compensatrices afin de développer l'autonomie dans les activités de vie quotidienne chez l'enfant ayant des TSA sévères. Il va travailler sur les incapacités de la personne, afin de limiter les répercussions dans les actes quotidiens comme s'habiller, faire sa toilette, s'alimenter (Dechambre, 2020). L'ergothérapeute peut aussi se déplacer au domicile pour adapter le logement de l'enfant, dans le but d'assurer sa participation dans les occupations, et de développer son autonomie, sa sécurité et son confort (Genet, s.d).

Les ergothérapeutes exerçant en libéral ne travaillent pas seuls, ils sont en lien avec d'autres professionnels de santé.

3. La prise en soin pluridisciplinaire

Selon Janes Summers, la collaboration interprofessionnelle représente, depuis plusieurs années, une approche optimale des soins, plus particulièrement auprès des personnes ayant des troubles du spectre autistique (Summers, Bartha, Desarkar & Duggan, 2016).

Au cours de sa prise en soins, l'enfant avec TSA sévères va être amené à rencontrer plusieurs professionnels de santé. En règle générale, ce sont les pédiatres ou les médecins de famille qui vont orienter l'enfant vers un médecin spécialiste, un pédopsychiatre ou un neuropsychologue afin de pouvoir réaliser des bilans et de poser un diagnostic. Ils vont également surveiller et évaluer régulièrement la santé et les progrès dans le développement de l'enfant (Brian, 2019). Le neuropsychologue va pouvoir effectuer un bilan complet des capacités et des déficiences cognitives de l'enfant à l'aide de différents outils standardisés. Ce diagnostic permettra ainsi de déterminer le degré de sévérité des troubles du spectre autistique (Chebli, 2017). Le psychologue, lui, va accompagner l'enfant et son entourage au moment du diagnostic mais aussi après, afin d'apporter un lieu d'écoute. L'assistant social intervient auprès de l'enfant et de la famille pour faciliter l'intégration, gérer toute la partie logement, santé. Il va pouvoir faire le lien entre les différentes structures, les professionnels que l'enfant va rencontrer pendant son parcours. Le rôle de l'éducateur spécialisé est

d'accompagner l'enfant dans son quotidien. Il va mettre en place des activités éducatives, ainsi que des ateliers en groupe ou en individuel. Il participe grandement au projet de l'enfant et au suivi de son avancée (Chapel, 2019, [1]). L'orthophoniste travaille la communication, le langage (vocabulaire - formulations de phrases). Mais aussi, en autres, l'apprentissage du Makaton, qui est une communication gestuelle et avec des pictogrammes, utilisée lorsqu'un trouble de la communication est présent, cela en étroite collaboration avec l'ergothérapeute (Cohen, 2002). Enfin, le psychomotricien, lui, s'axe sur les troubles psychomoteurs et sensori-moteurs. Il travaille également la sensorialité ainsi que la position du corps dans l'espace. Ces troubles sensoriels vont souvent se travailler en parallèle avec l'ergothérapeute (Perrin, 2013).

Cette collaboration entre professionnels de différentes spécialités permet d'avoir une approche prenant en compte la globalité des besoins particuliers de l'enfant ayant des troubles du spectre autistique. Ainsi que d'inclure dans la prise en soin la famille, l'entourage de la personne concernée et de prendre en compte leurs besoins (Rossini-Drecq, ANFE, Schovanec & Guisset, 2020). Dans le livre *« Parole et langage pédiatriques : perspectives sur la pratique interprofessionnelle, un enjeu des cliniques pédiatriques d'Amérique du Nord »* de Potvin Marie-Christine, Prelock Patricia et Savard Liliane, au chapitre *« Soutenir les enfants autistes et leurs familles : un processus interprofessionnel axé sur la famille et adapté à la culture »*, les auteurs évoquent le *« Processus de Coaching en Contexte »*. Ce processus interprofessionnel est axé sur le développement de l'amélioration du fonctionnement des enfants ayant des TSA et de leurs familles dans les activités de vie quotidienne. Cette pratique veut montrer que les familles jouent un rôle majeur dans la prise en soin et la mise en œuvre du plan d'intervention de leur enfant (Potvin, Prelock & Savard, 2018). Le fonctionnement du SESSAD est adapté à la prise en soin d'un enfant ayant des TSA puisque, comme vu précédemment, il permet d'avoir une grande partie des professionnels de santé réunis au même endroit, ce qui facilite le lien. De plus, c'est un établissement qui peut laisser la possibilité aux parents d'être présents, de pouvoir échanger avec les différents professionnels avant ou après les séances de l'enfant.

4. Le lien avec la famille

De manière générale, lorsque l'ergothérapeute travaille auprès d'enfants, l'inclusion des membres de la famille et de l'entourage est indispensable pour l'intervention. L'enfant vit et grandit au quotidien avec son entourage, il est en interaction constante avec eux. La pratique contemporaine de l'intervention en ergothérapie prend en compte l'enfant et ses besoins occupationnels, mais également tous les membres qui l'entourent, en leur fournissant des stratégies de compensations et

d’adaptations répondant aux exigences des différents environnements (Rossini-Drecq, ANFE, Schovanec & Guisset, 2020). Lorsque le diagnostic de troubles du spectre autistique est posé, c’est la vie de l’enfant qui se retrouve bouleversée, mais c’est aussi celle des parents et de la fratrie. Ce diagnostic est souvent associé à une diminution des occupations familiales. Il va alors être important que l’ergothérapeute comprenne et prenne en compte les attentes, les perceptions et les ressentis de la famille, également qu’il les accompagne dans la compréhension du fonctionnement de leur enfant (De Grace, Hoffman, Huston & Kolobe, 2016).

III. La participation à travers le Modèle de l'Occupation Humaine

Un modèle conceptuel est une représentation simplifiée d'un processus qui intègre la théorie, les idées philosophiques sous-jacentes, l'épistémologie et la pratique. Il se construit à partir d'hypothèses, selon des valeurs fondamentales.

Afin de répondre à mon questionnement sur la participation occupationnelle des enfants ayant des TSA sévères au domicile, j'ai choisi de m'intéresser au Modèle de l'Occupation Humaine (MOH). Il a été créé en 1980 par Gary Kielhofner, théoricien influent de l'ergothérapie. C'est un modèle général, très souvent utilisé par les ergothérapeutes. Il est centré sur le client et sur l'occupation. Ce modèle illustre bien le fait que la personne agit dans ses environnements pour développer son adaptation occupationnelle (Kielhofner, 2008).

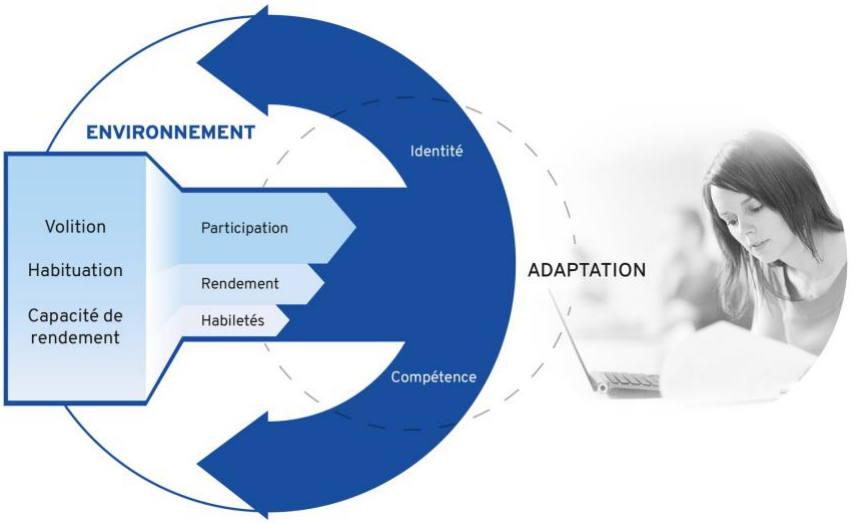


Schéma du modèle conceptuel de l'Occupation Humaine (MOH) de Gary Kielhofner

1. L'Être occupationnel

Habituation

L'habituation est le second élément qui compose l'Être occupationnel dans le Modèle de l'Occupation Humaine. Elle est définie par Kielhofner comme : « *une volonté intériorisée d'afficher des modèles de comportement cohérents guidés par nos habitudes et nos rôles adaptés aux caractéristiques des environnements temporels, physiques et sociaux.* » (Kielhofner, 2008).

L'habituation est en partie composée des habitudes. Les habitudes sont des routines comportementales associées à un environnement particulier et stable, elles ponctuent notre quotidien. Elles vont permettre aux individus de répondre de manière automatique et variée aux demandes de l'environnement (Kielhofner, 2008). Ces habitudes et ces routines sont très présentes dans la vie de l'enfant ayant des troubles du spectre autistique sévères. Un des premiers signes des TSA est l'attachement à des habitudes, à des routines.

Ainsi, des ergothérapeutes et scientifiques américaines, spécialistes de l'occupation, ont identifié cinq avantages aux habitudes, dont trois d'entre elles correspondent aux caractéristiques et aux besoins de l'enfant présentant des TSA sévères. Les habitudes : *« 1. Canalisent les ressources de la personne dans une direction et minimisent ainsi les incohérences et indécisions ; 2. Elles utilisent des incitations de l'environnement comme guide ; 3. Elles améliorent l'habileté grâce à la répétition, ce qui augmente les chances de réussir. »* (Clark, Sanders, Carlson, Blanche & Jackson, 2007).

Ces avantages justifient en partie l'importance des habitudes dans la vie quotidienne de l'individu ayant des TSA. Il est vrai que le monde qui l'entoure lui semble souvent imprévisible, ce qui peut le rendre anxieux. La stabilité des routines le réconforte et le sécurise, car elle lui permet de savoir ce qui va se passer par la suite. D'autant plus que de ne pas respecter les habitudes et routines de la personne peut susciter des comportements négatifs, tels que des crises (Labbé, 2021, [6]).

Toutefois, les habitudes n'ont pas que des avantages. Vivre au quotidien avec des habitudes et des routines peut finir par devenir problématique. Elles sont très utiles à la vie d'un individu et passent généralement inaperçues. Jusqu'au moment où la personne va rencontrer un changement dans son quotidien auquel elle ne saura pas faire face. Chez un enfant ayant des TSA sévères un manque de flexibilité important est présent, ce qui fait que face à une situation non quotidienne il ne sera pas en capacité d'adapter son comportement. Il peut alors décider de ne pas réaliser la tâche qu'il s'apprêtait à faire, ce qui diminue sa participation occupationnelle. Avec des enfants ayant des TSA sévères, il sera indispensable d'apporter régulièrement des changements mineurs aux routines, afin qu'ils ne deviennent pas rigides face à cela (Labbé, 2021, [6]).

Capacité de rendement

La capacité de rendement est le troisième et dernier élément de l'Être occupationnel. Cette composante s'intéresse au corps de l'individu, à la possibilité que la personne va avoir d'atteindre ses buts en fonction des moyens dont elle dispose (Kielhofner, 2008). La capacité de rendement évoque donc la capacité d'une personne à choisir, à s'organiser et à s'adonner à ses occupations (AQRP, 2006).

Ce qui veut dire qu'elle varie selon l'âge : un enfant âgé de 2 ans n'aura pas les mêmes capacités de rendement qu'un enfant de 6 ans.

À l'âge de 2 ans l'enfant a déjà développé de nombreuses capacités au niveau sensoriel et moteur. Il va commencer à explorer son environnement avec ses différents sens ainsi qu'à explorer son corps. Il est capable de marcher, de courir, de tenir des objets dans une main tout en occupant l'autre. Cependant, l'enfant de 2 ans est encore dépendant dans la majeure partie de ses tâches de la vie quotidienne (Adnot, 2016). C'est entre 6 et 10 ans qu'il va développer son autonomie dans ses occupations. À l'âge de 6 ans, l'enfant sait se coiffer, se rendre aux toilettes, couper les aliments avec un couteau ainsi que tartiner une tranche de pain seul. Puis, de 7 à 8 ans, il est capable d'attacher une fermeture éclair, ainsi que des boutons se trouvant dans son dos sans aide. Enfin, de 8 à 10 ans, l'enfant consolide ses apprentissages et devient autonome dans l'habillage, la toilette, la prise de repas (Caron Santha, 2023).

Pour la suite de mon mémoire, j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement aux enfants de 6 à 10 ans, puisque c'est la période où ils développent leur autonomie. Néanmoins, l'enfant ayant des troubles du spectre autistique sévères se développe moins rapidement au niveau psychomoteur, ce qui fait qu'il risque de devenir autonome dans ses occupations plus tard.

2. L'Agir occupationnel

Occupation

L'Agir occupationnel, *« ce que la personne fait »*, c'est-à-dire ses occupations. Le mot occupation vient de *occupare* en latin, qui signifie *« s'emparer de »*. En français, il a plusieurs sens, dont un qui est : « *ce à quoi on consacre son activité, son temps ; travail susceptible d'occuper.* » (Petit Robert, 2007). Selon Kielhofner, l'occupation humaine : *« fait référence au travail, au jeu ou aux activités de la vie quotidienne dans un contexte temporel, physique et socioculturel qui caractérise une grande partie de la vie humaine. »* (Kielhofner, 2008). Pour Kielhofner, les activités de la vie quotidienne sont synonymes de soins personnels et comprennent, en partie, s'habiller, faire sa toilette, se rendre aux toilettes, se laver les dents et manger (Meyer, 2013).

Le concept d'occupation se développe depuis plusieurs années dans le domaine de l'ergothérapie avec les sciences de l'occupation. L'occupation du point de vue ergothérapique peut également être définie comme *« ce que font les gens, qui a du sens pour eux dans leur contexte, leur agir dans leur vie quotidienne. »* (Caire & Schabaille, 2018).

Au vu de mon sujet, je vais m'intéresser plus particulièrement à la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des TSA sévères dans ses activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, ce sont les activités visant à s'occuper de soi-même. Elles visent le maintien du bien-être et de la santé de l'individu (Meyer, 2013).

La participation occupationnelle

Ce retard d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne peut s'expliquer par une restriction de la participation occupationnelle de l'enfant avec des TSA sévères. Kielhofner définit, dans le MOH, la participation occupationnelle comme : *« le fait de s'engager dans des occupations situées dans un contexte socio-culturel, désirées et/ou nécessaires pour le bien-être de la personne. Elle correspond à un engagement qui implique la réalisation de l'activité mais aussi l'expérience subjective dans l'agir. »* (Kielhofner, 2008). Ce déficit au niveau de la participation occupationnelle s'explique par une difficulté de l'enfant dans son rendement occupationnel, c'est-à-dire dans le fait de réaliser une partie de la tâche (Kielhofner, 2008). Cette difficulté s'explique elle-même par un manque d'habiletés – actions observables dirigées vers un but, qui nous permettent de réaliser une activité – chez l'enfant avec des TSA sévères.

Il existe trois types d'habiletés : motrices – ce qui est lié au mouvement du corps dans l'espace ; opératoires – les séquences de gestes ou d'actions dans le temps ; et communication & interaction – qui prend en compte la transmission de ses intentions et besoins.

Chez l'enfant ayant des TSA sévères, nous retrouvons des difficultés dans chacune de ces habiletés. En effet, au niveau moteur, il lui est difficile de maintenir son équilibre, que ce soit assis ou debout ; la coordination bi-manuelle n'est pas acquise. Pour ce qui est des habiletés opératoires, l'enfant n'est pas en capacité de s'adapter s'il se retrouve face à un problème, il peut également rencontrer des difficultés au niveau physiologique à sentir ses envies (Chapel, 2019). Enfin, comme vu précédemment, au niveau de la communication et des interactions, il est compliqué pour lui d'exprimer aux autres ce qu'il ressent et quels sont ses besoins (Rogé, 2008). Cela va impacter au quotidien les activités de soins personnels de l'enfant avec des troubles du spectre autistique sévères.

L'enfant ayant des TSA sévères peut, par exemple, rencontrer de grandes difficultés pour se rendre aux toilettes seul. À cause de ses déficiences en matière d'habiletés, l'enfant ne sera pas capable d'exprimer son souhait de se rendre aux toilettes. De plus, sa difficulté à initier une tâche va l'empêcher d'y aller spontanément sans avoir besoin d'exprimer aux autres son besoin. De même, ses particularités sensorielles peuvent parfois le mettre en difficulté pour ressentir son besoin

physiologique et le fait qu'il est mouillé. L'enfant a donc besoin d'être perpétuellement sollicité et accompagné pour s'engager dans ses activités de soins personnels (Chapel, 2019, [2]).

3. L'environnement

Dans le Modèle de l'Occupation Humaine, il est dit que : *« Toute occupation se produit dans un environnement complexe et multicouche. »* (Kielhofner, 2008). L'environnement ce sont les espaces utilisés par l'individu dans son quotidien. Il comprend donc les objets que la personne utilise ainsi que les individus avec lesquels elle interagit. L'environnement influence les performances quotidiennes de l'être humain de deux façons. Tout d'abord, en fournissant des opportunités à la personne pour développer des comportements, puis en exigeant d'elle certains comportements (Kielhofner, 2008).

Physique

L'environnement physique est défini par Kielhofner comme l'environnement qui inclut : *« Les objets et les espaces physiques qui nous entourent. »* (Forsyth & Kielhofner, 2003). Le domicile, l'école ainsi que le lieu de travail font partie de l'environnement physique de la personne.
Nous allons nous concentrer sur le domicile de l'enfant ayant des troubles du spectre autistique sévères, au vu de la thématique retenue.

Comme énoncé précédemment, les personnes ayant des TSA ont un profil sensoriel particulier, elles peuvent être hypersensibles aux stimuli extérieurs. Au domicile, cette particularité sensorielle peut être problématique. Très souvent, l'enfant va être sur-stimulé par la luminosité, les odeurs, les textures ainsi que par le bruit souvent provoqué par les autres membres de la famille ou le voisinage. De plus, l'enfant a besoin de repères afin de pouvoir se repérer dans son environnement. Le changement et l'hyperstimulation peuvent engendrer une situation de stress, qui à son tour va provoquer des troubles du comportement, susceptibles de le rendre vulnérable. Ils vont tous deux impacter la participation occupationnelle de l'enfant dans ses activités de vie quotidienne. Il est donc important de mettre en place un cadre sécurisant et rassurant au domicile (Lebaut, 2020).

Les particularités sensorielles de l'enfant peuvent fortement influencer sa participation occupationnelle dans la réalisation de sa toilette. Les sensations du jet d'eau et de la texture du savon pour le corps peuvent être très déplaisantes pour l'individu. D'autre part, le bruit de l'eau qui coule, qui goutte ou encore celui de l'eau qui s'évacue peuvent être mal vécus par l'enfant ayant des TSA

sévères. Ces sensations vont provoquer chez lui des réactions très vives, comme des crises ou un stress intense qui peuvent engendrer un arrêt total de l'occupation (Chapel, 2019, [2]).

Social

L'environnement social *« réunit les groupes d'appartenance de cette personne, incluant leurs conventions spécifiques appelées formes occupationnelles. »* (Forsyth & Kielhofner, 2003).
Il comprend les relations sociales et les milieux culturels au sein desquels la personne évolue (Barnett & Casper, 2001). La relation avec la fratrie et les parents se retrouve dans l'environnement social de l'enfant ayant des TSA sévères. La relation avec la famille va m'intéresser plus particulièrement puisque c'est avec elle que l'enfant vit au quotidien à son domicile.

Lorsqu'un enfant d'une famille est atteint d'un handicap ou d'un trouble, la vie de l'enfant mais également de tous les autres membres de cette famille est impactée. Les parents vont mobiliser leur temps et leur énergie pour cet enfant, afin de pouvoir répondre au maximum à ses besoins et de lui procurer les meilleurs soins possibles. Le jeune ayant des TSA sévères va alors être au centre de l'attention. Cette situation peut devenir problématique lorsqu'il n'est pas le seul enfant de la famille. Le frère ou la sœur peut être mis au second plan et mal vivre la situation. Pour attirer l'attention des parents, il/elle peut avoir un comportement agressif. Cela peut engendrer des conflits familiaux (Selmi, 2014). Les relations conflictuelles présentes dans la famille peuvent empêcher le bon développement de l'enfant avec TSA car le développement dépend de soi et de ses propres capacités mais aussi de l'influence de son environnement proche (Selmi, 2014).

De plus, la pose du diagnostic de trouble du spectre autistique chez un enfant peut être un choc pour les parents et entraîner un stress important. Selon Carole Sénéchal et Catherine des Rivières-Pigeon, 50% à 80% des mères ayant des enfants avec des TSA font preuve d'un taux élevé de stress, de détresse psychologique et d'isolement social. Cela est dû à une surcharge de travail que demande l'éducation de l'enfant, ainsi qu'à une pression sociale (Sénéchal & Rivières-Pigeon, 2009).

Comme vu précédemment, l'environnement a un impact sur les occupations de l'enfant. En effet, les résultats de l'étude de DeGrace sur la famille autour de la maladie montrent que, dans les familles avec un enfant ayant des TSA sévères, la participation occupationnelle dans les activités de vie quotidienne va être restreinte (DeGrace, 2004). Cette diminution s'explique en partie par la fatigue et la détresse psychologique des parents, qui vont provoquer une implication moindre dans les occupations quotidiennes de la famille.

IV. Problématique et hypothèses

Suite à mes recherches, la question de ma situation d'appel s'est affinée pour aboutir à la problématique suivante :

De quelle manière l'ergothérapeute peut-il favoriser la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des troubles du spectre autistique sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile ?

Pour y répondre, j'ai émis l'hypothèse suivante :

L'ergothérapeute favorise la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des troubles du spectre autistique sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile, grâce à la mise en place d'adaptations environnementales.

V. Méthodologie de l'enquête

1. Objectifs de l'enquête

À travers ce travail de recherche, j'ai aspiré à savoir si les adaptations environnementales au domicile de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des troubles du spectre autistique sévères faciliteraient sa participation occupationnelle dans ses activités de vie quotidienne.

Afin de valider ou d'invalider mon hypothèse de recherche, j'ai réalisé une enquête visant à analyser la pratique des ergothérapeutes sur le terrain auprès de cette population.

Les objectifs pour cette enquête étaient les suivants :

Objectifs	Critères d'évaluation
Objectif n°1 : D'ici le 15/04/2023, avoir **identifié** la/les occupation(s) dans laquelle/lesquelles la participation de l'enfant ayant des TSA sévères est la plus impactée.	**Qualitatifs.** L'ergothérapeute mentionne la/les activité(s) de vie quotidienne dans laquelle/lesquelles l'enfant ayant des TSA sévères rencontre le plus de difficultés.
Objectif n°2 : D'ici le 01/05/2023, avoir **recensé** les moyens et les outils mis en place par les ergothérapeutes permettant une meilleure participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile.	**Qualitatifs.** Énumération ou liste de moyens pouvant être mis en place par l'ergothérapeute. Nomination d'un ou plusieurs outil(s) pouvant être utilisé(s) afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères.

Tableau 1 : Objectifs de l'enquête

2. Population ciblée

Pour réaliser mon enquête, j'ai eu besoin d'interroger plusieurs ergothérapeutes travaillant ou ayant travaillé auprès d'enfants présentant des TSA sévères et exerçant dans un SESSAD ou en cabinet libéral afin d'avoir la dimension d'intervention à domicile.

Les critères d'élaboration de mon échantillon étaient les suivants :

	Ergothérapeutes
Critères d'inclusion	Ergothérapeute travaillant ou ayant travaillé auprès d'enfants âgés de 6 à 10 ans présentant des troubles du spectre autistique sévères. Exerçant en SESSAD ou en cabinet libéral et pouvant intervenir au domicile de l'enfant.
Critères d'exclusion	Ergothérapeute n'ayant jamais travaillé auprès d'enfants âgés de 6 à 10 ans présentant des TSA sévères et ne pouvant pas intervenir au domicile. Ayant une absence de maitrise de la langue française ne permettant pas de répondre à mes questions.

Tableau 2 : Critères d'inclusion et d'exclusion des ergothérapeutes

3. Choix de l'outil d'investigation

Au regard de la population de mon enquête, de mon sujet, de mon hypothèse ainsi que de mes lectures, l'outil d'investigation le plus adapté pour répondre aux objectifs de mon étude est **l'entretien semi-directif**. En effet, cette méthode est qualitative et permet de *« récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuves à un travail de recherche. »* (Claude, 2019). La recherche qualitative consiste à recueillir des données verbales permettant une démarche interprétative. L'entretien favorise la reformulation, ce qui peut faire émerger en continu de nouvelles hypothèses (Aubin-Auger, Mercier, Baumann, Lehr-Drylewicz & Imbert, 2008). De plus, il permet à l'interviewé de répondre librement aux questions ouvertes préparées en amont par l'interviewer (Claude, 2019). L'entretien semi-directif est un dialogue entre deux personnes. Il s'agit d'un moment d'écoute, d'empathie et de partage, ce sont donc des éléments essentiels à avoir et à prendre en compte afin d'assurer sa bonne réalisation. Il est important d'établir une relation de confiance pour pouvoir livrer un discours fidèle à son parcours. C'est pour cela qu'il convient de ne pas apporter de jugement aux réponses de la personne interviewée, ni d'éléments de réponses (Imbert, 2010).

L'entretien semi-directif comporte plusieurs avantages comme :

- Des réponses spontanées,
- Des réponses riches et nuancées,
- Permettre une observation des attitudes de la personne, de ses sentiments, de son ressenti,

- Un échange entre deux personnes,
- L'analyse d'un sujet précis.

(Debret, 2019)

En revanche, cet outil d'investigation comporte aussi des limites comme :

- La difficulté à réaliser une étude statistique entre plusieurs entretiens semi-directifs,
- Une influence de l'interviewer dans les réponses,
- Une méthode qui demande du temps aux interviewés.

(Debret, 2019)

Pour construire mon guide d'entretien, j'ai commencé par noter les différentes thématiques auxquelles je souhaitais m'intéresser. Les thématiques de la participation occupationnelle ainsi que celles sur les activités de vie quotidienne sont directement issues de ma problématique. Les autres thématiques, comme la prise en soin pluridisciplinaire et le lien avec la famille, ne sont pas clairement exprimées dans mon sujet mais sont des notions importantes au vu de la population étudiée. Pour ce qui est du nombre de questions, j'ai essayé d'avoir une question de première intention par thématique, puis plusieurs questions de relance. Néanmoins, pour la partie sur les activités de vie quotidienne, j'ai eu davantage de questions de première intention afin d'en avoir une pour chacune des activités.

Compte-tenu du temps imparti et des réponses que j'ai obtenues, j'ai réalisé 3 entretiens afin de pouvoir prendre mon temps pour chacun d'eux et correctement les retranscrire. Étant donné que la méthode choisie est qualitative, je recherche davantage une saturation des réponses, des informations reçues, que de faire valoir un avis.

Avant de réaliser mes entretiens, j'ai testé l'outil en amont auprès d'étudiants en ergothérapie ayant déjà effectué un stage auprès d'enfants âgés de 6 à 10 ans présentant des TSA sévères. Cela dans le but d'avoir des retours me permettant de réaliser des modifications et de m'entrainer à utiliser l'entretien semi-directif avant la réalisation des entretiens sur le terrain.

4. L'échantillonnage

Je me suis mise à la recherche d'ergothérapeutes pouvant répondre à mes critères d'inclusion dès le 06 mars 2023.

Pour mener à bien mon enquête, j'ai demandé aux étudiants de l'IFE de Créteil ayant effectué un stage en SESSAD ou en cabinet libéral les coordonnées de leurs lieux de stage. J'ai également

cherché des contacts d'ergothérapeutes travaillant auprès d'enfants ayant des troubles du spectre autistique dans la base de stage de l'IFE de Créteil. J'ai contacté les ergothérapeutes par mail.

Afin de maximiser mes chances d'avoir des retours d'ergothérapeutes répondant à mes critères d'inclusion, j'ai publié une annonce ainsi qu'un questionnaire sur un groupe Facebook avec des ergothérapeutes. Ce moyen de communication m'a permis d'avoir deux réponses favorables à mon questionnaire. Dans mon questionnaire, j'ai posé 8 questions orientées sur : la tranche d'âge accompagnée, les établissements où ils interviennent, le degré de sévérité des TSA le plus souvent rencontré, ainsi que la possibilité d'intervenir au domicile *(Annexe 6)*. Ces questions m'ont permis de visualiser directement si les ergothérapeutes ayant répondu à mon questionnaire correspondaient à mes critères d'inclusion.

Les recherches d'ergothérapeutes et les prises de contacts, via les différents vecteurs énoncés ci-dessus, m'ont amenée à réaliser trois entretiens. Afin de mieux visualiser mes recherches et mes prises de contacts, j'ai créé un diagramme des flux se trouvant ci-dessous.

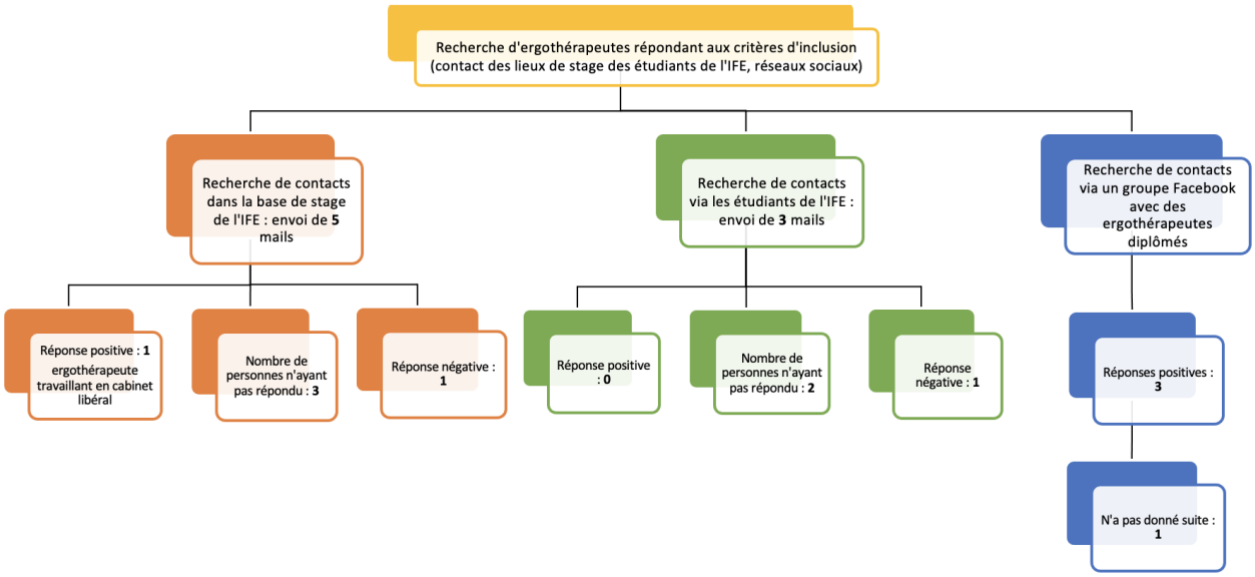


Diagramme de flux : ergothérapeutes contactés

VI. Résultats et analyse

Mes trois entretiens se sont réalisés en respectant l'éthique et l'anonymat des ergothérapeutes interrogées. En amont, une note d'information rappelant le déroulé ainsi que les conditions de passation de l'entretien et un formulaire de consentement ont été envoyés aux ergothérapeutes. Celles-ci les ont également signés pour montrer leur accord *(Annexe 1 & 2).* Les résultats bruts seront détaillés dans des tableaux, selon les thématiques établies dans mon guide d'entretien *(Annexe 3)*. Cela afin d'apporter plus de clarté lors de la lecture.
L'entretien de E2 a été entièrement retranscrit et se trouve en annexe *(Annexe 5).*

Dans les tableaux ci-dessous présentant mes résultats bruts, les réponses seront toujours des trois mêmes ergothérapeutes. Pour les identifier j'ai choisi de les nommer : E1 – E2 – E3, les numéros correspondent à l'ordre dans lequel les entretiens se sont réalisés. Afin de faciliter davantage la distinction des différentes réponses, j'ai choisi d'attribuer des couleurs à chacun d'entre eux :

E1 **E2** **E3**

1. Thème 1 : Profil des ergothérapeutes interrogées

Résultats bruts

	E1	**E2**	**E3**
Date de l'entretien	21/03/2023	28/03/2023	05/04/2023
Type d'entretien	Appel téléphonique	Appel téléphonique	Zoom
Durée de l'entretien	35 minutes	40 minutes	45 minutes
Année d'obtention du diplôme	2021	2018	2018
Lieu d'exercice actuel	SESSAD	Cabinet libéral	SESSAD/IME
Année d'expérience auprès des enfants ayant des TSA sévères	Depuis août 2022	5 ans	3 ans
Tranche d'âge	6 – 12 ans	2 – 17 ans	6 – 18 ans

Degré de sévérité des TSA le plus rencontré	Léger	Sévère	Sévère

Tableau 3 : Profil des ergothérapeutes interrogées

Analyse

L'année d'obtention du diplôme des différentes ergothérapeutes interrogées est proche. Toutes pratiquent en pédiatrie depuis l'obtention de leur diplôme. Deux d'entre elles (**E2**, **E3**) possèdent plusieurs années d'expériences auprès des enfants ayant des troubles du spectre autistique et une autre (**E1**) intervient depuis peu auprès de cette population.

Deux des ergothérapeutes (**E1**, **E3**) travaillent en partie en SESSAD, **E3** est à la fois en SESSAD et en IME, **E2** travaille depuis qu'elle est diplômée dans un cabinet libéral. Pour mes entretiens, nous nous sommes consacrées aux enfants ayant des troubles du spectre autistique sévères, qui font partie de ma population cible. Puisqu'en effet, dans leurs structures respectives, elles sont amenées à rencontrer également des enfants avec d'autres problématiques. Toutes les ergothérapeutes ont déjà été amenées à être en relation avec un jeune présentant des TSA sévères. Néanmoins, **E1** a davantage rencontré d'enfants ayant des TSA légers ; contrairement à **E2** et **E3** qui, elles, ont rencontré plus de jeunes présentant des TSA sévères.

2. Thème 2 : La prise en soin pluridisciplinaire et le lien avec la famille

Sous thème : L'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères

Résultats bruts

À la question : *« Pouvez-vous me dire les personnes avec lesquelles vous travaillez lors de la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères ? »*, les ergothérapeutes ont évoqué les personnes suivantes :

Ergothérapeutes / *Personnes citées*	**E1**	**E2**	**E3**
Professionnels	« **Les éducatrices**, les référentes des jeunes, qui, en fait, **connaissent le mieux le jeune** au niveau de la structure. » « La **psychologue** aussi du service et **l'assistante sociale** et **chef de service**. » « Y'a les **professionnels libéraux** aussi, **psychomot**… »	« Je travaille beaucoup avec **les éducatri**ces qui sont **en lien directement avec l'enfant**. » « Et avec les **psychomotriciennes** du secteur. » « Après, il y a aussi **les psychologues**, mais ça arrive en 3ème position. »	« Je travaille énormément (x3) avec **les éducateurs référents**. » « Un peu avec **le docteur** pour tout ce qui est administratif et **médecin**. » « Je mettrais **la psychologue** au même niveau que les médecins. » « Avec **la psychomot** aussi. »
Famille/entourage	« Ce sont des mineurs et ça se passe au domicile donc **tout passe par les parents**. » « C'est eux qui, après, permettent que la **prise en charge puisse vraiment avoir des bénéfices**, puisque c'est eux qui **accompagnent les jeunes au quotidien**. ».	« Avec **les parents**, j'ai des forts liens qui se sont créés. » « Les **grands parents** qui les amènent. »	« À peu près au même niveau que les éducateurs, c'est **les parents, la famille**. »
Autres	« Il y a tout ce qui est **au niveau de l'enseignement**. » « Y'a tout ce qui **AESH** qui les accompagnent. »	« Mais y a **les taxis** aussi qui les emmènent et c'est vrai qu'ils ont un rôle important. »	« Il y **a les professeurs** et **les AESH**. »

Tableau 4 : L'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères

Analyse

Dans les trois entretiens, les personnes énoncées sont assez similaires. L'ordre de l'énonciation des différents individus avec lesquels les ergothérapeutes peuvent travailler dans la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères varie d'un entretien à l'autre. Pour répondre à cette question, **E1** a commencé par évoquer en premier lieu les parents puis les professionnels et l'enseignement. **E3** a formulé sa réponse d'une autre manière, en parlant directement de l'éducateur spécialisé et des parents qu'elle positionne au même niveau. **E3** a énoncé les individus par ordre de priorité, en prenant en compte toutes les catégories de personnes (professionnels/entourage/autres…). Tandis que **E2** a commencé par les professionnels de santé, puis il a fallu que je pose une de mes questions de relance pour qu'elle évoque les parents. En effet, **E2** n'a pas pensé directement aux parents. Cependant, l'ordre d'importance des personnes avec qui les ergothérapeutes interrogées travaillent est assez semblable.

Pour ce qui est des professionnels, le premier d'entre eux qui a été évoqué dans chacun des entretiens est l'éducateur spécialisé de l'enfant. En effet, pour chacune d'entre elles, l'éducateur est le professionnel qui connaît le mieux l'enfant et sa famille, c'est lui qui va être le plus en lien avec eux. Pour les ergothérapeutes interrogées, l'éducateur spécialisé a un rôle central dans la prise en soin d'un enfant ayant des TSA. Puis, les deux autres professionnels de santé qui sont ressortis dans les trois entretiens sont les psychologues et les psychomotriciens. Eux aussi ont été décrits comme importants dans la prise en soin. Néanmoins ils arrivent après l'éducateur.

Pour ce qui est de l'entourage de l'enfant, il est évoqué dans chacun des entretiens également. Les ergothérapeutes interrogées montrent bien que le lien avec la famille va être très important dans l'accompagnement d'un enfant ayant des TSA sévères. Il est vrai que, généralement, ce sont les membres de la famille qui vivent au quotidien avec le jeune, ce sont les parents qui vont pouvoir l'accompagner, le guider, l'aider tous les jours. **E3** positionne l'entourage du jeune au même niveau que l'éducateur spécialisé.

E1 et **E3** ont également parlé de l'enseignement, avec les professeurs ou les AESH qui accompagnent l'enfant dans le milieu scolaire. **E2** évoque plutôt les taxis, qui peuvent emmener l'enfant aux séances d'ergothérapie en cabinet libéral, et permettent donc aussi de faire le lien entre la famille et le professionnel.

Sous thème : La collaboration avec les parents

Résultats bruts

À la question : *« D'après vous, comment en tant qu'ergothérapeute nous pouvons travailler avec les parents dans la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères à domicile ? »,* les ergothérapeutes ont donné les réponses suivantes :

	E1	**E2**	**E3**
La collaboration avec les parents	« Je n'ai pas **encore eu l'occasion de faire des séances avec eux**. »	« Les parents, ils sont **intégrés à la séance**. » « Comme ça je peux **faire le lien** avec eux. » « Je leur donne des **petits conseils, des outils** »	« Je les rencontre au moins **au début de l'accompagnement** de l'enfant. » « J'essaie de **maintenir le lien** avec eux. » « C'est **très dépendant des familles**. »

Tableau 5 : La collaboration avec les parents

Analyse

La collaboration avec les parents dans les trois entretiens varie. Il est vrai que, dans un cas, **E2** intègre très souvent les parents dans ses séances, tandis que, pour **E3,** cela est moins régulier, cela change en fonction des familles. **E1**, elle, n'a pas encore eu l'occasion de faire des séances en collaboration avec les parents.

Dans les trois entretiens, chacune dit quand même avoir un lien avec les parents à la fin des séances. Souvent, un échange de 5 minutes est consacré aux parents pour pouvoir leur expliquer ce qui s'est fait en séance, ce qui peut être travaillé à la maison, voir s'ils rencontrent des difficultés particulières. La différence pour l'intégration lors des séances entre **E2** et **E3** peut en partie s'expliquer par la structure dans laquelle elles travaillent. En effet, le cabinet libéral et le SESSAD/IME n'ont pas le même fonctionnement, les séances ne se déroulent pas de la même manière et, d'une structure à l'autre, cela s'y prête probablement moins.

3. Thème 3 : La participation occupationnelle chez l'enfant ayant des TSA sévères

Sous thème : Définition de la participation occupationnelle

Résultats bruts

À la question : *« Pour vous, qu'est-ce que la participation occupationnelle ? »*, les ergothérapeutes ont donné les définitions suivantes :

Participation occupationnelle	**E1**	« C'est la **participation** qu'a le jeune dans ses **activités quotidiennes**. »
	E2	« Comment l'enfant arrive à **réaliser ses occupations** de **manière optimale**. »
	E3	« C'est la **participation** de l'enfant dans tous les **domaines de la vie quotidienne**. »

Tableau 6 : La définition de la participation occupationnelle

Analyse

Les trois définitions de la participation occupationnelle données par les ergothérapeutes interrogées se rejoignent et rejoignent en partie la définition de Kielhofner.

Les définitions de **E1** et **E3** sont assez similaires, puisqu'elles utilisent toutes les deux le terme *« participation »* et qu'elles parlent *« d'activités ou de domaines de la vie quotidienne ».* Les activités de vie quotidienne comprennent pour elles le domaine des loisirs, de la productivité et des soins personnels. **E2** utilise, dans sa définition, le terme *« occupation »,* qui fait référence à un groupe d'activités. En employant ce terme, elle donne une définition plus large que **E1** et **E3**. De plus, la définition de **E2** est plus ambitieuse que celle de Kielhofner, puisqu'elle parle du fait de réaliser ses occupations, mais de les réaliser de *« manière optimale »*. Pour **E2**, ce n'est pas seulement faire son occupation, c'est aussi la faire au mieux.

Sous thème : L'occupation la plus impactée

Résultats bruts

À la question : *« Selon vous, dans quelle(s) occupation(s) la participation de l'enfant ayant des troubles du spectre autistique sévères va être la plus impactée ? »*, les ergothérapeutes ont donné les réponses suivantes :

Occupation(s) la/les plus impacté(s)	**E1**	« La problématique la plus importante c'est **le repas.** »
	E2	« Tout ce qui va être **lié au sensoriel**. Donc tout ce qui est **soins personnels**, au niveau de **la douche.** » « Tout ce qui va être **tactile** ça va être **hyper compliqué** (…) **s'habiller**, (…) **manger** (…). »
	E3	« Je suis très sollicitée par les parents pour l'autonomie, particulièrement **l'autonomie dans les soins personnels**. » « Mais moi, ce que j'observe, c'est une **restriction dans les loisirs** qui est énorme. »

Tableau 7 : L'occupation la plus impactée

Analyse

Pour cette question, le terme *« soins personnels »* a été employé par les trois ergothérapeutes que j'ai interrogées, car elles ne se basaient pas forcément sur le modèle du MOH. Afin de ne pas modifier leurs propos lors de ma retranscription, j'ai laissé le terme *« soins personnels ».* Cependant, dans mon analyse je parlerai *« d'activités de vie quotidienne »* pour continuer de m'appuyer sur le MOH.

Lors de mes trois entretiens, c'est le domaine des activités de vie quotidienne qui est ressorti comme le domaine dont la participation est la plus impactée chez l'enfant ayant des TSA sévères. Si nous nous attardons sur la réponse de chacune des ergothérapeutes, nous pouvons remarquer différentes choses. En effet, **E2** et **E3** n'ont pas ressorti d'activités précises dans les activités de vie

quotidienne. Elles sont davantage restées dans un domaine plus large. Pour **E3**, nous pouvons voir qu'elle distingue deux choses. Elle dit être sollicitée par les parents des enfants ayant des TSA sévères pour travailler l'autonomie dans les activités de vie quotidienne, car pour eux la participation de leur enfant est très impactée. Néanmoins, de ce qu'**E3** a pu observer au cours de sa pratique, c'est la participation occupationnelle des enfants ayant des TSA sévères qui est la plus restreinte dans les loisirs. Pour **E1**, la réponse donnée a été davantage ciblée sur une activité particulière qui est celle du repas. Elle justifie cela en disant que c'est une activité qui revient régulièrement dans une journée. De plus, elle évoque que c'est pour la prise de repas que les parents se sentent le plus démunis.

4. Thème 4 : La participation occupationnelle dans les activités de vie quotidienne

Sous thème : Les évaluations

Résultats bruts

À la question : *« Quelles évaluations faites-vous pour identifier les difficultés occupationnelles de l'enfant ayant des TSA sévères lors de la réalisation de ses activités de vie quotidienne ? »*. Les ergothérapeutes ont énoncé les évaluations suivantes :

Évaluations utilisées pour identifier les difficultés	**E1**	« En général, je fais un **bilan.** » « J'**échange avec les parents** sur l'évaluation des activités de vie quotidienne. Mais c'est plus quelque chose de **fabrication maison.** » « On peut faire des **mises en situations écologiques**, …, avec des **petites grilles.** »
	E2	« Je fais beaucoup passer **l'OT'Hope.** » « J'ai fait passer récemment **la MCRO** et une **MHAVIE.** » « Oui, oui je fais des **entretiens au début**, pour définir les **objectifs**. » « Je **discute avec les parents**. »
	E3	« L'**outil OT'Hope**, il y a la case **soins personnels** donc je l'utilise. Mais je trouve que ça n'est pas assez développé pour les enfants ayant des TSA sévères. » « J'ai construit des **grilles d'analyse d'activité**. » « Parfois, je vais faire **des mises en situations à domicile**. »

Tableau 8 : Les évaluations utilisées pour identifier les difficultés

Analyse

Pour ce qui est des évaluations permettant d'identifier les difficultés de l'enfant dans ses activités de vie quotidienne utilisées par les trois ergothérapeutes interrogées, nous pouvons voir que plusieurs d'entre elles se répètent. En effet, elles cherchent toutes les trois à savoir ce qui pose problème au quotidien.

Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons observer que les évaluations énoncées ne sont pas forcément présentes dans tous les entretiens, mais qu'à chaque fois une évaluation est commune pour au moins deux des ergothérapeutes.

Les trois ergothérapeutes essayent de demander à l'enfant quelles sont pour lui les difficultés qu'il rencontre à la maison pour réaliser ses soins personnels. Souvent, cela n'est pas simple car les enfants ayant des TSA sévères peuvent être non-verbaux et peuvent se retrouver dans l'incapacité de répondre aux questions. Afin de pallier les difficultés de communication qui peuvent se poser, les ergothérapeutes (**E2**, **E3**) utilisent parfois l'OT'Hope. Cet outil permet de privilégier une approche centrée sur la personne et sur ses occupations. Il soutient l'enfant dans une démarche d'auto-évaluation, cela en s'exprimant seulement à l'aide de cartes à placer dans différentes colonnes, ce qui rend la compréhension plus simple.

E1, **E2** et **E3** échangent beaucoup avec les parents en début de suivi, au cours d'un entretien ou lors de visites à domicile sur les difficultés que le jeune rencontre au quotidien. Selon les trois ergothérapeutes, ce sont les parents qui voient l'évolution, les problématiques de l'enfant ; ce sont les mieux placés avec le jeune pour pouvoir évoquer les difficultés dans les activités de vie quotidienne.



Nuage de mots 1 : Les évaluations utilisées pour identifier les difficultés

Sous thème : Les moyens et les outils

Résultats bruts

À la question : *« Quels moyens, quels outils pouvez-vous utiliser afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans cette activité ? ».* Cette question a été posée pour chacune des activités de vie quotidienne. Les ergothérapeutes ont énoncé les moyens et les outils suivants :

Ergothérapeutes / *Moyens/Outils*	**E1**	**E2**	**E3**
Adaptations environnement humain	« La **guidance verbale**. » « La **guidance physique**. »	« L'**aide orale** des parents. » « **Stimulations verbales**. »	« La **guidance verbale** et **gestuelle**. » « La **guidance imitative**. »
Adaptations matérielles	« Le travail en amont du **schéma corporel**. » « Travailler en **séquentiel**, mettre/enlever un **pictogramme**, déplacer une pince à linge pour suivre les étapes ».	« Les **pictogrammes** et le **séquentiel**. »	« Le **pointage** sur des photos. » « Le **séquentiel photo** ou **vidéo**. » « Le **renforçateur**. » « **Applications** donnant en temps réel les différentes étapes à réaliser. »
Adaptations sensorielles			

Tableau 9 : Les moyens et les outils utilisés pour favoriser la participation

Analyse

Pour ce qui est des moyens et des outils permettant de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne, beaucoup de ceux énoncés par les ergothérapeutes étaient assez identiques. Toutes les ergothérapeutes ont dit utiliser à peu près les mêmes moyens et outils dans chacune des activités de vie quotidienne.

Seulement un moyen, le renforçateur alimentaire, vient s'ajouter lorsqu'il est question de la participation dans la prise de repas.

Nous pouvons voir dans le nuage de mots que les moyens qui sont ressortis le plus dans les trois entretiens sont : l'utilisation du séquentiel, la mise en place de pictogrammes ainsi que la guidance verbale.



Nuage de mots 2 : Les moyens et outils utilisés pour favoriser la participation

VII. Discussion

1. Confrontation entre les recherches théoriques et les éléments du terrain

Les éléments énoncés dans cette partie feront l'objet d'une confrontation entre les recherches effectuées et les résultats obtenus lors des entretiens.

Pour rappel, cette étude a pour objectif de valider ou d'invalider l'hypothèse relative à la problématique suivante : **De quelle manière l'ergothérapeute peut-il favoriser la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile ?**

L'hypothèse donnée portait sur le fait que : **L'ergothérapeute favorise la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des troubles du spectre autistique sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile, grâce à la mise en place d'adaptations environnementales.** Pour répondre à cette hypothèse, des entretiens concernant la pratique des ergothérapeutes auprès de cette population ont été réalisés puis analysés. Les données recueillies ne permettent pas de totalement vérifier si les adaptations environnementales permettent de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans ses activités de vie quotidienne. À travers cette thématique de recherche, des liens entre la théorie et la pratique sur le terrain se sont créés.

Tout d'abord, nous avons pu voir, d'après les ergothérapeutes interrogées, que la collaboration entre les professionnels qui accompagnent un enfant ayant des TSA sévères va être indispensable au bon déroulement de la prise en soin. D'une part, la complémentarité pluridisciplinaire permet de réfléchir ensemble aux objectifs communs de la prise en soin de l'enfant, mais également de mettre en place les moyens thérapeutiques les plus adaptés aux besoins du jeune. En effet, selon Janes Summers, l'accompagnement interprofessionnel favorise une prise en soin optimale des individus ayant des TSA (Summers, Bartha, Desarkar & Duggan, 2016). Dans le livre, *L'ergothérapie et l'enfant avec autisme de la naissance à 6 ans*, Emmanuelle Rossini et Sylvie Tétreault appuient ce propos en exposant que ce sont les différentes spécialités de chacun des professionnels qui aident à prendre en compte la globalité des besoins particuliers de l'enfant avec des TSA (Rossini-Drecq, ANFE, Schovanec & Guisset, 2020).

Ensuite, les ergothérapeutes interviewées insistent sur l'importance du lien entre les professionnels et la famille du jeune. Les parents ont une place centrale dans le suivi d'un enfant ayant des TSA sévères puisque ce sont eux qui vont faire le lien entre les différents lieux de vie de l'enfant (le suivi médical, l'école, les loisirs, le domicile). Ce sont eux qui permettent de transférer les choses apprises en séance dans le quotidien de leur enfant. Ici aussi Emmanuelle Rossini et Sylvie Tétreault expliquent bien cela : étant donné que l'enfant vit au quotidien avec son entourage, c'est ce dernier qui connaît le mieux les difficultés et les besoins occupationnels du jeune. L'intégration des parents dans l'intervention en ergothérapie est importante afin de pouvoir leur fournir des stratégies de compensations et d'adaptations à mettre en place au domicile (Rossini-Drecq, ANFE, Schovanec & Guisset, 2020).

Enfin, ce qui ressort également dans les entretiens, c'est l'importance de prendre en compte les centres d'intérêt de l'enfant ayant des TSA sévères afin de favoriser une meilleure participation au quotidien. La motivation de l'enfant pour une activité va jouer sur son niveau de participation. Les enfants ayant des TSA sévères ont très souvent des intérêts restreints, une seule chose les préoccupe très fortement et en permanence (Labbé, s.d, [2]). C'est en travaillant sur cet intérêt restreint que l'apprentissage va être possible car l'enfant portera davantage attention à ce que nous travaillons si cela l'intéresse.

2. Validation de l'hypothèse de recherche

Lors de l'émission de l'hypothèse, nous entendions par *« adaptations environnementales »* : la sensibilisation de l'entourage (guidance verbale/gestuelle…), les aides matérielles (pictogrammes/séquentiels…) ainsi que les adaptations sensorielles (réglage de la luminosité, pression du jet d'eau…). Effectivement, ces moyens peuvent être utiles dans le quotidien d'un enfant ayant des TSA sévères puisque cela peut généralement l'aider à s'organiser, à se repérer et avoir une meilleure interaction avec son environnement.

Néanmoins, au cours de mes trois entretiens, seules la sensibilisation de l'entourage et les aides matérielles ont été nommées. Les ergothérapeutes interrogées ont beaucoup parlé de *« guidance verbale », « aide orale », « guidance physique »* ou encore de *« travailler en séquentiel », « le pointage sur des photos », « applications »*. Mais jamais de régler la pression du jet d'eau, la température, la luminosité dans une pièce, ce qui peut permettre de réduire les stimuli de l'environnement selon les sensibilités du jeune et donc d'optimiser ses capacités dans la réalisation de ses activités de vie quotidienne (CHUSJ, 2020).

Les adaptations sensorielles n'ayant été citées dans aucun de mes entretiens alors qu'elles constituent une partie de mon hypothèse, cela fait que celle-ci – sur la base de l'échantillon avec lequel je me suis entretenue - n'est que partiellement validée.

3. Limites et apports de mon étude de recherche

Limites

La première limite que j'ai rencontrée a été au niveau de la formulation de mon hypothèse. L'idée de mettre en place des adaptations au domicile pour favoriser la participation de l'enfant est venue très rapidement lorsque j'ai effectué mes recherches. Cependant, je me suis retrouvée en difficulté pour trouver le terme approprié. En effet, le premier terme que j'ai utilisé dans mon hypothèse a été *« aménagement du logement »*. L'ergothérapeute a un grand rôle au niveau de l'aménagement du domicile de la personne, mais, pour ma population cible cela n'était pas adapté. Par ce terme, nous entendons la mise en place d'aides techniques (siège de douche, couverts adaptés…) ou encore la préconisation de travaux à effectuer afin que la personne soit le plus autonome possible au quotidien. Chez les enfants ayant des TSA sévères, ce n'est pas cela qu'il faut puisque le changement de leur environnement risque de perturber davantage leur quotidien. Après différents échanges avec ma maître de mémoire et l'IFE de Créteil, ainsi qu'après plusieurs recherches, j'ai choisi d'utiliser le terme *« adaptations environnementales »,* qui englobe davantage de domaines et pas uniquement l'environnement physique.

L'outil d'investigation utilisé, l'entretien semi-directif, bien que guidé par une grille d'entretien, peut être un biais de mon étude. Le fait que mon hypothèse ne soit que partiellement validée peut s'expliquer par des questions trop vastes, qui n'ont pas assez orienté les ergothérapeutes où je le souhaitais précisément. De plus, l'échantillon de l'étude étant composé de trois ergothérapeutes, il ne permet pas de généraliser le fonctionnement de la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères, ainsi que les actions pouvant être mises en place pour favoriser la participation occupationnelle. Cependant, le délai qu'aurait nécessité cette enquête avec un plus grand nombre d'ergothérapeutes interrogés n'était pas envisageable au regard du temps imparti pour sa réalisation.

Ma recherche gagnerait à être étendue à d'autres professionnels comme les éducateurs spécialisés, puisque, lors des trois entretiens, la collaboration avec ces professionnels de santé et leur importance sont beaucoup ressortis. L'éducateur spécialisé ayant été énoncé comme le professionnel étant le plus proche du jeune, j'aurais également pu en interroger pour recueillir des informations

encore plus précises sur les principales difficultés rencontrées par la population de mon mémoire au quotidien.

Par conséquent, cette étude de recherches ouvre des perspectives intéressantes dans le cadre d'une enquête ayant une temporalité plus longue.

Apports

Ce travail d'initiation à la recherche a eu également plusieurs apports. Le premier a été sur le plan personnel. En effet, grâce à ce travail de recherche, j'ai pu davantage apprendre à être rigoureuse, à organiser ma pensée ainsi qu'à enrichir mes connaissances sur le fonctionnement des troubles du spectre autistique qui m'intéressent tout particulièrement depuis plusieurs années.

Cela a été enrichissant également sur le plan professionnel, tant au niveau théorique que pratique. Si je devais un jour accompagner cette population, je serais davantage sensible aux particularités du fonctionnement autistique, à la posture que je dois adopter, à l'importance de la collaboration avec la famille et les autres professionnels de santé.

Ce travail de recherche a permis d'enrichir mes connaissances concernant la pratique de l'ergothérapeute auprès des enfants âgés de 6 à 10 ans ayant des TSA sévères. Et plus précisément sur la question de la participation occupationnelle de l'enfant dans la réalisation de ses activités de vie quotidienne à domicile. Il a, par ailleurs, pu mettre en évidence les difficultés que le jeune ayant des TSA sévères rencontre au quotidien. Grâce à mes trois entretiens, j'ai pu répondre aux objectifs d'enquête qui étaient les suivants :

- **Identifier** la/les occupation(s) dans laquelle/lesquelles la participation est la plus impactée,
- **Recenser** les moyens et les outils permettant une meilleure participation.

De plus, cela m'a permis de rédiger pour la première fois un mémoire d'initiation à la recherche et de suivre une méthodologie particulière pour le réaliser.

Conclusion

Au travers de ce mémoire, j'ai pu effectuer de nombreuses recherches sur le sujet des troubles du spectre de l'autisme. Cette thématique m'est venue après avoir rencontré des personnes ayant une fille présentant un TSA sévère et vivant en colocation dans un habitat totalement adapté à son fonctionnement.

À la suite de mes diverses recherches, j'ai pu constater que les TSA peuvent avoir des conséquences sur toutes les dimensions qui composent l'Être occupationnel, la personne. L'ensemble de ces troubles peuvent également avoir un impact sur l'Agir occupationnel, donc les occupations de l'individu ainsi que sur les différents environnements qui l'entourent (social, physique, occupationnel). De plus, l'ensemble des troubles peuvent alors engendrer une restriction de la participation de la personne dans ses occupations, plus particulièrement dans ses activités de vie quotidienne. C'est pourquoi, la problématique qui a émergé est :

De quelle manière l'ergothérapeute peut-il favoriser la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des troubles du spectre autistique sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile ?

L'ergothérapeute est un professionnel paramédical pouvant intervenir au domicile de la personne, dans le but d'évaluer son niveau d'autonomie et les difficultés qu'elle peut rencontrer dans son quotidien. À la suite de cette visite à domicile, il va pouvoir préconiser des adaptations, des aménagements ou encore apporter des conseils et des stratégies à la personne, afin de pallier ses problèmes occupationnels. Suite à de nouvelles recherches, l'hypothèse formulée en réponse à la problématique a été la suivante :

L'ergothérapeute favorise la participation occupationnelle de l'enfant âgé de 6 à 10 ans ayant des troubles du spectre autistique sévères dans ses activités de vie quotidienne à domicile, grâce à la mise en place d'adaptations environnementales.

Dans le but de valider ou d'invalider cette hypothèse, j'ai réalisé une enquête ayant pour objectifs de faire ressortir l'occupation dans laquelle la participation occupationnelle de l'enfant est la plus impactée, ainsi que les moyens et les outils pouvant être mis en place pour favoriser cette participation. J'ai alors mené trois entretiens semi-directifs avec des ergothérapeutes travaillant auprès de la population cible et pouvant intervenir au domicile.

Au regard des résultats obtenus et après l'analyse effectuée, l'hypothèse n'est que partiellement validée. En effet, différents moyens composant les adaptations environnementales ont été cités par les ergothérapeutes, comme : la sensibilisation des parents avec la guidance verbale et gestuelle ; la mise en place d'aides matérielles avec les pictogrammes et le séquentiel. Néanmoins, les adaptations sensorielles, comme : régler la luminosité dans la pièce ; la pression du jet d'eau pendant la douche ; la diminution du bruit environnant, n'ont pas été énoncés.

Ce travail d'initiation à la recherche m'a fait prendre davantage conscience de l'importance de la prise en soin pluridisciplinaire et de la collaboration avec l'entourage de la personne. La communication et l'échange sont des éléments indispensables dans notre métier d'ergothérapeute afin d'assurer un accompagnement optimal. Cela m'a également donné envie d'approfondir mes recherches sur les adaptations environnementales pouvant être mises en place dans l'environnement des personnes ayant des TSA. Ainsi que de continuer à m'interroger sur l'impact que les adaptations sensorielles pourraient avoir sur la participation occupationnelle d'un individu vivant avec ces troubles.

Lors de mes différents entretiens, deux des ergothérapeutes interrogées ont évoqué l'outil OT'Hope comme un outil qui pourrait être intéressant pour évaluer les difficultés occupationnelles de l'enfant ayant des TSA sévères. En effet, celui-ci permet à l'enfant d'exprimer les problématiques qu'il rencontre de manière non-verbale. L'OT'Hope est un outil d'évaluation auquel je n'avais pas pensé lors de la création de mes questions de relance. Néanmoins, l'évocation de cet outil m'a fait me questionner sur l'apport de l'OT'Hope dans notre prise en soin ergothérapique auprès des enfants ayant des TSA sévères. En quoi l'OT'Hope pourrait favoriser l'engagement de l'enfant dans ses occupations serait un axe à approfondir.

Bibliographie

Adnot, P. (2016). *Observer et accompagner le développement de l'enfant de 0 à 6ans*. Consulté 20 décembre 2022, à l'adresse https://www.aube.fr/uploads/Publication/ab/59_1458203865_pdf_HD_page_par_page.pdf

Ameli. (2022). *Processus d'installation*. Consulté 27 janvier 2023, à l'adresse https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/vie-cabinet/installation-liberal/processus-installation

ANFE. (2013). *L'autisme*. Consulté 25 janvier 2023, à l'adresse https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/01/ANFE_AUTISME_2013.pdf

AQNP. (2023). *Les fonctions cognitives*. Association québécoise des neuropsychologues. Consulté 02 mars 2023, à l'adresse https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/

AQRP. (2006). *Volition et motivation en santé mentale*. *13*(1), 9. Consulté 02 mars 2023, à l'adresse https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/

Aubin-Auger, I., Mercier, A., Baumann, L., Lehr-Drylewicz, A.-M., & Imbert, P. (2008). *Introduction à la recherche qualitative*. *19*. Consulté 14 février 2023, à l'adresse http://www.bichat-larib.com/publications.documents/3446_2008_introduction__RQ__Exercer.pdf

Autism, O. (2011). *Les ergothérapeutes : À quoi vous attendre ?* Consulté 22 janvier 2023, à l'adresse https://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Santé/Autismontario-ergo.pdf

Barnett, E., & Casper, M. (2001). A Definition of « Social Environment ». *American Journal of Public Health*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.91.3.465a

Bloch, G. (s. d.). *Autisme · Inserm, La science pour la santé*. Inserm. Consulté 23 janvier 2023, à l'adresse https://www.inserm.fr/dossier/autisme/

Brian, J. (2019). *La prise en charge et le suivi du trouble du spectre de l'autisme une fois le diagnostic posé*. Société canadienne de pédiatrie. Consulté 16 janvier 2023, à l'adresse https://cps.ca/fr/documents/position/tsa-la-prise-en-charge-et-le-suivi

Caire, J.-M., & Schabaille, A. (2018). *Engagement, occupation et santé* (ANFE).

Canitano, R. (2007). Epilepsy in autism spectrum disorders. *European Child + Adolescent Psychiatry*. Consulté 21 janvier 2023, à l'adresse https://www.epilepsy.com/stories/epilepsy-and-autism-there-relationship

Canadian Association of Occupational Therapy (CAOT). (2017). *L'ergothérapie et le trouble du spectre de l'autisme.* Consulté 23 mai 2023, à l'adresse https://www.caotace.ca/document/4089/Autism%20-%20FS.pdf

Caron Santha, J. (2023). *Le guide du développement moteur de l'enfant 0-8 ans +*. Académie JCSI. Consulté 22 janvier 2023, à l'adresse https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/file-uploads/sites/21391/themes/2149533047/downloads/7ba3725-e038-7d0d-408-5f4dd7e5a02_josianecaronsantha.com_GM.V.06-01.2023.pdf

Chamak, B. (2012). La prise en charge de l'autisme : Le traitement médiatique. *Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence*, *61*(4), 231-235. Consulté 16 janvier 2023, à l'adresse https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961712018119

Chamak, B., & Bonniau, B. (2012). Les parcours des personnes autistes en France de 1960 à 2005 : Une étude rétrospective. *Deuxièmes rencontres scientifiques de la CNSA*. Aide à l'autonomie et parcours de vue. Consulté 16 janvier 2023, à l'adresse https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961712018119

Chapel, F. (2019). *Autisme et apprentissage de la propreté : Nos conseils*. Consulté 27 janvier 2023, à l'adresse https://www.autismeinfoservice.fr/accompagner/enfant/proprete

Chapel, F. (2019). *Gérer les particularités sensorielles d'un enfant autiste : Nos conseils*. Consulté 27 janvier 2023, à l'adresse https://www.autismeinfoservice.fr/accompagner/enfant/particularites-sensorielles

Chebli, S. (2017). *Trouble du spectre de l'autisme—NeuroSolution | Neuropsychologie*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://neurosolution.ca/trouble-spectre-autisme/

CHUSJ. (2020). *Les particularités et besoins sensoriels chez l'enfant présentant un TSA : Autisme au quotidien*. Consulté 22 mai 2023, à l'adresse https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme/Outils-et-conseils/Les-besoins-sensoriels

Claude, G. (2019, octobre 30). *L'entretien semi-directif : Définition, caractéristiques et étapes*. Scribbr. Consulté 21 février 2023, à l'adresse https://www.scribbr.fr/methodologie/entretien-semi-directif/

Cohen, D. (2002). Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. *Elsevier Masson SAS*, *70*(8), 401-456. Consulté 16 janvier 2023, à l'adresse https://www.em-consulte.com/revue/NEUADO/presentation/neuropsychiatrie-de-l-enfance-et-de-l-adolescence

Constantino, J., & Todd, R. (2000). Genetic structure of reciprocal social behavior. *Psychiatry*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.157.12.2043

CRAIF. (2018). *Les SESSAD autisme TED et TSA en Ile-de-France*. Consulté 19 janvier 2023, à l'adresse https://www.craif.org/sites/default/files/2020-03/livret-SESSAD%20Autisme.pdf

Crocq, M.-A., Guelfi, J.-D., Boyer, P., Pull, C.-B., & Pull, M.-C. (2015). *DSM-5—Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* (Elsevier Masson).

Debret, J. (2018, mars 6). *Entretien ou questionnaire—Quelle méthode choisir ?* Scribbr. Consulté 06 avril 2023, à l'adresse https://www.scribbr.fr/methodologie/entretien-ou-questionnaire/

DeGrace, B., Hoffman, C., Huston, T., & Kolobe, T. (2014, juillet). Families'experiences and occupations following the diagnosis of autism. *Journal of Occupational Science*, 309-321.

DeGrace, B. W. (2004). The everyday occupation of families with children with autism. *The American Journal of Occupational Therapy: Official Publication of the American Occupational Therapy Association*, *58*(5), 543-550. Consulté 27 janvier 2023, à l'adresse https://doi.org/10.5014/ajot.58.5.543

Delaisse, A.-C., Bodin, J.-F., Charret, L., Hernandez, H., & Morel-Bracq, M.-C. (2022). *L'ergothérapie en France : Une perspective historique*. deboeck supérieur.

Ergothérapeutes.net. (2022). Rééducation autisme par l'ergothérapie | Ergotherapeutes.net. *Ergotherapeutes*. Consulté 09 avril 2023, à l'adresse https://www.ergotherapeutes.net/autisme/

Genet, R. (s.d). *L'ergothérapie en libéral*. Consulté 19 janvier 2023, à l'adresse https://www.synfel-ergolib.fr/informations-ergotherapie/

Ha, C., Chin, F., & Chan Chee, C. (2020). Troubles du spectre de l'autisme : Estimation de la prévalence à partir du recours aux soins dans le système national des données de santé, France, 2010-2017. *Santé publique France*, 136-143. Consulté 16 janvier 2023, à l'adresse http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/6-7/pdf/2020_6-7_2.pdf

Handicap.gouv. (2023, mars 28). *La stratégie nationale autisme et troubles du neuro-développement | handicap.gouv.fr*. Consulté 23 mai 2023, à l'adresse https://handicap.gouv.fr/la-strategie-nationale-autisme-et-troubles-du-neuro-developpement

Hanneke van Bruggen. (2016). *Le vocabulaire de l'occupation—ENOTHE* [Conférence ENOTHE]. Consulté 22 janvier 2023, à l'adresse http://enothe.eu/Wordpress%20Documents/Galway/Conférence%20ENOTHE2016_05_03%20french%20version.pdf

Harrisson, B., & St-Charles, L. (2018). A-t-il des émotions ? In *L'autisme expliqué aux non-autistes* (Marabout, p. 111-112). Hachette Livre.

HAS. (2018). *Comment diagnostiquer le trouble du spectre de l'autisme chez l'enfant ?* Consulté 21 janvier 2023, à l'adresse https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/infographie_autisme_enfants_v2_2018-03-28_10-27-58_580.pdf

HAS. (2018). *Trouble du spectre de l'autisme : Signes d'alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l'enfant et l'adolescent*. Consulté 21 janvier 2023, à l'adresse https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent_-_argumentaire.pdf

Imbert, G. (2010). L'entretien semi-directif : À la frontière de la santé publique et de l'anthropologie. *Recherche en soins infirmiers*, *102*(3), 23-34. Consulté 21 février 2023, à l'adresse https://doi.org/10.3917/rsi.102.0023

Inserm. (2018). *Autisme · Inserm, La science pour la santé*. Inserm. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://www.inserm.fr/dossier/autisme/

Kielhofner, G. (2008). *Model Of Human Occupation* (Wolters Kluwer Health).

Kielhofner, G., & Forsyth, K. (2003). *Model of humain occupation* (Human occupation participation in life).

Labbé, A. (s. d.). *Diagnostic d'autisme ? Mode d'emploi des démarches à effectuer*. Comprendre l'autisme. Consulté 23 janvier 2023, à l'adresse https://comprendrelautisme.com/le-diagnostic-de-lautisme/les-demarches-du-diagnostic-dautisme/

Labbé, A. (s. d.). Les intérêts spécifiques : Définition et explication du fonctionnement. *Comprendre l'autisme*. Consulté 22 mai 2023, à l'adresse https://comprendrelautisme.com/le-fonctionnement/les-interets-specifiques/

Labbé, A. (2021). *Comprendre les stéréotypies chez l'enfant présentant un TSA*. Consulté 23 janvier 2023, à l'adresse https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/stereotypies/

Labbé, A. (2021). *L'hypersensibilité sensorielle chez l'enfant ou l'adulte présentant un trouble du spectre de l'autisme*. Consulté 23 janvier 2023, à l'adresse https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/hypersensibilite-sensorielle/

Labbé, A. (2021). *Le fonctionnement cognitif de la personne présentant un trouble du spectre de l'autisme*. Consulté 23 janvier 2023, à l'adresse https://spectredelautisme.com/trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa/fonctionnement-cognitif-de-la-personne-autiste/

Labbé, A. (2021). *Les routines et les rituels chez la personne vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA)*. spectredelautisme. Consulté 23 janvier 2023, à l'adresse https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/

Larousse. (2020). *Définitions : Communication—Dictionnaire de français Larousse*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communication/17561

Larousse. (2020). *Définitions : Hypersensibilité—Dictionnaire de français Larousse*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hypersensibilit%C3%A9/41086

Larousse. (2020). *Définitions : Hypoesthésie - Dictionnaire de français Larousse*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hypoesth%C3%A9sie/41184

Le Robert. (2007). *Le Petit Robert* (Dictionnaires Le Robert).

Lebaut, B. (2020). *À la maison | Craif—Centre de Ressources Autisme Ile-de-France*. craif.org. Consulté 27 janvier 2023, à l'adresse https://www.craif.org/la-maison-87

Maffre, T., Perrin, J., & Plumet, M.-H. (2013). Fonctions exécutives et autisme. In *Autisme et psychomotricité* (deboeck supérieur, p. 249).

Marquis, N. (2023, janvier 8). *Profil sensoriel de Dunn : Un outil pour améliorer son bien-être*. Consulté 26 avril 2023, à l'adresse https://dormeur.co/profil-sensoriel-de-dunn/

Meyer, S. (2013). *De l'activité à la participation* (1er édition).

Opar, A. (2017). Why children with « severe autism » are overlooked by science. *Spectrum news*. Consulté le 22 janvier 2023, à l'adresse https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/why-children-severe-autism-overlooked-by-science/

Potvin, M.-C., Prelock, P., & Savard, L. (2018). *Supporting Children with Autism and Their Families : A Culturally Responsive Family-Driven Interprofessionnal Process*. 47-57.

Pouhet, A. (2016). Connaître les dys- et en mesurer les enjeux. *Enfances & Psy*, *71*(3), 88-104. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://doi.org/10.3917/ep.071.0088

Ratel, H. (2012). Autisme, un scandale français. *Sciences et Avenir*, *782*, 5-10.

Rossini-Drecq, E., Bulgarelli, D., Rudelli, N., Di Fulvio, A., Cattelan, C., & Thommen, E. (2013). La cognition sociale chez l'enfant autiste : Les particularités de son développement, son implication sur la participation sociale et sa prise en charge en ergothérapie. *Ergothérapies*, *49*, 23-28.

Rossini-Drecq, E., & Sylvie Tétreault. (2020). *L'ergothérapie et l'enfant avec autisme de la naissance à 6 ans : Guide de pratique* (1ère édition). deboeck supérieur.

Selmi, F. (2014). La fratrie de l'enfant autiste. *Enfances & Psy*, *62*(1), 152-162. Consulté 27 janvier 2023, à l'adresse https://doi.org/10.3917/ep.062.0152

Sénéchal, C., & Rivières-Pigeon, C. (2009). Impact de l'autisme sur la vie des parents. *Santé mentale au québec*, *34*(1).

Service Public. (2023). *Mentions légales | entreprendre.service-public.fr*. Consulté 28 janvier 2023, à l'adresse https://entreprendre.service-public.fr/P10153

Sladana, P. (2017). *Haute Autorité de santé*.

Speranza, M., & Ferrari, P. (2012). Principales théroies du développement de l'enfant. In *Traité européen de psychiatrie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent* (Lavoisier, p. 3-11). Consulté 16 janvier 2023, à l'adresse https://www.cairn.info/traite-europeen-de-psychiatrie-et-de-psychopatholo--9782257205193-page-3.htm

Thommen, E., Cartier, B., Guidoux, A., & Wiesendanger, S. (2014). *Les particularités cognitives dans le trouble du spectre de l'autisme : La théorie de l'esprit et les fonctions exécutives*. *165*(8), 290-296. Swiss archives of neurology and psychiatry.

Vincent, C. (2012). L'accompagnement des personnes souffrant d'autisme reste insuffisant. *Le Monde*. Consulté 22 janvier 2023, à l'adresse https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/01/13/l-accompagnement-des-personnes-souffrant-d-autisme-reste-insuffisant_1629355_3224.html

Sommaire tableaux

Tableau 1 : Objectifs de l'enquête 23
Tableau 2 : Critères d'inclusion et d'exclusion des ergothérapeutes 24
Tableau 3 : Profil des ergothérapeutes interrogées 28
Tableau 4 : L'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères 29
Tableau 5 : La collaboration avec les parents 31
Tableau 6 : La définition de la participation occupationnelle 32
Tableau 7 : L'occupation la plus impactée 33
Tableau 8 : Les évaluations utilisées pour identifier les difficultés 34
Tableau 9 : Les moyens et les outils utilisés pour favoriser la participation 36

Sommaire nuages de mots

Nuage de mots 1 : Les évaluations utilisées pour identifier les difficultés 35
Nuage de mots 2 : Les moyens et outils utilisés pour favoriser la participation 37

Sommaire annexes

Annexe 1 : Notice d'informations I
Annexe 2 : Formulaire de consentement III
Annexe 3 : Guide d'entretien V
Annexe 4 : Grille d'analyse des entretiens IX
Annexe 5 : Retranscription entretien E2 XXVI
Annexe 6 : Questionnaire recherche d'ergothérapeute XXXVI

Annexe 1 : Notice d'informations

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de fin d'études, je vous propose de participer à une recherche, sous la direction de MME Pauline DESCAMPS, fondée sur des entretiens individuels.

Il est nécessaire de lire de manière attentive cette note d'information, qui vous offre toutes les informations nécessaires à la compréhension du déroulement de cette étude. Si, toutefois, vous êtes saisi(e) d'un doute sur tout ou partie de cette notice, je reste à votre entière disposition pour toute explication ou information complémentaire.

Cette recherche a pour objectif d'étudier l'impact que l'intervention de l'ergothérapeute au domicile peut avoir sur la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans la réalisation de ses activités de vie quotidienne.

La méthode mise en œuvre comprend une série d'entretiens semi-dirigés, d'une durée approximative **entre 30 et 45 minutes**. La durée prévisionnelle de recherche est de 8 mois (septembre 2022 à mai 2023). En consentant à participer à cette recherche, vous vous engagez à réaliser un entretien semi-directif. La date de celui-ci sera arrêtée en fonction de vos disponibilités. Un second entretien peut toutefois vous êtes proposé ultérieurement afin de préciser certains points.

Les entretiens seront enregistrés via une application sur smartphone sécurisée par un mot de passe, puis retranscrits et enfin analysés sur un ordinateur sécurisé lui aussi par un mot de passe.

En participant à cette recherche, vous contribuerez à une meilleure appréhension du rôle occupé par l'ergothérapeute dans l'accompagnement des enfants ayant des TSA sévères à domicile.

Votre participation nécessite toutefois votre disponibilité durant la durée complète de l'entretien. Les données recueillies, conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), seront traitées exclusivement par mon encadrante et moi-même.

Aucune information vous concernant ou données personnelles ne seront divulguées, sous quelque forme que ce soit.

Les résultats de cette recherche pourront être réutilisés dans le cadre d'un autre travail de recherche réalisé par la même équipe, ou une équipe différente.

Par la présente, vous consentez librement et de façon éclairée à participer à ce travail de recherche. Tout au long de celui-ci, vous pouvez demander des informations et des explications concernant le déroulement du protocole mis en œuvre.

Vous pouvez également à tout moment, et ce sans qu'il ne puisse être recherché votre responsabilité, vous retirer du protocole auquel vous avez initialement consenti sans délai de préavis. Dans ce cas, les données collectées jusqu'à votre retrait effectif seront utilisées pour l'analyse des résultats à la recherche.

À l'issue de la recherche, il vous est possible d'obtenir la communication des résultats par demande réalisée par lettre simple ou courriel. Ceux-ci vous seront alors adressés par retour de courrier ou courriel sous une quinzaine de jours.

Si vous acceptez de participer à la recherche, il est nécessaire que vous apposiez votre signature précédée de la mention « lu et approuvé » sur le document joint, que vous aurez préalablement daté.

Annexe 2 : Formulaire de consentement

Consentement dans le cadre d'un mémoire de recherche

Objet de l'accord : Autorisation à réaliser un entretien auprès de MME/MR…
Motif : Réalisation d'une recherche dans le cadre d'un mémoire de fin d'étude en ergothérapie.
Période : mars, avril, mai 2023

Article 1 : La présente convention règle les rapports entre ;
Madame Garance HAUCK, résidant au 14 rue Marius Delcher 94220 Charenton-le-Pont et étudiante en ergothérapie à l'IFE de Créteil UPEC, 80 avenue du général de Gaulle 94000 Créteil.
Et Madame/Monsieur, ergothérapeute DE exerçant à ……

Article 2 : Le présent document définit les règles de l'accord suivant lesquels se dérouleront les temps de présence de MME Garance Hauck auprès des personnes. Il définit aussi l'usage des informations qui seront recueillies par MME Garance Hauck lors de sa présence auprès des personnes.

Article 3 : MME Garance Hauck réalise ce travail d'investigation dans le cadre de son mémoire de fin d'étude ayant pour objet d'études *« L'impact de l'intervention de l'ergothérapeute au domicile de l'enfant ayant des troubles du spectre autistique sévères sur sa participation occupationnelle, dans ses activités de vie quotidienne. »* Ainsi, l'objectif fixé est de pouvoir recueillir une quantité non déterminée de données empiriques dont l'analyse sera à même d'offrir des éléments de compréhension sur la/les occupation(s) dans laquelle/lesquelles la participation est la plus impactée chez l'enfant ayant des TSA sévères. Ainsi que, les moyens et les outils pouvant être mis en place afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant à domicile.

Article 4 : MME Garance Hauck signe cet accord à titre individuel. La responsabilité de l'IFE – UPEC ne saurait être visée.

Article 5 : MME Garance Hauck reconnait avoir souscrit un contrat de RESPONSABILITE CIVILE auprès de la GMF, société d'assurance dont le siège est situé à Créteil.

Article 6 : Dans le cadre de cette recherche, et pour s'assurer d'une récolte efficace des données empiriques, MME Garance Hauck utilisera des modalités d'enregistrement audio.

Article 7 : Les documents de synthèse écrits par MME Garance Hauck (mémoire, article, chapitre d'ouvrage, présentation en séminaires et conférences, etc.…) seront entièrement anonymisés, si bien qu'aucune information ne permettra d'identifier les personnes ayant participé à ce travail de recherche.

Article 8 : MME Garance Hauck s'engage à faire parvenir en temps voulu et selon le désir des personnes, un exemplaire de son mémoire finalisé. Selon les désirs des personnes et des professionnels, et les possibilités de MME Garance Hauck, une communication de son travail pourra être envisagée. Relevant des articles L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, aucun autre droit sur le travail de recherche de MME Garance Hauck ne pourra être recherché.

Document établi en 3 exemplaires à Créteil le 04 avril 2023

LU ET APPROUVE

M/Mme *étudiant* Ergothérapeute D.E

Signature *Signature*

Annexe 3 : Guide d'entretien

Légende des thématiques :

- Présentation professionnelle
- Prise en soin pluridisciplinaire et lien avec la famille
- Participation occupationnelle
- Activités de vie quotidienne

Thèmes	Sous-objectifs	Question de première intention	Questions de relance
Présentation professionnelle	Connaître les personnes interviewées.	Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel ?	Depuis quand êtes-vous diplômé ? Depuis combien de temps exercez-vous auprès d'enfants ayant des TSA ? Dans quel établissement exercez-vous en ce moment ? Rencontrez-vous beaucoup d'enfants ayant des TSA ? Plutôt de quel degré de sévérité ? Quelle tranche d'âge ?
Prise en soin pluridisciplinaire et lien avec la famille	Identifier les personnes qui vont être présentes de la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères. Identifier l'importance de la prise en soin pluridisciplinaire auprès de cette population.	Pouvez-vous me dire les personnes avec lesquelles vous travaillez lors de la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères ?	Pour vous, en quoi la prise en soin pluridisciplinaire va être importante dans l'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères ?
	Connaitre l'importance du rôle et de la place de la famille dans la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères.	D'après vous, comment en tant qu'ergothérapeute nous pouvons travailler avec les parents dans la prise en soin d'un enfant ayant des TSA sévères à domicile ?	Comment les intégrez-vous lors des séances ? et à quelle fréquence ? Comment intervenez-vous auprès des parents pour faciliter les soins personnels des enfants ayant des TSA à domicile ?
	Identifier les facteurs permettant la participation d'un enfant	Pour vous, qu'est-ce que la participation occupationnelle ?	D'après vous, comment obtient-on la participation d'un enfant ayant des TSA sévères à domicile ?

Participation occupationnelle	ayant des TSA sévères dans ses occupations. Identifier la/les occupation(s) dans laquelle/lesquelles la participation de l'enfant va être la plus impacté.		Selon vous, dans quelle(s) occupation(s) la participation de l'enfant ayant des TSA sévères va être la plus impacté ?
Activités de vie quotidienne	Recenser les évaluations utilisées par les ergothérapeutes permettant de faire émerger les difficultés occupationnelles de l'enfant dans ses activités de vie quotidienne.	Quelles évaluations faites-vous pour identifier les difficultés occupationnelles de l'enfant ayant des TSA sévères lors de la réalisation de ses activités de vie quotidienne ?	Passez-vous des entretiens pour évaluer les difficultés occupationnelles ? Réalisez-vous des mises en situations écologiques ? *(Au lieu de vie de la personne)*
	Identifier les difficultés que l'enfant ayant des TSA sévères peut rencontrer dans chacune de ses activités de ses activités de vie quotidienne. Faire émerger les moyens, les outils ainsi que les approches pouvant être mis en place afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans activités de vie quotidienne.	D'après vous, quelles difficultés vont rencontrer les enfants ayant des TSA sévères lors de la toilette ?	Quels moyens pouvez-vous utiliser afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans cette activité ? *(Aides humaines, techniques, visuelles, guidage verbal…)* Quels outils pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation de l'enfant lors de la toilette ? Quelles approches pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation occupationnelle de l'enfant ? *(Intégration sensorielle…)*
		D'après vous, quelles difficultés vont rencontrer les enfants ayant des TSA sévères lors du brossage de dents ?	Quels moyens pouvez-vous utiliser afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans cette activité ? *(Aides humaines, techniques, visuelles, guidage verbal…)* Quels outils pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation de l'enfant lors du brossage de dents ? Quelles approches pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation

			occupationnelle de l'enfant ? *(Intégration sensorielle…)*
		D'après vous, quelles difficultés vont rencontrer les enfants ayant des TSA sévères lorsqu'ils se rendent aux toilettes ?	Quels moyens pouvez-vous utiliser afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans cette activité ? *(Aides humaines, techniques, visuelles, guidage verbal…)* Quels outils pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation de l'enfant lorsqu'il souhaite se rendre aux toilettes ? Quelles approches pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation occupationnelle de l'enfant ? *(Intégration sensorielle…)*
		D'après vous, quelles difficultés vont rencontrer les enfants ayant des TSA sévères lors de l'habillage ?	Quels moyens pouvez-vous utiliser afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans cette activité ? *(Aides humaines, techniques, visuelles, guidage verbal…)* Quels outils pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation de l'enfant lors de l'habillage ? Quelles approches pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation occupationnelle de l'enfant ? *(Intégration sensorielle…)*
		D'après vous, quelles difficultés vont rencontrer les enfants ayant des TSA sévères lors de la prise de repas ?	Quels moyens pouvez-vous utiliser afin de favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans cette activité ? *(Aides humaines, techniques, visuelles, guidage verbal…)* Quels outils pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation de l'enfant lors de la prise de repas ? Quelles approches pouvez-vous utiliser pour favoriser la participation

			occupationnelle de l'enfant ? *(Intégration sensorielle…)*
	Identifier les possibles causes des difficultés rencontrées par l'enfant présentant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne.	Selon vous, par quoi peuvent s'expliquer les difficultés rencontrées par l'enfant ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne ?	Par des particularités sensorielles et/ou motrices ? Par des difficultés émotionnelles et/ou comportementales ? Ou encore par des troubles cognitifs ?
	Comprendre l'utilité de l'utilisation d'une approche dans la prise en soin d'un enfant avec des TSA sévères.	Si vous utilisez une approche dans votre pratique, comment la prenez-vous en compte lors de vos interventions ?	L'utilisez-vous dans vos observations ? *(Si oui comment ?)* Comment cette approche vous permet de mieux comprendre les réactions de l'enfant ?
Ouverture		Avez-vous autre chose à ajouter ?	

Annexe 4 : Grille d'analyse des entretiens

Légende des thématiques :

Prise en soin pluridisciplinaire et lien avec la famille

Activités de vie quotidienne

Participation occupationnelle

Éléments nouveaux dans les entretiens

Sous-thèmes	E1	E2	E3
L'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères	« Ah bah du coup y'a les parents, qui sont hyper importants dans la prise en charge puisque ce sont des mineurs et que ça se passe au domicile donc tout passe par les parents. Et c'est eux qui après permettent à ce que la prise en charge elle puisse vraiment avoir des bénéfices puisque c'est eux qui accompagnent les jeunes au quotidien en fait. » « Après il y a les éducatrices, les référentes des jeunes qui en fait connaissent le mieux le jeune au niveau de la structure. Après il y a la psychologue aussi du service et l'assistante sociale et chef de service fin fonctionnement d'un établissement, d'une structure. » « Après il y a tout ce qui est au niveau de l'enseignement. Y'a ça et tout ce qui est AESH qui les accompagnent. »	« Alors moi je sais que c'est des enfants qui sont suivis, beaucoup en structure, donc, je travaille beaucoup avec les éducatrices qui sont en lien avec bah directement avec avec l'enfant. Je travaille beaucoup avec les éducatrices et avec les psychomotriciennes sur le secteur. Les premières avec qui je vais travailler, c'est vraiment éducatrices et psychomotriciennes, vraiment, c'est les, c'est les 2 points forts. Après, j'avoue qu'il y a aussi les les psychologues, mais ça arrive vraiment en 3e position largement. » « Ah oui bah clairement les moi je oui, j'avoue je les oubliés c'est pardon oui avec la famille, clairement hein. J'avoue que ouais avec les parents j'ai un j'ai des forts liens qui se sont créés. Pas nécessairement avec les frères et sœurs, avec les parents oui. Ouais, plus avec les parents ou les grands-parents qui les amènent. » « Et encore, après, il y a aussi on n'en parle pas assez mais y a des taxis aussi qui me les emmènent et c'est vrai qu'ils ont un rôle important. On ne va pas, voilà, c'est eux qui font le lien. Quand les parents ne peuvent pas se déplacer, c'est eux qui font lien avec les parents. Donc il ne faut quand même pas les oublier, ces Messieurs Mesdames qui nous les emmènent toutes les semaines au cabinet ou voilà	« Alors je vais faire dans l'ordre de de priorité. Je travaille énormément, énormément, énormément avec les éducateurs référents des enfants. » « Et en 2e, et en fait un petit peu au même niveau, c'est juste que je les vois moins à certains moments de la prise en soin, c'est les parents, la famille. » « Et éducateur référent et parents au même niveau. Un peu avec le docteur pour tout ce qui est administratif, le médecin, je mettrai la psychologue au même niveau. Et au SESSAD les psychologues ont tendance à avoir une fonction plutôt de coordination des soins que de que d'accompagnement thérapeutique. Je donc voilà, on se réfère à eux plutôt pour des questionnements sur le fonctionnement, sur l'admission, sur l'a mise en place de tel ou tel outil mais voilà plutôt pour des questionnements de coordination. Et après je travaille pas mal avec la psychologue aussi, mais c'est c'est, c'est parce qu'on s'entend bien aussi, mais on travaille pour se mettre en accord, sur les objectifs, pour se mettre en accord, sur la façon dont on travaille avec tel ou tel enfant. » « Ok donc ouais, dans l'ordre de priorité, éducateur, famille, médecin, psychologue et un peu psychologue. Et du coup si j'imagine que s'il y avait une

		donc ouais après avec les parents, clairement les parents ils ont un rôle très important. Je trouve que en fait, sans eux enfin, le travail n'est pas le même parce que bah c'est eux qui font la boucle entre professionnels, tous les professionnels et puis bah leur environnement avec bah leurs enfants et leur quotidien. » « Ah oui, parce qu'il y a nous y a les professionnels, y a les parents et y a aussi l'école parce que bah ce n'est pas que les enseignants etc. Enfin, on fait vachement enfin c'est les parents en fait, qui font le lien entre nous et tout ce monde-là. Donc bah sans sans eux bah il n'y a rien quoi clairement hein, quand y a pas de dialogue avec les parents bah y a rien qui se fait derrière. »	orthophoniste je la mettrais à ce même niveau aussi quoi. »
Les aidants - plateforme de répit	« Après pour certains il y a la plateforme de répit aussi, c'est une plateforme qui propose en fait des temps de répit en fait c'est à destination plutôt des aidants et qui proposent des temps de répit donc avec des activités par exemple jeux de société, patinage enfin ce genre de choses. »		
L'importance de la prise en soin pluridisciplinaire	« Parce que chacun on a notre manière de, de comment dire, de voir le jeune aussi et puis nos visions elles sont complémentaires ce qui permet de lui apporter la meilleure réponse en fait. Fin la meilleure, la plus adaptée à ses besoins et d'avoir toujours le même fil conducteur en fait. Et puis le même discours face aux parents et puis vraiment d'être une équipe face aux parents. »	« Alors pour moi, un enfant qui est TSA sévère, il a tellement d'impact dans sa vie quotidienne qu'alors oui, l'ergo à un super rôle hein, mais en fait on a un moment où notre, personnellement, moi je les vois que 45 minutes à une heure par semaine, je je ne peux pas tout faire clairement à un moment, je pense que les éducateurs les, enfin voit l'enfant plus, en plus, c'est des gens qui vont à l'école. Peut-être que moi je ne peux pas y aller. Peut-être que voilà, il y a plein d'autres choses ou que moi je ne pourrais pas faire par	« Elle est importante pour pleins de choses, mais j'espère que je ne vais pas en oublier. Surtout, elle est importante, déjà parce que les personnes avec autisme, elles ont des difficultés de généralisation des acquis et donc le fait de travailler vraiment en équipe. Ça va permettre bah de généraliser plus facilement les acquis dans un domaine, dans tous les espaces et l'enfant côtoient au quotidien. » « Et c'est toujours plus simple pour les l'apprentissage, en tout

		manque de temps. Et je sais qu'eux le font parce qu'ils ont des plages horaires dans leur planning vu qu'ils sont dans des structures. C'est complètement différent, c'est une organisation qui est complètement différente, mais en fait eux je trouve ça hyper important parce que c'est eux qui limitent des fois, qui m'enrichissent, qui me disent *« Bah ça, ça n'a pas été. Est-ce que tu peux travailler avec un tel sur telle activité parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas à l'école. »* Et ce n'est pas dans mon champ de compétence donc, *« Est-ce que toi tu as des idées ? »* et c'est vraiment un un, c'est un enrichissement. En fait, je trouve de travailler avec tout ce monde-là, parce qu'on a tous nos casquettes et tout le monde va travailler quelque chose va voir quelque chose, mais en même temps, on va tous se se concerter. Et pour travailler d'un commun accord avec pour pour que les objectifs de l'enfant ils soient, ils soient, ils soient atteints et c'est vrai que bah ouais, par manque de temps par manque de plein de choses ; ben c'est bien d'avoir tout ce monde-là autour de l'enfant pour qu'il puisse voilà pour qu'il puisse s'épanouir autant qu'il qu'il puisse après, des fois ça arrive que ça soit différent. Mais dans la majorité des cas, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce lien avec tout le monde quoi, qu'on travaille tous ensemble pour l'enfant, vraiment. »	cas, d'uniformiser les pratiques. D'accélérer un peu l'apprentissage aussi j'imagine. Et ben en fait travailler en équipe aussi, dans l'élaboration des outils, ça permet d'avoir la l'expertise de chacun et du coup d'avoir des outils aussi qui sont beaucoup plus performants sur le terrain que si on travaille vraiment tout seul de son côté avec sa seule expertise, ça peut finalement se retrouver être un réel biais à l'accompagnement de l'enfant. »
L'accompagnement de l'enfant ayant des TSA sévères	« Et j'ai oublié dans les professionnels, y'a les professionnels libéraux aussi. Psychomot etc, qu'on n'a pas forcément sur le service. »		« Juste, c'est. Et dans les partenaires aussi, il y a les professeurs. Ils sont importants et les AESH du coup aussi. Du coup je mettrai là je ne sais pas à

			quel niveau je les mettrai, ça dépend des situations en fait. » « Comme ça, je les mettrai au niveau de la psychomotricienne, mais en fait, selon les moments, il y a des moments où ils ont beaucoup plus besoin de nous en tant qu'ergo, on a qu'à d'autres moments, en fait, c'est plutôt auprès de ces de ces professionnels-là, c'est plutôt des interventions ponctuelles que sur le long terme. »
Collaboration avec la famille	« Pour l'instant, les parents, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des séances avec eux. Hormis quand c'est par exemple des observations du quotidien. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, y'a pas eu par exemple de guidance parentale. »	« Alors moi je sais que les parents, ils sont intégrés à la séance. Certains parents peuvent très bien participer à la séance ou des fois j'arrête la séance dix minutes avant et je leur explique *« bon bah on a fait ça ça, ça ça il faut que vous fassiez ça ça, ça ça à la maison du coup »* et je leur donne des petits, des conseils, etc ou des outils. Je leur dis, *« Bah écoutez, je vous prépare quelque chose, je vous l'envoie par mail et vous travaillez à la maison. »* Et c'est vrai que bah les parents, moi je les intègre largement parce que c'est des parents qui ont eu des parcours de soins assez compliqués. Avec des enfants des fois qui sont diagnostiqués très tard et qui n'ont pas eu toutes ces aides dès le départ et qui sont, des fois ils culpabilisent, ils sont complètement perdus. Et c'est vrai que de les intégrer, ça les valorise et ils sont super contents et je je ne me vois pas les enlever de la séance. Alors y a des parents qui ne veulent pas du tout assister à la séance parce que les enfants c'est encore pire. Mais je trouve que ça reste quand même super important. Moi je sais que bah dans quasiment toutes les séances avec des des enfants TSA sévères, ils sont tout le temps-là	« Avec les parents ? Alors en début de prise en soin, quand j'accueille les enfants, soit ils arrivent à l'IME, soit ils arrivent au SESSAD, soit on me dit *« Là, il va falloir que tu voies cet enfant là parce qu'on se pose des questions sur telle telle chose. ».* Généralement, j'envoie un questionnaire à la famille pour qu'il y ait un un aperçu de ce que c'est que l'ergothérapie, l'ergothérapie de ce que moi je fais avec les enfants à l'IME. Parce que c'est des familles, généralement, qui ont un niveau social assez faible. Je dis généralement c'est, ça veut dire qu'il y a des familles, ce n'est pas le cas, mais la majorité des familles en tout cas que je côtoie, c'est le cas. Donc j'ai fait en sorte que ce soit accessible et c'est un questionnaire qui reprend donc les habitudes de vie dans les loisirs, dans la scolarité et dans la vie quotidienne, plutôt les soins, l'habillage etc. Pour avoir moi déjà un premier aperçu de ce que veut l'enfant, de ce que veut les parents, ce que veulent les parents. Et voilà comme dans l'OTHope que vous devez utiliser là en libéral. Je demande aux aux parents quelles sont les priorités pour eux dans l'accompagnement, quels sont

		tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça et ben ils voient, ils voient ce qu'on fait en séance et ils me disent « Ah bah du coup ça, je peux le faire à la maison, ça, je peux le faire à la maison. » Et du coup, le lien se crée vraiment. En disant *« Bah oui, OK d'accord, bah vous m'avez dit ça donc j'ai fait ça. »* comme ça on peut en discuter des situations de problème que bah en 5 minutes avant la séance ils ne peuvent pas m'expliquer, que quand je fais quelque chose ils disent *« Ah bah oui, ça c'était problématique est-ce que vous pouvez le travailler ? ».* Et on fait vraiment des liens avec, bah avec les parents du coup. »	leurs problèmes principaux rencontrés. Donc ça me donne une première image de l'enfant et de ce sur quoi je dois axer l'accompagnement. Ensuite, je rencontre l'enfant et c'est l'étape qu'on appelle le PEERING en dans le milieu de l'autisme, c'est l'étape où on crée la relation. Donc on est beaucoup dans du jeu dans les centres d'intérêts de l'enfant, c'est pas du tout des séances et c'est en ça que le libéral, ça me bloquait complètement c'est que bah c'est des séances qui sont financées par les les parents et du coup bah c'est des séances où on se veut rentable et donc on veut attaquer tout de suite sur les objectifs et en fait en en établissement on a beaucoup plus eu le temps de créer cette relation avec l'enfant qui est très important pour la suite, notamment pour définir les renforçateurs etc. Voilà, je les rencontre au moins pour le le le début de l'accompagnement de l'enfant et puis après je j'essaie de maintenir le lien. Il y a des familles qui souhaitent pas du tout, ils mettent leur enfant le matin dans l'institut et puis ils viennent le chercher le soir et ça ils ne souhaitent pas trop développer ça parce qu'il y a toutes les étapes du deuil de l'enfant idéal et qui ne sont pas encore accomplis. Aussi et des familles qui sont très demandeuses de plein de choses et dès qu'elles rencontrent une difficulté à la maison, elles reviennent vers moi *« On a voulu faire tel jeu ce week-end et on s'est aperçu que c'était super compliqué. Comment on peut l'aborder ? Comment on peut l'adapter ? »* Donc voilà, c'est très dépendant des familles avec lesquelles on interagit. Mais dans l'idéal, j'essaie de les rencontrer

			minimum une fois tous les 2 ans donc le minimum, c'est pour les familles avec qui justement le contact est compliqué. »
L'intervention auprès des parents pour faciliter les activités de vie quotidienne		« Je fais beaucoup de mises en situation et je sais que bah la maman qui est aussi à domicile à à ce moment-là, fait beaucoup de photos films et en fait elle elle fait plein de carnets, etc. Et c'est vrai que bah forcément, elle est elle est intégrée et j'essaie de donner des conseils en même temps, quand elle filme etc. »	
Définition de la participation occupationnelle	« Alors, j'ai complétement oublié mes définitions de y'a deux ans, on ne va pas se mentir. (…) La participation occupationnelle, on va simplifier. Je pense que c'est la participation qu'à le jeune dans les activités, dans ses activités quotidiennes. Mais elles sont, parfois elles sont, ce sont des activités qui sont en co-occupation aussi avec les parents ou avec par exemple l'AESH. Ce n'est pas des occupations qui va qui va faire seule en fait puisqu'il n'y a pas, y'a l'autisme sévère qui fait que seul il ne participerait à rien en fait. »	« Moi, je dirais que ça, c'est en lien avec son rôle occupationnel après tout ce qui est participation sociale aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile à expliquer. J'avoue, vous me posez un peu une colle. Ce qui participation occupationnelle, c'était comment il arrive à à faire, à réaliser ses occupations de manière optimale. Je pense. C'est ouais ça ça me semble à peu près correct. »	« Mais pour moi, c'est la participation de l'enfant dans tous les domaines de la vie quotidienne, donc que ce soit les loisirs, les soins personnels, la scolarité, ça peut être aussi le travail parce qu'il y en a qui commencent à aborder une vie professionnelle. Et en fonction de ce qu'en fonction de sa satisfaction à lui, quoi de ses déterminations en ce moment. Voilà, je dirais que c'est la participation de l'enfant dans les activités qui lui plaisent. »
L'occupation la plus impactée	« Là, je dirai la problématique la plus importante c'est le repas. Avec, du coup tout ce qui est troubles… Bah déjà parce que c'est une activité qui revient régulièrement. C'est en moyenne, on fait ça 3 fois par jour hein, (…) parce que c'est quelque chose qui tient aussi à cœur aux parents et c'est là qu'ils se sentent le plus démuni quand l'enfant est… Fin parce que dans l'autisme il y a beaucoup de sélectivité alimentaire aussi, qui fait que les parents se sentent vite	« Pour moi, ça va être tout ce qui va être lié au sensoriel. Donc bah tout ce qui va être soin soin personnel au niveau de la douche. » « Tout ce qui est même alimentation tout en fait, pour moi tout ce qui va être lié au sensoriel, parce que ces des enfants qui sont hypersensibles. Et et du coup, bah c'est vrai que bah tout ce qui va être lié bah à la sphère orale ça va être compliqué tout ce qui va être tactile ça va être hyper compliqué. Donc bah	« Moi je suis très sollicitée par les parents qui ont des enfants en situation de TSA sévère pour, je dirais, l'autonomie, mais particulièrement pour l'autonomie dans les soins personnels, que ce soit le brossage de dents, que ce soit la toilette et que ce soit l'habillage j'englobe les 3 parce que c'est vraiment les les 3, ces 3 demandes qui reviennent le plus fréquemment. Mais moi, ce que j'observe, c'est surtout les loisirs en fait, parce que, Eh ben en fait, c'est des, c'est des enfants qui

	démunis et c'est un questionnement qui revient régulièrement. » « Après bah tout dépend si on considère que, fin parce que les loisirs ils n'en ont pas forcément, parce que ça ne s'exprime pas réellement. Plutôt, ce qu'on en comprend, alors que par exemple les soins personnels c'est quelque chose qu'on va leur imposer mais ils sont aussi en difficultés. »	s'habiller ça va être compliqué que certaines textures, manger ça va être compliqué parce que bah qu'une texture aussi ou que certains aliments et pas d'autres. Pour moi c'est ça qui est le plus compliqué pour les parents (…). » « Et puis tout ce qui est soin personnel au niveau de la, la gestion de l'autonomie à la toilette. Enfin, tout ça, c'est… C'est ce qui pour moi, c'est les plus gros, le sensoriel et ben je ne sais pas si c'est pour vous, ce sera une activité, mais tout ce qui va être amené au sensoriel et à la toilette. »	ont un TSA assez sévère, qui ont une restriction de loisirs énorme. Et en fait, Eh ben c'est un impact énorme aussi sur tous les autres apprentissages, parce que quand on est motivé que par faire des lumières que par voir des lumières et bah forcément on ne s'intéresse pas à d'autres choses et du coup on ne développe pas les compétences qui nous permettent de de de ben d'écrire parce qu'on s'en fiche d'écrire pour eux, mais de de de manipuler des choses et du coup ça ça engendre en tout cas, ça a un impact dans dans plein d'autres domaines. »
Comment obtient-on la participation ?	« Y'a tout ce qui est mise en place aussi de la communication alternative. Par exemple le pointage, PECS, Makaton fin ou les prémisses en fait ; juste associer un objet, à une activité une tâche pour que le jeune puisse aussi essayer d'exprimer ses choix. Mais c'est vrai que c'est compliqué au quotidien et c'est en fait de les, je pense les solliciter régulièrement pour qu'ils puissent (…) trouver les activités qui leurs sont plaisantes, je ne sais pas, mais qui leurs correspondent le mieux. » « Après il y a tout ce qui est mise en place de séquentiel. Il y a tout ce qui est bah expliquer, sensibiliser les parents à tout ce qui est aussi guidance verbale et physique. En fait, un petit peu de la guidance parentale. Et puis, fin en fait, bah réaliser les activités dans le contexte environnemental et écologique du jeune. »	« Sa motivation. Je pense à motivation à l'activité après aussi son comment dirais-je, son à l'instant T est-ce qu'il est capable d'entendre les conseils ? Est-ce qu'il veut bien faire aussi y'a ça ? Si c'est un bon, c'est un bon jour ou pas, hein ? En fonction d'une situation… Et après de donner bah peut être des choses plus ludiques, je ramène toujours au jeu, hein, de toute façon. Tout ce qui va être travail au niveau de la participation, de la participation, ça va être bah forcément revenir au jeu, de la motivation pour que bah il se crée voilà se créer des liens avec bah ces activités de la vie quotidienne. »	« C'est de tout passer sur le centre d'intérêt restreint. Des fois, pour favoriser l'apprentissage, même si bah le centre d'intérêt restreint comme on le dit, il restreint beaucoup de choses au niveau de la socialisation, au niveau des manipulations, au niveau de pleins de choses. Si on veut qu'il y ait un apprentissage au début, il faut forcément passer par là. Et on a de la chance, on met des supers psychologues qui font systématiquement des évaluations des renforçateurs donc selon la méthode ABA et donc on sait pour tel enfant quel renforçateur est le plus puissant à utiliser et souvent le le renforçateur il a un lien direct avec le centre d'intérêt restreint. »
	« En fait, si vous voulez, les référentes des jeunes qui me	« Alors moi je fais beaucoup passer l'OT'Hope je ne sais pas si	« Je commence un petit peu le bilan et là ça dépend des enfants,

Les évaluations	disent *« tiens là je pense qu'il y aurait un besoin pour toi etc. ».* Donc là en général, je fais un bilan ou j'échange avec les parents aussi sur l'évaluation des activités de vie quotidienne, ou je regroupe un petit peu toutes les… enfin l'alimentation, l'habillage/déshabillage, la toilette etc. Mais c'est plus quelque chose de fabrication maison. » « Voir les difficultés que le parent repère du coup ou qui peut repérer à la suite de l'échange, en échangeant il se rend compte que *« ah oui effectivement là il y a quelques difficultés »* ». « On peut faire des mises en situations écologiques oui également, avec des petites grilles. On a quelques grilles là sur le service, mais c'est pour en fait structurer notre observation. »	vous connaissez ? Voilà donc qui est quand même bien bien rapproché du MCRO, j'ai fait passer récemment la MCRO justement à bah au grand que je suis aussi, que je suis à la maison. Et j'ai passé oh, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises… Il me semble que j'ai passé une MHAVIE ou un truc comme ça ? » « Et oui, bien sûr, je, pour je fais une grosse anamnèse hein de toute façon (…) Mais c'est vrai que oui, je je discute avec les parents, je leur demande *« Bah voilà telle activité par exemple repas comment ça va pour manger, couper sa viande etc. »* Et en fait je détaille brossage de dents et en fait ils me disent, ils me disent *« Bon bah ça a été ça n'a pas été ça, ça ne va pas, qu'est ce qui ne va pas… »* et on en discute en fait. »	soit je fais le bilan et je demande aux parents de venir à la première séance. Soit, je fais le bilan toute seule dans mon coin quand je vois que c'est des des parents qui ont des difficultés à communiquer à cause de la langue française et du coup je les fais venir pour la restitution du bilan où je simplifie clairement les choses. Je leur remets le contre rendu papier que qui est toujours difficile à adapter, et c'est la grosse problématique en ergothérapie. Mais je leur remets le compte-rendu papier et je leur explique au moins les objectifs d'accompagnement. » « Alors j'ai bah, dans les soins personnels, bah, l'outil OTHope. Du coup y a y a la case soin personnelle donc je l'utilise. Mais après, je trouve que ce n'est pas assez développé pour…, en tout cas pour les niveaux TSA sévères dont vous parlez. Je trouve que l'outil il n'est pas assez développé pour ces niveaux là parce que c'est des choses de de bas niveau en fait, sur lesquels ils sont encore en difficulté et ça évalue que la qu'une grande grande tâche finalement, avec pleins de sous taches comprises dedans. Donc et en fait j'ai construit des grilles de d'analyse d'activité et en partenariat beaucoup avec les stagiaires que j'accueille. Donc c'est des grilles d'analyse d'activités qu'on construit maison. Donc voilà et puis, et bah pareil après, je transmets la grille d'analyse à la famille. Selon le niveau, je l'adapte ou pas et des fois, quand c'est trop compliqué pour la famille de répondre à ce questionnaire, sur cette grille, je leur demande de venir faire une mise en situation à la maison en leur expliquant bien qu'il faut

			qu'ils fassent comme si je n'étais pas là. »
Les difficultés pour la toilette	« Comme vous avez dit la, le fait de se laver le corps et plus particulièrement la tête peut poser peut-être une difficulté mais aussi dans tout ce qui est régulation de la température de l'eau puisqu'il n'y a pas forcément la même la même le même traitement de la température de l'eau que nous. Après y en a beaucoup qui ont du mal avec les quantités aussi qui ont des beaucoup de stéréotypies avec l'eau même par exemple qui face à un…, c'est pas forcément sous la douche mais face à un labo qui est allume - éteigne - allume éteigne… un nombre incalculable de fois le robinet. »	« Voilà pour tout ce qui est mettre de l'eau sur le corps, le savon, la gestion de du savon dans les cheveux. Et après, on est quand même aussi sur des enfants qui ont des problèmes de coordination hein. Donc bah se laver les cheveux c'est hyper compliqué quand même, hein, le mouvement etc. Se laver tout le corps, bien se savonner partout, on n'est pas non plus sur des choses qui sont optimales optimales. Mais le premier truc, c'est vraiment tout ce qui est sensoriel »	« La problématique principale, toujours si je reste centrée sur les enfants avec un TSA sévère, c'est l'enchaînement des étapes. Le le fait de de pas de pas persévérer sur se laver, le bras, se laver le bras, se laver le bras, se laver le bras et de passer à se laver l'autre bras, ça s'est compliqué. Là, je dirais ça en numéro un comme difficulté principale. Après, on est en difficultés cognitives, on va dire le fait d'enchaîner les étapes. En difficultés sensorielles, je dirais le contact avec l'eau et le contact avec la salle de bain parce que c'est un espace assez particulier la salle de bain. Et en difficulté motrice eh ben je dirais que c'est le domaine où y a le moins de difficultés finalement, pour la douche, les enfants TSA avec un TSA sévères. »
Les moyens, les outils et l'approche utilisés pour la toilette	« Bah beaucoup de de guidance verbale en verbalisant attention la température de l'eau mais sans forcément faire à la place du jeune en fait. » « Ben il y a tout ce qui est bon après il n'y a pas forcément un outil tel quel mais le travail en amont du schéma corporel. Après ça peut être conjointement ce n'est pas qu'en ergothérapie mais ça peut travailler aussi avec les les éducatrices référentes. Et même la psychologue et travailler en séquentiel donc ça c'est plutôt aussi en lien avec la psychologue qui va dire dans dans quel sens le chaînage vertical horizontal et selon quelles modalités on passe d'une étape à une autre. Et on a par exemple c'est mettre enlever un picto, d'autres ça va être déplacer une pince à linge.	« Après moi je sais que je dis aux parents de faire tel ou tel rituel, voilà. *« Vous faites un bon massage avant d'y aller, vous faites une grosse pression sur le corps et puis après vous pouvez aller à la douche et vous refaites pareil après. ».* Après c'est plus des petits outils que je peux, je peux leur donner. Après je sais que je travaille beaucoup avec tout ce qui est picto, on séquence la tâche, *« tu dois faire ça, ça, ça, non ça ne va pas te faire mal aux yeux. »* etc. On travaille enfin, j'essaie de rassurer du mieux que je peux. Après pour les moyens donc picto je dirais et et puis bah aide orale entre guillemets pour les parents, pour pour les aider, pour pour les aider au mieux à ce que bah, ce genre de moment se passe se passe au mieux. »	« Oui, et bah comme je disais, avec l'enfant là dont j'ai cité l'exemple tout à l'heure, c'est une photo de lui, donc j'ai imprimé sur un format A3 et puis je guide pour le moment en pointage avec mon doigt. Donc pointage photo. » « Les séquentiels, que ce soit séquentiel photo, séquentiel image séquentiel… Ça peut être du guidage verbal, la guidance verbale, ça peut être de la guidance gestuelle. Et je fais des séquences animées aussi sur PowerPoint parce que justement travailler l'enchaînement des étapes et ben si on veut que l'enfant il soit autonome avec PowerPoint, il est autonome alors que si je suis là, il est un peu autonome. »

	Oui donc c'est organisation de la de la toilette. » « Non parce qu'enfin du coup moi j'utilise beaucoup l'approche CO-OP mais je de manière globale en fait avec les jeunes dans le sens où j'essaye d'ouvrir les questions pour qu'ils soient amenés à réfléchir par eux-mêmes à la solution mais comme c'est de l'autisme sévère souvent c'est c'est limité. Et c'est enfin il y a une limitation au niveau cognitif et du coup c'est l'approche elle ne se met pas vraiment en place. C'est difficile de du coup faire réfléchir amener à faire réfléchir le jeune. »	« Alors moi je je je ne me suis pas informée à ça, mais je pense que l'approche CO-OP pourrait être une une très bonne enfin, voilà un très bon outil. Je ne suis absolument pas formée, mais je pense que en fait avec cette approche-là, à mon avis on pourra avoir de très bons résultats. Tout ce qui va être travail sensoriel, vu qu'on va le travailler en amont, ça peut être aussi très bien, mais ce n'est pas la même approche, on va dire ça comme ça. »	« Et renforçateurs. Je réfléchis, mais je crois que… Ouais, c'est un un bon tour des moyens. »
Les difficultés pour le brossage de dents	« Alors, c'est une activité qui est très complexe pour les personnes TSA sévères. Rien que le fait, enfin rien que le fait de devoir mettre la brosse à dents en bouche et de devoir se toucher la bouche, la sphère orale est complexe pour les jeunes. Donc ça va vraiment être très, tout ce qui va être sensoriel à ce niveau-là, ça va être très compliqué. »	« Encore comme tout à l'heure hein, tout ce qui est bah tout ce qui va être détail, donc ouvrir le le dentifrice, mettre le dentifrice, trouver le bon dentifrice. Parce que bah c'est différent partout, donc là on passe sur le sensoriel et puis faire le mouvement et le faire partout. C'est vrai que c'est, ça peut ne ne pas être super facile pour les enfants, donc on est toujours sur la même chose hein. Bah, motricité du monde supérieur, coordination et sensoriel. C'est ce qui se passe le plus, c'est ce qui pêche le plus. »	« Alors au niveau sensoriel… Bah c'est l'introduction d'un objet dans la bouche, plus le goût du dentifrice. Ça, le dentifrice, c'est une réelle problématique. Mais moi, la plupart des enfants que j'accompagne, ils arrivent avec un dentifrice au goût à la fraise horrible. Et la première chose qu'ils font, c'est de recracher le dentifrice, donc première chose pour moi, c'est la première difficulté que je vois, ce n'est pas la plus grande mais c'est la première. » « Voilà, après pareil, introduire la brosse à dents dans la bouche au niveau sensoriel, c'est quand même particulier et difficile pour beaucoup d'enfants. Mais je trouve que ce cap, ils arrivent à le passer assez vite donc, finalement je trouve que ce n'est pas la difficulté principale pour le brossage de dents. Je dirais, c'est de le faire correctement, là, de faire à droite à gauche de la dent… Parce que faire un séquentiel avec l'intérieur de la bouche, c'est quand même hyper la galère. Là, j'ai j'étais en réunion pluridisciplinaire hier soir et le

			thème, c'était brossage de dent. Il ne faut pas le même niveau de séquentiel pour chacun des enfants. Sauf que dans une salle de bain, on ne peut pas mettre 400000 séquentiels différent sinon on surcharge l'environnement des enfants. En fait, pour que tel enfant, il ait accès au séquentiel, équilibre qui lui convienne, qu'il soit de son niveau de compréhension. Donc je dirais que c'est vraiment de d'arriver à faire un brossage de dents efficace. En plus, ce n'est pas en faisant des ronds comme on a tendance à faire donc là pour le coup au niveau moteur déjà il y a plus de difficultés parce qu'il faut vraiment s'organiser dans l'espace. Et, et ce n'est vraiment pas facile, ça c'est c'est la gestion de de l'orientation de la brosse à dents de des mouvements dans la bouche, c'est tout ça en même temps, c'est c'est la multitâche. Voilà c'est la multitâche qui est compliquée. Parce qu'il y a plein d'aspects à gérer en même temps, il faut tout gérer en même temps, autant la douche, on peut se dire bon bah aujourd'hui on fait que du sensoriel. La brosse à dent pour y arriver, c'est beaucoup plus compliqué. » « Puis la zone elle est super réduite et donc même si on fait de la guidance gestuelle ou imite, voilà guidance imitative. Pour montrer en fait que je retourne ma brosse à dents c'est compliqué parce que l'espace bouche il est hyper réduit et que du coup ça. C'est très compliqué pour l'enfant de cibler en plus sur la bouche de quelqu'un d'autre. »

Les moyens, les outils et l'approche utilisés pour le brossage de dents	« Bah pour le brossage des dents, comme c'est vraiment sensoriel, fin souvent c'est associé aussi à un trouble de l'oralité. Du coup, enfin souvent y'a aussi une prise en charge orthophoniste pour travailler l'aspect oral. Donc ce n'est pas, ce n'est pas un moyen en ergothérapie mais y'a un travail à mener en parallèle. Puis au niveau de l'autisme sévère, du coup y'a beaucoup de parents qui sont démunis et qui ne brosse plus les dents en fait. Mais ce qui engendre après, par la suite d'autres troubles, des caries ou autres et c'est encore plus difficile à traiter en fait. » « C'est plutôt la même chose, fin tout à l'heure j'ai parlé de l'orthophoniste mais c'est plutôt là où est placée la difficulté du jeune aussi. Si c'est sur la planification de la tâche, il va y avoir un séquentiel également, fin ça se rejoint globalement. »	« Alors au niveau des moyens… Je franchement, je je je ne saurais pas trop oui je pense que j'irai toujours sur la même chose. De toute façon, en en soi, surtout si c'est qu'enfin activités de la vie quotidienne pures, enfin toilette, brossage de dents, etc. » « Je pense que je procéderai de la même manière. Donc on va décortiquer la tâche, on va d'abord la travailler avec les pics, etc. Et après mise en situation et puis après en répétition, répétition, répétition et en travaillant le sensoriel. Enfin, pour moi, c'est de toute façon, c'est, je procède comme ça tout le temps en fait. » « Pour moi, c'est c'est, ça marche et voilà. Après il y a d'autres, il y a d'autres choses qui marchent tout à fait. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux avec aussi le picto, décortiquer les la la tâche pour les certains enfants, c'est génial quoi. »	« En plus, je rajouterai que on utilise des applications, il y a une petite application Pokémon, y a un Pokémon qui danse et qui dit quel côté il faut brosser de la dent. Donc je rajouterai les applications disponibles sur Play Store. »
	« Je suis en train de réfléchir mais en fait, la plupart des enfants autistes sévères ils ne sont pas propre. Donc ils ne se rendent pas aux toilettes. Y'a une difficulté à ce, à intégrer la zone du bassin au niveau du schéma et du coup à comprendre les sensations corporelles qui en découlent. Tel que, l'envie d'aller aux toilettes. »	« C'est vraiment le fait de pas voir ce qui ce qu'ils font, c'est hyper hyper angoissant. Et puis même, on a le voilà, tout ce qui est bah, qui va être faire à la toilette, ça va être hyper compliqué à gérer hein. C'est comme si une partie du corps partait hein, des fois hein c'est horrible hein mais vraiment c'est hyper compliqué. Du coup ils se contiennent, ils se contiennent sauf qu'au bout d'un moment ça arrive à l'hôpital. Voilà pareil pour mon grand hein, il a été combien de fois l'hôpital parce qu'il n'a pas été aux toilettes, parce que si parce que ça c'est vrai que ça reste compliqué. Au niveau du sensoriel… Les enfants qui ne voient pas derrière, ils ne sont	« Ah Ah, là pour le coup dans le domaine de l'autisme je ne sais pas si la difficulté, elle relève vraiment de notre niveau en tant qu'ergo. Euh, parce qu'il y a toute cette difficulté à sortir quelque chose de son corps qui est très particulière dans le monde de l'autisme. Et qui relève plutôt du domaine psychologique. C'est la première étape et c'est souvent la difficulté pour…Qui est très difficile à surmonter et à à passer pour les enfants plus que de finalement s'asseoir sur les toilettes est souvent une difficulté. Mais qui finalement sur laquelle on arrive assez facilement et rapidement à passer en fait pour les enfants en leur proposant des petits jeux

Les difficultés pour se rendre aux toilettes		pas capables en fait, pour eux leur leur conception du corps, au proprioceptif y'a pas hein. C'est c'est compliqué pour eux, hein, de savoir qu'il y a quelque chose derrière le le dos ce n'est pas ça existe quoi. Le dos, les, les fesses ça existe, elles sont là, elles sont présentes. Et bah pour certains enfants elles ne sont pas présentes et ils vont pouvoir s'essuyer dans le dos alors qu'il faut s'essuyer les fesses quoi donc… » « C'est vrai que c'est hyper compliqué pour eux la gestion du corps, etc. Donc y a un gros travail au niveau proprioceptif à faire aussi, au niveau des de d'aller aux toilettes quoi. Ça pour le coup, il faut travailler bah tout ce qui se passe derrière le corps etc, ressentir le corps, c'est hyper important. Là par contre pour le proprio oui il va falloir bosser absolument là-dessus parce que sinon ça va être hyper compliqué quoi. Il ne va pas, il ne va pas comprendre pourquoi on le fait quoi. »	dans les toilettes, sur les toilettes, bien sûr. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles on arrive à passer. Alors que là le le fait de sortir quelque chose de son corps c'est quelque chose qui est sûrement très compliqué à travailler. Je n'en sais rien parce que ce n'est pas moi qui le travail pour le coup. » « Ça va être plus plutôt au niveau moteur. Voilà la difficulté à s'essuyer les fesses au niveau de la motricité parce que c'est derrière parce que bah pour expliquer le geste c'est pareil, c'est un peu la galère. Donc ouais s'essuyer les fesses je dirais. Et ça, c'est un apprentissage gestuel qui relève de l'ergothérapie et qui est difficile parce que bah à l'IME, on est encore sur des ados de 15/16/17/18 ans. Et on est encore sur enfin en fait, on n'est pas encore mais c'est qu'à un moment les éducs, ils arrivent, ils me disent *« A*****, là, il faudrait que tu ailles voir parce qu'il me semble que l'essuyage, il n'est pas maîtrisé en fait ».* »
Les moyens, les outils et l'approche utilisés pour se rendre aux toilettes	« Un peu pareil à chaque fois pour moi, j'essaye toujours d'adapter aux difficultés de l'enfant et à ses besoins. Je ne change pas vraiment de moyens en fonction de chaque soin personnel. »		« Là on n'a pas beaucoup de moyens et on n'est que sur de la guidance gestuelle. On peut être sûr de la guidance imitative pour montrer la position de passer son bras derrière. Mais on ne peut pas être sûr… pour montrer exactement comment s'essuyer l'anus donc donc je dirais uniquement sur la guidance gestuelle, quasiment. » « Comme moyen je rajouterais que c'est aussi beaucoup de de transfert de compétences aux éducateurs et aux parents parce que généralement, je ne suis jamais là au bon moment. »
	« Je dirais que si on enlève le fait de devoir choisir le vêtement en	« Sensoriel. Et puis on a le la gestion, comment je m'organise	« Là, je dirais que ce serait surtout une gêne motrice. Et ce

Les difficultés pour s'habiller	fonction de la météo, parce que c'est vraiment, je pense que c'est la plus grosse difficulté. Mais au final, bien souvent c'est les parents qui le font, c'est le fait de planifier l'ordre des vêtements. Par exemple, d'abord mettre le slip, après le pantalon enfin pas le pantalon et après le slip. »	pour mettre mon vêtement ? J'ai des enfants qui mettent à l'endroit à l'envers alors qu'ils ont 17 ans quoi. Donc c'est vrai que ça va être hyper compliqué pour eux ce genre de choses. Toutes les activités de la vie quotidienne en fait, y a ils ne font pas de liens. Pourquoi je mettrais bah qu'est-ce que ça peut me faire de mettre mon t-shirt à l'envers ? Enfin, il y a aucun problème là-dessus. Alors que si en société on ne peut pas avoir ça à l'envers. Donc ils ont aucune conscience de bah ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est mal quoi. Donc il y a tout ça à retravailler avec eux. Le *« Bah non je ne peux pas me déshabiller en public. »*. Enfin, il y a tout ça et cette composante là, mais oui, au niveau des coordinations, de motricité fine, motricité globale. S'il n'y a pas le schéma corporel etc. Bah pareil au niveau proprio, bah je la fermeture éclair mais je ne regarde pas ce que je fais, ce n'est pas possible quoi parce que je ne sais pas qu'à tel endroit j'ai une fermeture éclair et je peux l'enclencher donc. C'est vrai que voilà, il y a tout le travail, mais moi, pour moi, de toute façon… enfin je, je je n'arrête pas de parler de sensoriel. Pour moi, l'ergo sans le sensoriel, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pour moi, ça intervient dans toutes les activités de la vie quotidienne et du coup bah c'est vrai que c'est, c'est difficile de de faire abstraction de ça, hein. »	serait surtout en lien avec des difficultés motrices pour tout ce qui est mettre les chaussettes, mettre les boutons de pantalon. Et ouais ouais, là c'est surtout en termes de motricité et ça peut être aussi en termes de sensorialité parce que en enfilant l'habit, le faire de faire glisser quelque chose sur sa peau, ça peut être gênant. Honnêtement à l'IME il y en a un sur les 25 enfants pour qui c'est le cas. Donc ce n'est pas la gêne principale alors que pour le coup mettre ses chaussettes et mettre les boutons de pantalon on est sûr en plus plus de 50%. »
	« Là c'est essentiellement du séquentiel, mais avec guidance, par exemple guidance verbale qui s'estompe, qui devient physique et qui après s'estompe. Pour que le jeune il soit amené après a, on lui dit	« Donc c'est vrai que j'y reviens tout de temps. Mais tout ce qui est proprio, vestibulaire tactile auditif, ça va être des enfants qui sont stimulés hyper, enfin, les les enfants autistes sont hyper stimulés tout le temps et du coup c'est horrible pour eux. Donc	« Oui, parce que là vu que ça dépend aussi de compétences motrices… Et Ben on fait pas mal de travail en séance sur les prérequis : pour boutonner, pour enfiler ses chaussettes, sur la dissociation des doigts sur les manipulations etc. Donc on fait

Les moyens, les outils et l'approche utilisés pour l'habillage	simplement d'aller s'habiller et puis il suit son séquentiel. »	c'est vrai qu'un bruit de fermeture éclair ça ne va pas être possible donc ils vont laisser le manteau ouvert. Enfin, il y a plein de composantes qui sont hyper complexes et qui doivent être prises quand même en compte et dans notre plan de traitement. Voilà qu'on travaille la mise en situation parce que ça ne sert à rien, en fait, parce qu'il ne va pas accepter. Que ça va être encore pire. Il faut accepter, il y a un gros travail quand même à faire sur le sensoriel avant tout ça. »	pas mal de déguisements pour passer ça sous le la forme de jeu. Après, on fait les planches d'habillage, ouais avec renforçateur parce qu'une planche d'habillage, c'est horrible mais voilà du coup y a des séances de rééducation en plus comme moyen en plus de tous les autres séquentiels etc. »
Les difficultés pour la prise de repas	« La sélectivité, l'hyper sélectivité. Bah du coup pour beaucoup, c'est aussi les morceaux, ce qui entre en jeu aussi dans la sélectivité hein mais (…). L'introduction des morceaux est très difficile. »	« Bah c'est des enfants qui utilisent rarement les fourchettes, les couteaux hein. J'ai envie de vous dire des enfants qui mangent, qui ne prennent alors peut-être pas à la main, hein. Je n'avoue peut-être pas quand on a de l'hyper sensibilité tactile, ils ne vont peut-être pas y aller avec la main. Mais c'est vrai que ça, ça utilise sûrement enfin vachement tout ce qui est cuillère, pas fourchette, ils ne piquent pas, ils ne savent pas les retournements au niveau de la manipulation de la main ils n'ont pas hein. Ça, ça reste très saccadé. Couper la viande, c'est les coordinations des la coordination bi manuelle, il y a il y a très peu, voilà qu'ils en font… Au niveau moteur, ils ont des grosses difficultés, ils n'y mettent pas de sens en plus. Donc c'est vrai qu'en plus souvent, c'est des moments qu'ils détestent parce que bah au niveau sensoriel, on est au summum de la simulation donc c'est des choses où ils vont ils ne vont pas trouver d'intérêt ou ils vont avoir un léger dégout donc bah tout ce qui va être repas va être compliqué. Les coordinations ça va être compliquées, mettre à la bouche etc. Et puis bah tout ce qui va	« Là, c'est difficultés sensorielles, direct. Mais il y a une difficulté motrice qui arrive aussi derrière, c'est le couteau, utiliser le couteau, que ce soit poussé, pour découper, pour tartiner, c'est… Le couteau, ça reste une utilisation quand même assez complexe pour les enfants qui ont un trouble de la coordination associé. Mais la particularité principale, et notamment pour les les, les enfants avec un un TSA sévère, c'est la sensorialité, le fait de manger des fruits et des légumes crus, ça c'est le plus compliqué. »

		être, tout ce qui est orale, faciale hein ça va être hyper complexe hein de mâcher etc. C'est des gens qui vont, qui vont limite gobet parce que bah au moins ça passe vite et puis c'est tout quoi. Mais voilà, un gros travail aussi à faire là-dessus. Et oui encore le sensoriel encore et toujours et toujours mais mais voilà pour moi c'est c'est ça. » « Après stimulation autour, hein. Les parents qui vont dire *« Aller faut manger faut manger… »* stimulation extérieure, l'environnement, bah la télé machin, qui peut être aussi compliqué et qui peut être qui peuvent être aussi parasites. Voilà. Faut faut faut aussi penser à tout ça. »	
Les moyens, les outils et l'approche utilisés pour la prise de repas	« J'ai suivi une formation il y a peu de temps. En fait, c'est un programme assez récent, il a été créé y'a un an et il est encore en phase d'évaluation. Et qui est en lien avec l'institut de C********. Et en fait c'est un programme, qui vise à donner des, comment dire, des stratégies pour que les jeunes puissent avoir les ressources pour goûter les plats. Et qui est un programme qui s'étend sur 14 semaines, avec participation régulière des parents. C'est vraiment pour tout ce qui est néophobie, la peur de ce qui est nouveau et que le jeune est moins peur des aliments nouveaux en ayant les armes pour aller vers la découverte. »		« Oui, alors là on fait souvent avec les éducs. Enfin, j'aimerais bien en faire plus, mais j'aimerais bien me former avant de faire des bêtises aussi. C'est des groupes, des ateliers en fait autour du goût. Alors, ça s'appelle les ateliers goût, mais finalement, le goût, c'est le dernier objectif. Parce que là, pour le coup, les séquentiels, ça ne marche pas. Le renforçateur, ça marche parce que, par exemple, de dire *« Bon bah si tu mets juste le morceau de carottes râpées sur la langue, t'as le droit à un morceau de pain derrière »* ça, souvent ça marche. » « Ouais, voilà là je dirais pour le coup les ateliers autour du goût, de la sensorialité de l'alimentation et les renforçateurs. Et puis j'imagine que certains ergos proposent des des séances autour de l'oralité, mais moi ce n'est pas le cas, je ne suis pas formée, j'aimerais bien hein, je l'ai demandé, mais mais je ne veux

			pas faire de bêtises, donc je ne préfère pas trop m'y lancer. »
Par quoi s'expliquent ces difficultés ?	« Il y a énormément quand même de troubles sensoriels. (…) après je dirais que y'a, au niveau moteur il y en a très peu qui ont des, si quand même, c'est plus des difficultés dans le sens vestibulaire ou proprioceptif, du coup c'est encore à la fois vers le sensoriel en fait. »		
Utilisation d'une approche dans la pratique professionnel	« Du coup, comme dit précédemment l'approche CO-OP mais qui va me servir plutôt avec les enfants avec des TSA plus léger. Mais sinon non pas particulièrement. »	« Alors mes formations, oui, clairement, je les intègre tout à fait à mes séances. Après, encore une fois ça dépend de voilà de de à l'instant T si l'enfant est présent avec moi ou pas ou pas du tout. Après moi, je sais que tout ce que j'ai pu apprendre bah j'ai fait des liens avec ma ma profession avec bah l'ergothérapie. Mettre en application ce que j'ai appris sur mes feuilles et mes cahiers. J'essaye de le mettre en action en séance, bah toujours avec la même chose hein. Essayez de de mettre en place bah avec les parents des pictogrammes pour faire des demandes, etc. Je suis formée PECS, on essaie de travailler là-dessus pour que l'enfant puisse dire bah là, « j'ai envie d'aller aux toilettes ou je je veux me brosser les dents ou j'ai envie d'aller manger telle chose. ». On essaie de travailler là-dessus. Je les mets en place, bah avec avec tous les jeux que je peux avoir, je ne sais pas si ça peut, ça peut faire des liens avec tout ce que je peux avoir au cabinet. Bah j'essaie de de l'intégrer aux séances. Les Jeux, les, les outils qu'on m'a donnés, les protocoles d'intégration sensorielle tout ça. Enfin voilà, tout ça, j'essaie de le mettre en place en séance. »	« Je fais de l'ABA. On est beaucoup sûr de l'ABA en tout cas par rapport à votre problématique. On est beaucoup sûr de l'ABA parce que on travaille avec des enfin dans votre problématique, on travaille avec des enfants avec TSA sévère et que donc ABA fonctionne bien. Et par rapport à la problématique de travailler sur la participation dans les activités de vie quotidienne on est aussi sur du modèle ABA, mais je peux aussi être sur du TEACCH quand je suis en séance de rééducation. Ouais, beaucoup ABA et TEACCH. En autisme, c'est tout ce que je vois après, en ergo, je ne sais pas si on considère MCRO tout ça comme une approche, mais en tout cas c'est inspiré parce que y a la priorisation des objectifs, il y a les demandes aux familles, ce n'est pas du MCRO rigide on va dire. Je ne trouve pas mon mot, mais ce n'est pas du appliquer en tout cas, mais c'est de l'inspiré mais c'est comme beaucoup, hein, parce qu'en libéral je sais qu'on travaille énormément avec les bilans. En IME, les bilans, ils ne sont tellement pas adaptés au public qu'on reçoit, c'est trop compliqué et tous les outils qu'on peut utiliser en cabinet, on n'utilise pas du tout les mêmes. »

Annexe 5 : Retranscription entretien E2

Retranscription entretien E2 :

Date : 28 mars 2023
Durée : 35 minutes
Par : appel téléphonique

GH : Est-ce que déjà vous pourrez, vous pourriez me présenter un peu votre parcours professionnel ? S'il vous plaît.
E2 : Ouais, pas de soucis alors moi je suis diplômée depuis septembre 2018. J'ai fait une année en fait de stage parce que j'ai redoublé ma dernière année d'ergo, donc j'ai fait une année pour faire mon mémoire que j'ai fait en cabinet libéral pendant une année. Et du coup, bah dès que j'ai eu mon diplôme j'ai été diplômée de Belgique, je ne sais pas si, ça peut être, intéressant. Je suis diplômée d'une école belge donc j'ai dû attendre mon équivalence au mois d'octobre. Donc c'est vrai que voilà, j'ai après, j'ai directement commencé, j'avais un an de stage en libéral, j'ai directement commencé en libéral parce qu'une place se libérait. J'étais à temps plein en tant que collaboratrice, donc ce n'était pas mon cabinet mais mais voilà, pendant 2 bonnes années jusque fin 2020. Juste après le COVID, j'ai été collaboratrice et puis après j'ai monté mon cabinet en septembre 2020, donc je suis prêt, de D******* à côté de R*****. Et depuis voilà, je je suis 100% libéral, j'ai toujours été quasiment 100% libéral, à part quand j'ai lancé mon cabinet, j'ai été à mi-temps en EHPAD, mi-temps libéral. J'ai toujours travaillé avec des enfants, ce qui me plaît. Quoi d'autre ? J'ai une collaboratrice depuis un an, voilà et puis et puis voilà. Après, j'ai quelques enfin quelques formations, j'en ai pas mal, j'ai tout ce qui est outil, PECS, outil de communication. Je suis formée Stimul'Ergo, tout ce qui est diagnostic précoce donc bah les TSA, pour les jeunes, les jeunes enfants de 0 à 5 ans.
GH : OK.
E2 : Euh, j'ai tout ce qui est troubles de l'intégration neurosensorielle et j'ai des troubles de l'oralité alimentaire. J'ai quoi d'autre ? J'ai j'ai pas, j'ai pas mal de formations et dont bah quelques bases dans le TSA même si voilà, je j'en ai pas énormément, j'en ai plus au cabinet que je ne vais à domicile parce que je fais plus beaucoup de domicile. Mais j'en ai quand même aussi pas mal au cabinet donc bon, j'essaierai de répondre aussi par rapport à ce que je peux avoir au cabinet et puis et puis voilà avec toutes sortes de population rien de particulier sur ça.
GH : Ok. Ok. Et du coup je voulais vous demander, est-ce que bah vous m'avez dit que vous rencontriez du coup des enfants TSA aussi au cabinet et c'est plutôt quel degré de sévérité enfin que vous êtes amenée à rencontrer ?
E2 : J'ai du TSA avec enfin, j'ai des verbaux, j'ai des non verbaux. En fait, j'ai j'ai vraiment de tout ça va de de de l'autisme infantile à asperger. Donc voilà, j'ai j'ai vraiment c'est très très large mais voilà, j'en ai quand même pas mal, qui sont verbaux au cabinet, j'en ai 5, voilà au moins 5 en tant que non verbaux. Voilà.
GH : Ok. Du coup, c'est plutôt quelle tranche d'âge ? Est-ce que vous avez un peu de tout âge, surtout au niveau fin des enfants TSA du coup ? Ça m'intéresserait plus.
E2 : Alors oui, alors en cours de diagnostic, j'en ai un au cabinet, il a 2 ans. On diagnostic pas à cet âge-là mais on a quand même des petits signaux qui nous laisse penser que, donc un diagnostic précoce là. Il est dans un parcours PCO, donc voilà. J'en j'en ai un qui a 2 ans et ça va jusqu'à mon plus grand que je vois à domicile qui a 17 ans.

GH : Ok, ça marche.
E2 : Voilà donc j'en ai… Voilà 10-13 ans et j'en ai aussi de 8 ans. Enfin voilà, j'ai vraiment de tout âge pour le coup de de 2 jusque 17.
GH : Du coup, Ben merci si on rentre un peu plus dans le bah dans le sujet du coup je voulais vous demander est-ce que vous pouvez me dire les personnes avec lesquelles vous allez travailler lorsque vous prenez en soin un enfant avec des TSA sévères ?
E2 : Alors moi je sais que c'est des enfants qui sont suivis, beaucoup en structure, donc, je travaille beaucoup avec les éducatrices qui sont en lien avec bah directement avec avec l'enfant. Je travaille beaucoup avec les éducatrices et avec les psychomotriciennes sur le secteur. J'avoue que voilà, on se complémente bien et et je trouve ça super. Donc c'est vrai que les les premières, enfin les premières, c'est majoritairement des femmes mais les premières avec qui je vais travailler, c'est vraiment éducatrices et psychomotriciennes, vraiment, c'est les, c'est les 2 points forts. Après, j'avoue qu'il y a aussi les les psychologues, mais ça arrive vraiment en 3e position largement. Donc, c'est vraiment pour moi le premier, c'est éducatrice. Clairement, je je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les éducatrices. Je fais beaucoup de lien avec les éducatrices et après psychomotriciennes, voilà si y a un bon lien, c'est plus rare. Et après psychologue.
GH : Ok. Et du coup, si on ne parle pas forcément de des enfin d'une personne, enfin du des professionnels, mais plutôt de l'entourage des enfants ?
E2 : Ah oui bah clairement les moi je oui, j'avoue je les oubliés c'est pardon oui avec la famille, clairement hein. J'avoue que ouais avec les parents j'ai un j'ai des forts liens qui se sont créés. Pas nécessairement avec les frères et sœurs, avec les parents oui. Ouais, plus avec les parents ou les grands-parents qui les amènent.
GH : Ok.
E2 : Et encore, après, il y a aussi on n'en parle pas assez mais y a des taxis aussi qui me les emmènent et c'est vrai qu'ils ont un rôle important. On ne va pas, voilà, c'est eux qui font le lien. Quand les parents ne peuvent pas se déplacer, c'est eux qui font lien avec les parents. Donc il ne faut quand même pas les oublier, ces Messieurs Mesdames qui nous les emmènent toutes les semaines au cabinet ou voilà donc ouais après avec les parents, clairement les parents ils ont un rôle très important. Je trouve que en fait, sans eux enfin, le travail n'est pas le même parce que bah c'est eux qui font la boucle entre professionnels, tous les professionnels et puis bah leur environnement avec bah leurs enfants et leur quotidien.
GH : Tout à fait. Ok mais oui, c'est sûr qu'enfin même là, du coup je suis en stage. Enfin, je fais une parenthèse mais en stage en cabinet libéral et et du coup bah c'est vraiment le stage où je vois le lien donc entre les parents et nous. Et c'est vrai que pour prendre en soin des des enfants, c'est hyper important de ben ce lien.
E2 : Ah oui, parce qu'il y a nous y a les professionnels, y a les parents et y a aussi l'école parce que bah ce n'est pas que les enseignants etc. Enfin, on fait vachement enfin c'est les parents en fait, qui font le lien entre nous et tout ce monde-là. Donc bah sans sans eux bah il n'y a rien quoi clairement hein, quand y a pas de dialogue avec les parents bah y a rien qui se fait derrière. Clairement ouais, je l'ai, enfin ça se voit.
GH : C'est super. Ça se voit. Ok OK et du coup pour vous, en quoi cette prise en soin pluridisciplinaire là du enfin, si on s'intéresse donc aux à l'éducateur psychologue, etc. Pourquoi ça va être important dans l'accompagnement de d'un enfant ayant des TSA sévères ?
E2 : Alors pour moi, un enfant qui est TSA sévère, il a tellement d'impact dans sa vie quotidienne qu'alors oui, l'ergo à un super rôle hein, mais en fait on a un moment où notre, personnellement, moi

je les vois que 45 minutes à une heure par semaine, je je ne peux pas tout faire clairement à un moment, je pense que les éducateurs les, enfin voit l'enfant plus, en plus, c'est des gens qui vont à l'école. Peut-être que moi je ne peux pas y aller. Peut-être que voilà, il y a plein d'autres choses ou que moi je ne pourrais pas faire par manque de temps. Et je sais qu'eux le font parce qu'ils ont des plages horaires dans leur planning vu qu'ils sont dans des structures. C'est complètement différent, c'est une organisation qui est complètement différente, mais en fait eux je trouve ça hyper important parce que c'est eux qui limitent des fois, qui m'enrichissent, qui me disent « Bah ça, ça n'a pas été. Est-ce que tu peux travailler avec un tel sur telle activité parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas à l'école. » Et ce n'est pas dans mon champ de compétence donc, « Est-ce que toi tu as des idées ? » et c'est vraiment un un, c'est un enrichissement. En fait, je trouve de travailler avec tout ce monde-là, parce qu'on a tous nos casquettes et tout le monde va travailler quelque chose va voir quelque chose, mais en même temps, on va tous se se concerter. Et pour travailler d'un commun accord avec pour pour que les objectifs de l'enfant ils soient, ils soient, ils soient atteints et c'est vrai que bah ouais, par manque de temps par manque de plein de choses ; ben c'est bien d'avoir tout ce monde-là autour de l'enfant pour qu'il puisse voilà pour qu'il puisse s'épanouir autant qu'il qu'il puisse après, des fois ça arrive que ça soit différent. Mais dans la majorité des cas, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce lien avec tout le monde quoi, qu'on travaille tous ensemble pour l'enfant, vraiment.

GH : Ok OK OK merci. Et du coup par rapport aux parents. Comment nous en tant qu'ergothérapeute, on pourrait travailler avec les parents ? Oui, comment on peut travailler avec eux dans cette prise en soin de l'enfant ?

E2 : Alors moi je sais que les parents, ils sont intégrés à la séance. Certains parents peuvent très bien participer à la séance ou des fois j'arrête la séance dix minutes avant et je leur explique « bon bah on a fait ça ça, ça ça il faut que vous fassiez ça ça, ça ça à la maison du coup » et je leur donne des petits, des conseils, etc ou des outils. Je leur dis, « Bah écoutez, je vous prépare quelque chose, je vous l'envoie par mail et vous travaillez à la maison. » Et c'est vrai que bah les parents, moi je les intègre largement parce que c'est des parents qui ont eu des parcours de soins assez compliqués. Avec des enfants des fois qui sont diagnostiqués très tard et qui n'ont pas eu toutes ces aides dès le départ et qui sont, des fois ils culpabilisent, ils sont complètement perdus. Et c'est vrai que de les intégrer, ça les valorise et ils sont super contents et je je ne me vois pas les enlever de la séance. Alors y a des parents qui ne veulent pas du tout assister à la séance parce que les enfants c'est encore pire. Mais je trouve que ça reste quand même super important. Moi je sais que bah dans quasiment toutes les séances avec des des enfants TSA sévères, ils sont tout le temps-là tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça et ben ils voient, ils voient ce qu'on fait en séance et ils me disent « Ah bah du coup ça, je peux le faire à la maison, ça, je peux le faire à la maison. » Et du coup, le lien se crée vraiment. En disant « Bah oui, OK d'accord, bah vous m'avez dit ça donc j'ai fait ça. » comme ça on peut en discuter des situations de problème que bah en 5 minutes avant la séance ils ne peuvent pas m'expliquer, que quand je fais quelque chose ils disent « Ah bah oui, ça c'était problématique est-ce que vous pouvez le travailler ? ». Et on fait vraiment des liens avec, bah avec les parents du coup.

GH : Ok. Oui, c'est vrai, ça permet de faire plus de liens. Je suis d'accord avec vous que juste faire le résumé à la fin.

E2 : Bah c'est ça, c'est ça. Je trouve que c'est tellement mieux de travailler vraiment avec eux. Après voilà, c'est, il y a des professionnels qui ne veulent absolument pas, etc. Ce que je peux entendre, mais moi, je n'ai aucun problème avec le fait que les parents viennent en séance et je trouve ça 1000 fois mieux. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à créer le lien avec les parents et et les intégrer

clairement en leur donnant bah s'ils ne veulent pas participer en leur donnant des outils en leur expliquant vraiment détailler ce qu'on a fait parce que je ne pense pas qu'ils en ont besoin. Et voilà.
GH : Ok OK. Bah je suis vraiment d'accord avec vous. Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que c'est assez, enfin je ne sais pas si c'est rare mais c'est une des premières fois, je pense que j'entends que quelqu'un vraiment intègre enfin un ergo intègre les parents en séance.
E2 : Ah oui, mais ouais. Ma, ma stagiaire m'a dit la même chose, elle m'a dit « c'est possible que les parents viennent ? ». J'ai dit « oui, oui les parents peuvent rester, bien au contraire ». Moi je suis pas du tout fermée, mais même, même pas que pour des enfants que TSA, hein. J'ai des enfants, j'ai des enfants, qui sont tellement angoissés de venir me voir et je dis aux parents, « Bah restez pour la première séance » et la 2e est ben ils restent et puis bah et puis bah ça ne me gêne pas. Comme ça moi je peux faire le lien avec eux, ben je leur dis « Voilà, on a travaillé ça donc bah vous allez travailler ça à la maison. », « Ah oui d'accord d'accord Ah bah oui bah super. ». Donc oui tout à fait franchement moi je je trouve ça super.
GH : Ok, Ok. Mais du coup ben un peu en lien avec ça quand vous intervenez ? Bah du coup ça va plus être enfin ça peut être plus être à domicile mais auprès des parents pour par exemple faciliter leurs soins personnels. Enfin est ce que vous enfin comment vous allez intervenir pour les aider à pouvoir faciliter les soins personnels de leurs enfants ?
E2 : Alors quand vous dites les soins personnels c'est vraiment tout ce qui est toilette etc. Ou on parle d'habillage tout ça ?
GH : Euh oui oui bah habillage, toilette, repas vraiment global.
E2 : Ouais, alors moi, je sais qu'à domicile pour pour le grand que je suis, c'est vrai qu'on on travaille beaucoup avec des mises en situation. Voilà, je sais que je je fais beaucoup de mises en situation et je sais que bah la maman qui est aussi à domicile à à ce moment-là, fait beaucoup de photos films et en fait elle elle fait plein de carnets, etc. Et c'est vrai que bah forcément, elle est elle est intégrée et j'essaie de donner des conseils en même temps, quand elle filme etc. Et on a déjà travaillé la cuisine, l'habillage, plié le linge. Enfin, voilà toutes les petites choses à faire, le lit et c'est vrai que on n'a pas fait tout ce qui était partie, soins personnels, tout ce qui est toilette, etc. Parce que ça reste quelque chose que la famille ne veut pas travailler avec moi, donc je le je l'entends. Hein mais voilà.
E2 : Et en plus, c'est un, c'est un grand qui porte encore tout ce qui est protection, la journée, la nuit donc c'est vrai qu'il est. Voilà, au niveau, voilà au lieu urinaire etc, ce n'est pas, c'est pas du tout acquis donc c'est des choses que la maman a un peu honte aussi alors qu'enfin faudrait pas du tout. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais accès vraiment là-dessus, après, ça pourrait être tout à fait travaillé et sous forme de mise en situation aussi, hein. Se mettre en maillot de bain il n'y a pas de y a y a aucune honte hein vraiment pour le coup. Mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup en mise en situation. Ok ça ça ne va pas, on le met en place, pour par exemple on a étendu le linge, fin voilà des bêtises mais voilà et on décortique toutes les tâches. « Tu prends comme ça, tu voilà… » et la maman filme et prend des photos tout le temps.
GH : Ok bon. Ça marche.
E2 : Et elle est, elle est présente quand on fait ce genre d'activités parce que du coup, elle va pouvoir le refaire avec avec son fils et elle va dire « Oh bah tu l'as fait avec C****… » fin voilà c'est vraiment des liens qui qui peuvent se faire.
GH : Oui c'est ça qui est important parce que c'est vrai qu'avec les enfants TSA, comme ça, de toute façon, même si on les fait mettre en situation, souvent ils n'arriveront pas à le refaire tout seul, donc il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui puisse les aider.

E2 : Exactement. Donc en fait, il faut le répéter, répéter, répéter répéter. Pareil comme je disais, je viens qu'une fois par semaine, 1h ben en répétant même pendant 1h, il ne sera pas capable de de l'emmagasiner et du coup il faut que les parents fassent derrière quoi.
GH : Ok. Ok Ok du coup maintenant j'aimerais plutôt parce qu'on parle de la participation occupationnelle. Bah vu que c'est un point fort de mon sujet de mémoire et du coup je voulais vous demander pour vous un peu qu'est-ce que c'est la participation occupationnelle, enfin vraiment pas obligé une une définition précise mais avec vos mots et globalement pour vous enfin, qu'est-ce que vous entendez ?
E2 : Ok, ça marche alors pour moi la participation occupationnelle, c'est alors comment je pourrais expliquer ça de manière précise sans dire n'importe quoi. Moi je dirais que c'est plutôt l'enfant, comment dire ? Comment il participe dans son environnement, mais ça ne veut rien dire. C'est comment il est dans… Ah je ne saurais pas expliquer de manière simple je pense… Moi, je dirais que ça, c'est en lien avec son rôle occupationnel après tout ce qui est participation sociale aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile à expliquer. J'avoue, vous me posez un peu une colle. Ce qui participation occupationnelle, c'était comment il arrive à à faire, à réaliser ses occupations de manière optimale. Je pense. C'est ouais ça ça me semble à peu près correct.
GH : Oui ok, oui ok. Et du coup, selon vous, dans quelle(s) activité(s) de vie quotidienne l'enfant ayant des ça sévère va rencontrer le plus de difficultés ?
E2 : Pour moi, ça va être tout ce qui va être lié au sensoriel. Donc bah tout ce qui va être soin soin personnel au niveau de la douche.
GH : Ok.
E2 : Tout ce qui est même alimentation tout en fait, pour moi tout ce qui va être lié au sensoriel, parce que ces des enfants qui sont hypersensibles. Et et du coup, bah c'est vrai que bah tout ce qui va être lié bah à la sphère orale ça va être compliqué tout ce qui va être tactile ça va être hyper compliqué. Donc bah s'habiller ça va être compliqué que certaines textures, manger ça va être compliqué parce que bah qu'une texture aussi ou que certains aliments et pas d'autres. Pour moi c'est ça qui est le plus compliqué pour les parents c'est que bah je reprends l'exemple de mon grand que j'ai à la maison. C'est il boit du coca, il mange du fromage et ça, ça s'arrête quasiment là, n'y mange pas de pâtes. Voilà, c'est l'alimentation elle est vraiment très sélective. Et bah il ne peut pas sortir, il ne peut rien faire, il ne peut rien manger. Donc c'est vrai que ça reste très limitant et puis voilà enfin c'est c'est hyper compliqué. Et puis tout ce qui est soin personnel au niveau de la, la gestion de l'autonomie à la toilette. Enfin, tout ça, c'est… C'est ce qui pour moi, c'est les plus gros, le sensoriel et ben je ne sais pas si c'est pour vous, ce sera une activité, mais tout ce qui va être amené au sensoriel et à la toilette.
GH : Ok, oui c'est c'est parfait ok. Et du coup d'après vous comment on obtient la participation d'un enfant ? Enfin, qu'est-ce qui peut influencer ou faciliter cette participation ?
E2 : Sa motivation. Je pense à motivation à l'activité après aussi son comment dirais-je, son à l'instant T est-ce qu'il est capable d'entendre les conseils ? Est-ce qu'il veut bien faire aussi y'a ça ? Si c'est un bon, c'est un bon jour ou pas, hein ? En fonction d'une situation… Et après de donner bah peut être des choses plus ludiques, je ramène toujours au jeu, hein, de toute façon. Tout ce qui va être travail au niveau de la participation, de la participation, ça va être bah forcément revenir au jeu, de la motivation pour que bah il se crée voilà se créer des liens avec bah ces activités de la vie quotidienne. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider.
GH : Si c'est parfait, toute toute réponse me va de toute façon, donc parfait. Maintenant, je vais, on va plus…
E2 : Ah super.

GH : Du coup, s'axer sur bah les soins personnels et je voulais vous demander donc vous m'avez parlé des des mises en situation mais globalement, quelles évaluations vous pouvez faire pour identifier les difficultés occupationnelles que l'enfant il va avoir dans la réalisation des soins personnels ?
E2 : Alors moi je fais beaucoup passer l'OT'Hope je ne sais pas si vous connaissez ? Voilà donc qui est quand même bien bien rapproché du MCRO, j'ai fait passer récemment la MCRO justement à bah au grand que je suis aussi, que je suis à la maison. Et j'ai passé oh, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises… Il me semble que j'ai passé une MHAVIE ou un truc comme ça ?
GH : Ok.
E2 : Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Attendez, j'ai passé, ouais, il me semble que c'était une MHAVIE. Mais après c'est c'est tout ce que je passe, j'avoue. Mais OT'Hope m'aide vachement pour le coup et puis MCRO.
GH : Ok. Et du coup est-ce que vous vous pouvez aussi faire par exemple des entretiens avec ben, l'enfant et ses parents, enfin ses proches pour évaluer ces difficultés occupationnelles ?
E2 : Ah oui, oui. De toute façon, bah j'en reviens toujours à mon grand. Euh, je en fait il est non verbal donc du coup ce n'est pas lui qui va me répondre mais en fait on pose des objectifs. De toute façon moi je pose des objectifs avec les parents quand ils arrivent en séance, que ça soit TSA ou non. C'est « Vous voulez avoir quoi comme objectif là, à moyen long et court terme ? » et du coup ils me disent « Bon bah voilà je, je veux ça, je veux ça, je veux ça. ». Et en fait, avec cette maman, on avait très bien mis en avant des objectifs. C'était bah ça va s'apparenter toujours à la même chose, hein. De toute façon, on est sur tout ce qui est bah de la vie quotidienne, les repas, l'habillage, savoir la gestion de la monnaie, aussi il y a les heures, la gestion de son organisation enfin voilà. C'est elle qui m'a dit, « Ben, je veux ça qui sache faire ça, ça, ça ça ça. ». Et oui, bien sûr, je, pour je fais une grosse anamnèse hein de toute façon. Après je le connais donc c'est différent, je ne fais pas comme si je partais de 0 pour un bilan. Mais c'est vrai que oui, je je discute avec les parents, je leur demande « Bah voilà telle activité par exemple repas comment ça va pour manger, couper sa viande etc. » Et en fait je détaille brossage de dents et en fait ils me disent, ils me disent « Bon bah ça a été ça n'a pas été ça, ça ne va pas, qu'est ce qui ne va pas… » et on en discute en fait.
GH : Ok.
E2 : Et ça pour n'importe quel quel entretien, bilan de tout ça, voilà.
GH : Ok, Ok. Maintenant, on va détailler les, les soins personnels, un peu un par un pour savoir en fait bah déjà dans un premier temps, quelle(s) difficulté(s) l'enfant va rencontrer. Enfin, d'après vous, quelles difficultés vont être rencontrés principalement pour un enfant ayant des TSA sévères dans la réalisation de sa toilette ? Du coup, est-ce que ça va être plus par exemple, pour bah ouvrir l'eau enfin, des choses plutôt techniques ou des choses, mais je pense qu'enfin en fait, j'ai un peu la réponse mais je préfère vous demander, pour se mouiller le corps pour tout ce qui est mettre du savon ou des choses comme ça ?
E2 : Ouais, bah on est plus sur ça. On est plus sûr, voilà pour tout ce qui est mettre de l'eau sur le corps, le savon, la gestion de du savon dans les cheveux. Et après, on est quand même aussi sur des enfants qui ont des problèmes de coordination hein. Donc bah se laver les cheveux c'est hyper compliqué quand même, hein, le mouvement etc. Se laver tout le corps, bien se savonner partout, on n'est pas non plus sur des choses qui sont optimales optimales. Mais le premier truc, c'est vraiment tout ce qui est sensoriel. C'est hyper compliqué quoi, c'est… Enfin, le grand que je suis c'est, c'est horrible quoi. C'est les cheveux, ce n'est pas possible c'est la maman qui est obligée de le faire. Après enfin, j'ai encore l'exemple de couper les ongles, j'ai des mamans qui le font quand les enfants dorment enfin, voilà.

GH : Et du coup, quel(s) moyen(s) vous pouvez utiliser pour favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans l'activité de la toilette ?
E2 : C'est-à-dire les moyens ?
GH : Par exemple, est-ce que oui, vous pourriez mettre en place des plutôt des êtres humains, des aides techniques, des choses comme ça ?
E2 : Alors, aides techniques ou plus ou moins. Après moi je sais que je dis aux parents de faire tel ou tel rituel, voilà. « Vous faites un bon massage avant d'y aller, vous faites une grosse pression sur le corps et puis après vous pouvez aller à la douche et vous refaites pareil après. ». Après c'est plus des petits outils que je peux, je peux leur donner. Après je sais que je travaille beaucoup avec tout ce qui est picto, on séquence la tâche, « tu dois faire ça, ça, ça, non ça ne va pas te faire mal aux yeux. » etc. On travaille enfin, j'essaie de rassurer du mieux que je peux. Après pour les moyens donc picto je dirais et et puis bah aide orale entre guillemets pour les parents, pour pour les aider, pour pour les aider au mieux à ce que bah, ce genre de moment se passe se passe au mieux.
GH : Ok. Et bah du coup, vous avez eu plusieurs formations. Du coup je voulais vous demander est-ce qu'il y a une approche par exemple que vous pouvez utiliser pour favoriser ? Bah la participation compassionnelle de l'enfant dans ses soins personnels, enfin dans la dans la toilette du coup.
E2 : Alors moi je je je ne me suis pas informée à ça, mais je pense que l'approche CO-OP pourrait être une une très bonne enfin, voilà un très bon outil. Je ne suis absolument pas formée, mais je pense que en fait avec cette approche-là, à mon avis on pourra avoir de très bons résultats. Tout ce qui va être travail sensoriel, vu qu'on va le travailler en amont, ça peut être aussi très bien, mais ce n'est pas la même approche, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas la même donc je pense que… Enfin, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais une approche CO-OP pourrait pourrait fortement aider l'enfant. Parce que voilà, je je ne me suis pas formée, donc je ne pourrais pas là pour le coup répondre mais pour moi une de voilà de de mes, de mes souvenirs d'études et etc, une approche CO-OP pourrait être tout à fait adaptée.
GH : Très bien et bon, là voilà, on va un peu faire chaque soin personnel, mais du coup je pense que ça va se répéter mais bon ce n'est pas grave mais comme ça j'ai j'ai mes réponses.
GH : Du coup, si on passe plutôt maintenant par rapport au brossage des dents, les difficultés là pour vous qui vont être rencontrées principalement, ça va être à quel on va dire niveau de de la réalisation de du soin personnel ?
E2 : Bah bah encore comme tout à l'heure hein, tout ce qui est bah tout ce qui va être détail, donc ouvrir le le dentifrice, mettre le dentifrice, trouver le bon dentifrice. Parce que bah c'est différent partout, donc là on passe sur le sensoriel et puis faire le mouvement et le faire partout. C'est vrai que c'est, ça peut ne ne pas être super facile pour les enfants, donc on est toujours sur la même chose hein. Bah, motricité du monde supérieur, coordination et sensoriel. C'est ce qui se passe le plus, c'est ce qui pêche le plus.
GH : Et ce que du coup là vous allez, vous, vous allez mettre en place, vous allez pouvoir mettre en place d'autres moyens que ce qu'on a évoqué avant ou est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient qui pourraient être enfin, qui pourraient favoriser la participation occupationnelle de l'enfant dans cette activité et qui pourraient ne pas marcher dans une autre activité ? Ou est-ce que pour vous c'est un peu un peu pareil au niveau des moyens que vous pouvez mettre en place ?
E2 : Alors au niveau des moyens… Je franchement, je je je ne saurais pas trop oui je pense que j'irai toujours sur la même chose. De toute façon, en en soi, surtout si c'est qu'enfin activités de la vie quotidienne pures, enfin toilette, brossage de dents, etc.
GH : Ok.

E2 : Je pense que je procéderai de la même manière. Donc on va décortiquer la tâche, on va d'abord la travailler avec les pics, etc. Et après mise en situation et puis après en répétition, répétition, répétition et en travaillant le sensoriel. Enfin, pour moi, c'est de toute façon, c'est, je procède comme ça tout le temps en fait.
GH : Ok.
E2 : Pour moi, c'est c'est, ça marche et voilà. Après il y a d'autres, il y a d'autres choses qui marchent tout à fait. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux avec aussi le picto, décortiquer les la la tâche pour les certains enfants, c'est génial quoi.
GH : Très bien. Si maintenant on s'intéresse plus à à aux aller aux toilettes, est-ce que vous voyez ben un moment vraiment qui peut être compliqué ? Est-ce que plutôt enfin ça va être bah de s'asseoir sur les toilettes au niveau encore de ce qui est sensoriel ? Ou autre chose ?
E2 : Les enfants, ils ont peur de tomber. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ils ont peur.
GH : Ok.
E2 : De se faire emmener par les toilettes, c'est vraiment le fait de pas voir ce qui ce qu'ils font, c'est hyper hyper angoissant. Et puis même, on a le voilà, tout ce qui est bah, qui va être faire à la toilette, ça va être hyper compliqué à gérer hein. C'est comme si une partie du corps partait hein, des fois hein c'est horrible hein mais vraiment c'est hyper compliqué. Du coup ils se contiennent, ils se contiennent sauf qu'au bout d'un moment ça arrive à l'hôpital. Voilà pareil pour mon grand hein, il a été combien de fois l'hôpital parce qu'il n'a pas été aux toilettes, parce que si parce que ça c'est vrai que ça reste compliqué. Au niveau du sensoriel… Les enfants qui ne voient pas derrière, ils sont pas capables en fait, pour eux leur leur conception du corps, au proprioceptif y'a pas hein. C'est c'est compliqué pour eux, hein, de savoir qu'il y a quelque chose derrière le le dos ce n'est pas ça existe quoi. Le dos, les, les fesses ça existe, elles sont là, elles sont présentes. Et bah pour certains enfants elles ne sont pas présentes et ils vont pouvoir s'essuyer dans le dos alors qu'il faut s'essuyer les fesses quoi donc…
GH : Ok.
E2 : C'est vrai que c'est hyper compliqué pour eux la gestion du corps, etc. Donc y a un gros travail au niveau proprioceptif à faire aussi, au niveau des de d'aller aux toilettes quoi. Ça pour le coup, il faut travailler bah tout ce qui se passe derrière le corps etc, ressentir le corps, c'est hyper important. Là par contre pour le proprio oui il va falloir bosser absolument là-dessus parce que sinon ça va être hyper compliqué quoi. Il ne va pas, il ne va pas comprendre pourquoi on le fait quoi.
GH : Ok. Ok. Il nous reste 2 soins personnels, donc les difficultés au niveau de l'habillage. Est-ce que là, du coup, les difficultés pour vous ça va être plutôt aussi au niveau texture mais ou au niveau bah aussi coordination pour enlever les habits, mettre les habits, l'ordre etc ?
E2 : Sensoriel. Et puis on a le la gestion, comment je m'organise pour mettre mon vêtement ? J'ai des enfants qui mettent à l'endroit à l'envers alors qu'ils ont 17 ans quoi. Donc c'est vrai que ça va être hyper compliqué pour eux ce genre de choses. Toutes les activités de la vie quotidienne en fait, y a ils ne font pas de liens. Pourquoi je mettrais bah qu'est-ce que ça peut me faire de mettre mon t-shirt à l'envers ? Enfin, il y a aucun problème là-dessus. Alors que si en société on ne peut pas avoir ça à l'envers. Donc ils ont aucune conscience de bah ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est mal quoi. Donc il y a tout ça à retravailler avec eux. Le « Bah non je ne peux pas me déshabiller en public. ». Enfin, il y a tout ça et cette composante là, mais oui, au niveau des coordinations, de motricité fine, motricité globale. S'il n'y a pas le schéma corporel etc. Bah pareil au niveau proprio, bah je la fermeture éclair mais je ne regarde pas ce que je fais, ce n'est pas possible quoi parce que je ne sais pas qu'à tel endroit j'ai une fermeture éclair et je peux l'enclencher donc. C'est vrai que voilà, il y a tout le travail, mais moi, pour moi, de toute façon… enfin je, je je n'arrête pas de parler de sensoriel. Pour moi, l'ergo sans le

sensoriel, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pour moi, ça intervient dans toutes les activités de la vie quotidienne et du coup bah c'est vrai que c'est, c'est difficile de de faire abstraction de ça, hein.
GH : Oui, je suis d'accord.
E2 : Vraiment pas que pour les enfants TSA hein. Donc c'est vrai que j'y reviens tout de temps. Mais tout ce qui est proprio, vestibulaire tactile auditif, ça va être des enfants qui sont stimulés hyper, enfin, les les enfants autistes sont hyper stimulés tout le temps et du coup c'est horrible pour eux. Donc c'est vrai qu'un bruit de fermeture éclair ça ne va pas être possible donc ils vont laisser le manteau ouvert. Enfin, il y a plein de composantes qui sont hyper complexes et qui doivent être prises quand même en compte et dans notre plan de traitement. Voilà qu'on travaille la mise en situation parce que ça ne sert à rien, en fait, parce qu'il ne va pas accepter. Que ça va être encore pire. Il faut accepter, il y a un gros travail quand même à faire sur le sensoriel avant tout ça.
GH : Ok et du coup il nous reste un soin personnel et un un aussi compliqué. Enfin, tout est compliqué mais du coup ce qui va être tout ce qui est bah prise du repas. Donc, est-ce que là pour vous aussi ? Bah quel enfin quel moment ça va être le plus compliqué ?
E2 : Bah c'est des enfants qui utilisent rarement les fourchettes, les couteaux hein. J'ai envie de vous dire des enfants qui mangent, qui ne prennent alors peut-être pas à la main, hein. Je n'avoue peut-être pas quand on a de l'hyper sensibilité tactile, ils ne vont peut-être pas y aller avec la main. Mais c'est vrai que ça, ça utilise sûrement enfin vachement tout ce qui est cuillère, pas fourchette, ils ne piquent pas, ils ne savent pas les retournements au niveau de la manipulation de la main ils ont pas hein. Ça, ça reste très saccadé. Couper la viande, c'est les coordinations des la coordination bi manuelle, il y a il y a très peu, voilà qu'ils en font… Au niveau moteur, ils ont des grosses difficultés, ils n'y mettent pas de sens en plus. Donc c'est vrai qu'en plus souvent, c'est des moments qu'ils détestent parce que bah au niveau sensoriel, on est au summum de la simulation donc c'est des choses où ils vont ils ne vont pas trouver d'intérêt ou ils vont avoir un léger dégout donc bah tout ce qui va être repas va être compliqué. Les coordinations ça va être compliquées, mettre à la bouche etc. Et puis bah tout ce qui va être, tout ce qui est orale, faciale hein ça va être hyper complexe hein de mâcher etc. C'est des gens qui vont, qui vont limite gobet parce que bah au moins ça passe vite et puis c'est tout quoi. Mais voilà, un gros travail aussi à faire là-dessus. Et oui encore le sensoriel encore et toujours et toujours mais mais voilà pour moi c'est c'est ça.
GH : Oui oui.
E2 : Après stimulation autour, hein. Les parents qui vont dire « Aller faut manger faut manger… » stimulation extérieure, l'environnement, bah la télé machin, qui peut être aussi compliqué et qui peut être qui peuvent être aussi parasites. Voilà. Faut faut faut aussi penser à tout ça.
GH : Ok. Ok Ok parfait bah merci beaucoup et il me reste une dernière question. Après je peux vous libérer. Je voulais vous demandez, bah vous avez été formé à différentes bah différentes choses et ce que ces formations enfin, tout ça, est-ce que vous le prenez en compte dans votre pratique lors de vos interventions et si oui, comment vous vous allez pouvoir l'intégrer à vos à vos séances ou des choses comme ça ?
E2 : Alors mes formations, oui, clairement, je les intègre tout à fait à mes séances. Après, encore une fois ça dépend de voilà de de à l'instant T si l'enfant est présent avec moi ou pas ou pas du tout. Après moi, je sais que tout ce que j'ai pu apprendre bah j'ai fait des liens avec ma ma profession avec bah l'ergothérapie. Mettre en application ce que j'ai appris sur mes feuilles et mes cahiers. J'essaye de le mettre en action en séance, bah toujours avec la même chose hein. Essayez de de mettre en place bah avec les parents des pictogrammes pour faire des demandes, etc. Je suis formée PECS, on essaie de travailler là-dessus pour que l'enfant puisse dire bah là, « j'ai envie d'aller aux toilettes ou je je veux

me brosser les dents ou j'ai envie d'aller manger telle chose. ». On essaie de travailler là-dessus. Je les mets en place, bah avec avec tous les jeux que je peux avoir, je ne sais pas si ça peut, ça peut faire des liens avec tout ce que je peux avoir au cabinet. Bah j'essaie de de l'intégrer aux séances. Les Jeux, les, les outils qu'on m'a qu'on m'a donné, les les protocoles de d'intégration sensorielle tout ça. Enfin voilà, tout ça, j'essaie de le mettre. En place en séance. Après, voilà, ça marche, ça marche.

GH : Ok.

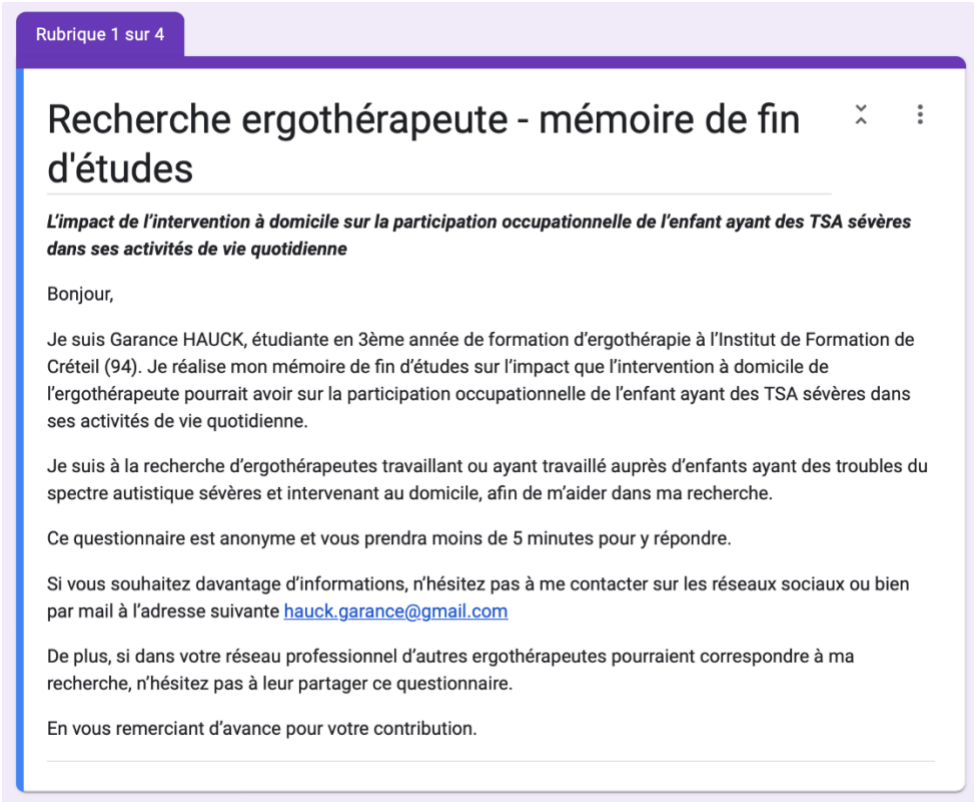
E2 : Après voilà, j'essaye de en tout cas de de mettre en application le plus que j'ai pu apprendre. Je travaille beaucoup tout autour du jeu donc forcément ça va être des jeux, des mises en situation. Enfin voilà, c'est. Ça reste très varié donc. C'est vrai que la question est quand même un peu un peu vaste.

GH : Ok OK, mais c'est parfait pour moi du coup. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou des questions par rapport à tout ça ?

E2 : Non pour moi tout est bon ! Parfait !

GH : D'accord, super. Merci pour le temps que vous m'avez accordé et pour vos réponses.

Annexe 6 : Questionnaire recherche d'ergothérapeute



Rubrique 1 sur 4

Recherche ergothérapeute - mémoire de fin d'études

L'impact de l'intervention à domicile sur la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne

Bonjour,

Je suis Garance HAUCK, étudiante en 3ème année de formation d'ergothérapie à l'Institut de Formation de Créteil (94). Je réalise mon mémoire de fin d'études sur l'impact que l'intervention à domicile de l'ergothérapeute pourrait avoir sur la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne.

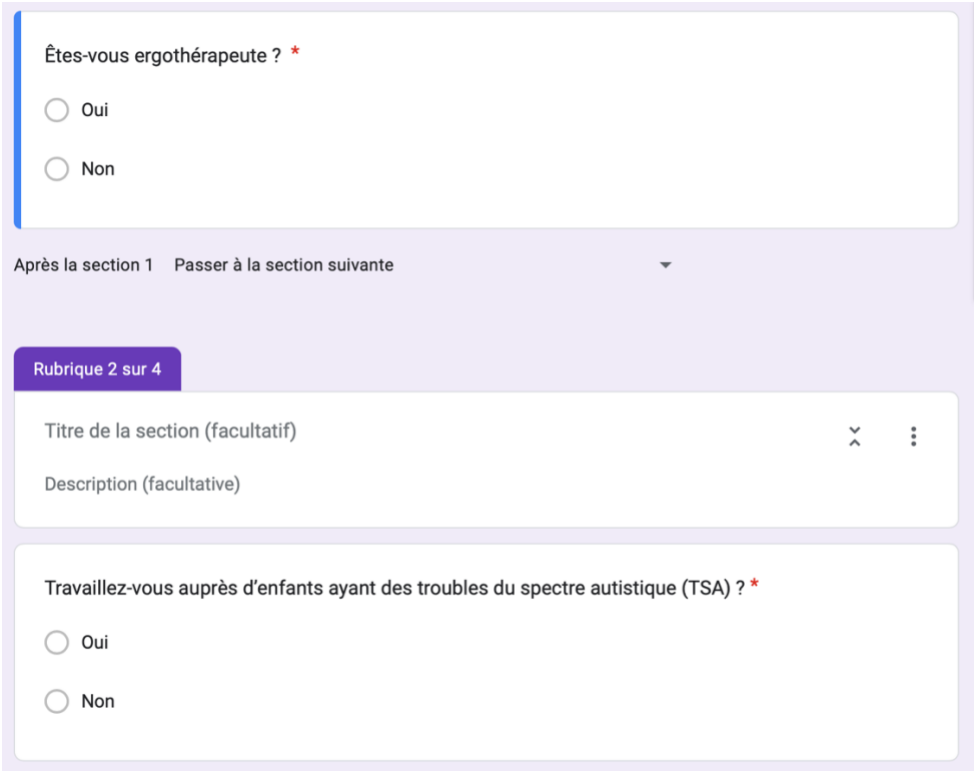
Je suis à la recherche d'ergothérapeutes travaillant ou ayant travaillé auprès d'enfants ayant des troubles du spectre autistique sévères et intervenant au domicile, afin de m'aider dans ma recherche.

Ce questionnaire est anonyme et vous prendra moins de 5 minutes pour y répondre.

Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou bien par mail à l'adresse suivante hauck.garance@gmail.com

De plus, si dans votre réseau professionnel d'autres ergothérapeutes pourraient correspondre à ma recherche, n'hésitez pas à leur partager ce questionnaire.

En vous remerciant d'avance pour votre contribution.



Êtes-vous ergothérapeute ? *

- Oui
- Non

Après la section 1 Passer à la section suivante

Rubrique 2 sur 4

Titre de la section (facultatif)

Description (facultative)

Travaillez-vous auprès d'enfants ayant des troubles du spectre autistique (TSA) ? *

- Oui
- Non

Auprès de quelle tranche d'âge travaillez-vous ? *

- 0 - 6 ans
- 6 - 12 ans
- 12 - 18 ans
- Autre...

Dans quels types d'établissements travaillez-vous ? *

- SESSAD
- IME
- IEM
- Cabinet libéral
- Autre...

Depuis combien de temps travaillez-vous auprès d'enfants ayant des troubles du spectre autistique ? *

Réponse courte

Quel est le degré de sévérité des TSA que vous rencontrez le plus souvent dans votre profession ? *

- Léger
- Modéré
- Sévère

Êtes-vous régulièrement amenés à intervenir au domicile des enfants ayant des TSA que vous accompagnez ? *

- Oui
- Non

Résumé

Introduction : En France, actuellement un enfant sur 100 est concerné par les Troubles du Spectre Autistique (TSA). Une grande majorité des enfants ayant des TSA sévères ont une autonomie qui se développe plus tardivement, qui peut s'expliquer par des difficultés dans les habiletés ainsi que par un profil sensoriel particulier. Cela impact fortement leur participation occupationnelle dans leurs activités de vie quotidienne. L'ergothérapeute est un professionnel de santé, spécialiste de la personne et de l'occupation. Son objectif auprès de la population de ce mémoire est que l'enfant développe une meilleure autonomie dans tous ses lieux de vie.

Méthode : Cette étude explore l'impact de l'intervention de l'ergothérapeute au domicile sur la participation occupationnelle de l'enfant ayant des TSA sévères dans ses activités de vie quotidienne. Pour y répondre, trois entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'ergothérapeutes travaillant auprès de la population de l'étude.

Résultats : La sensibilisation des parents, la mise en place d'aides matérielles ainsi que les adaptations sensorielles permettent à l'enfant ayant des TSA sévères de participer de manière plus active dans ses activités de vie quotidienne à domicile.

Conclusion : Cette enquête permet de valider partiellement l'hypothèse de cette étude de recherche. Cela peut s'expliquer en partie par un faible échantillon de professionnels interrogés.

Mots clés : Trouble du Spectre Autistique – participation – ergothérapie – activités de vie quotidienne – adaptations environnementales

Abstract

Introduction: In France, currently one in 100 children is affected by Autism Spectrum Disorders (ASD). A large majority of children with severe ASD have an autonomy that develops later, which can be explained by difficulties in skills as well as by particular sensory profile. This strongly impacts their occupational participation in their activities of daily living. The occupational therapist is a health professional, specialist of the person and the occupation. Their objective with the population of this dissertation is that the child develops a better autonomy in their different living environments.

Method: This study explores the impact of the occupational therapist's intervention at home on the occupational participation of children with severe autism spectrum disorder in their daily living activities. To answer this question, three semi-structured interviews were conducted with occupational therapists working with the study population.

Results: Raising parents' awareness, setting up material aids and sensory adapations allow children with severe ASD to participate more actively in their daily living activities at home.

Conclusion: This survey partially validates the hypothesis of this research study. This can be partly explained by a small sample of professionals interviewed.

Keywords: Autism Spectrum Disorder – participation – occupational therapy – activities of daily living – environmental adaptations